

Die Lunge/ Der Pulmo

Anamnese

Aktuellen Beschwerden	
1.	Haben Sie Probleme beim Atmen? Beim Ein-oder Ausatmen?
2.	Haben Sie die Beschwerden nur bei Belastung oder auch in Ruhe?
3.	Wie viele Kissen brauchen Sie zum Schlafen?
4.	Haben Sie Husten (mit Auswurf)?
5.	Können Sie den Husten/Auswurf beschreiben? Welche Farbe hat der Auswurf? Ist er gelblich, grünlich oder transparent?
6.	Was ist die Konsistenz des Auswurfs? Ist er eher dünnflüssig, zäh, schleimig oder eitrig?
7.	Haben Sie Schmerzen im Brustkorb? Oder ein Engegefühl? Sind die Schmerzen atemaabhängig?
8.	Haben Sie auch andere Schmerzen, wie Kopf- Bauch- oder Gliederschmerzen?

Diagnostik

allgemeine Beschwerden	-r Husten: trocken, unproduktiv (- r Reizhusten), produktiv -r Auswurf/-sSputum: blutig, eitrig-pürülan(grünlich, gelblich) -s Fieber/-ePyrexie - r Schüttelfrost -e Müdigkeit -e Schwäche/-eAstenie -e atemabhängigen Schmerzen (PL) -e Brustschmerzen (PL) –e Rückenschmerzen (PL) -eAtemnot beim Einatmen/-e inspiratorische Dyspnoe -e Atemnot beim Ausatmen/-e expiratorische Dyspnoe -e Atemnot bei Belastung(Belastungsdyspnoe) I-eAtemnot in Ruhe/-e Ruhedyspnoe Abgeschlagenheit: yorgunluk, güçsüzlük -e Abwehrschwäche: bağısıklığın düşmesi	*e Heiserkeit: ses kısıklığı glasig(şeffaf), zäh(fest) -e Schwäche/-eAstenie Hämoptyse -das Nasenbluten(Epistaxis)
-------------------------------	---	--

9.	Was verbessert oder verschlechtert die Beschwerden?
10	Hatten Sie die Beschwerden früher schon einmal?
11	Wenn Sie Ihre Luftnot auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen müssten – wobei 10 die schlimmste vorstellbare Luftnot ist – wo wären Sie da?
12	Tritt der Husten zu bestimmten Tageszeiten auf?
13	Waren Sie in letzter Zeit öfter heiser?
Vegetative /Vorerkrankungen	
1.	Gibt es denn noch andere Symptome? Schwindel vielleicht?Übelkeit? Herzklopfen?
2.	Haben Sie Bluthochdruck oder ist bei Ihnen eine Herzerkrankung bekannt?

Allergien /Noxen	
1.	Haben Sie Allergien?
2.	Hatten Sie in letzter Zeit Kontakt mit Haustieren?
Familienanamnese/ Sozialanamnese	
1.	Gibt es in Ihrer Familie Atemwegserkrankungen, z.B. Asthma oder chronische Bronchitis?
2.	Was machen Sie beruflich? Wo und wie arbeiten Sie? Sind Sie bei der Arbeit chemischen Stoffen, Stäuben oder Dämpfen ausgesetzt?
Anatomie	
-e Luftröhre -e Trachea - s Zwerchfell -s Diaphragma - s Lungenfell-e Pleura Visceralis - s Rippenfell/Brustfell -e Pleura parietalis - r Pleuraspalt -e Cavitas pleuralis -e Lungenvene / -e Lungenarterie /Lungengefäßen - r obere Lungenlappen, -rMittellappen, -r untere Lungenlappen / Lungenflügel - s Lungenbläschen -e Alveole - rechter/linker Hauptbronchus(Bron. prin.dex/sin.)	

Inspektion

-e Haltung(postür): -r Kutschersitz (öne eğiş oturuş)

-e Atmung: N:-e Eupnoe
P: -e Atemnot,-e Kurzatmigkeit/-e Dyspnoe
-r Einsatz der Atemhilfsmuskulatur: supraclaviculäre und intercostale Einziehungen (PL), -s Nasenflügel

-e Thoraxform: P> -r Faszthorax(fıçı göğüs) -e Trichterbrust/-s Pectus excavatum -e Hühnerbrust/-sPectus carinatum

-e Lippen (PL) : -e Blaufärbung/-e Zyanose, zyanotisch

-e Haut: -e Wasseransammlung/-s Odem, ödematös

-e Nägel (PL): -e Uhrglasnägel (PL), -e Trommelschlägelfinger (PL.)çomak parmak-kronik hipoksi?

-e Gefäße (PL) -e gestauten Jugularvenen

Auswurf

.durchsichtig/weißlich/gräulich: allergie, virus, COPD

.gelb/grünlich: bakterielle Infektion, Virus

.rot(blutig): innere Verletzung, Fremdkörper Bronchitis, bösartiger Tumor, Tuberkulose der Lunge, Lungenembolie

Perkussion: N: sonor **P:** hypersonor/hyposonor

Palpation:

- Thoraxexkursion: symmetrisch / asymmetrisch-eingeschränkt(die Pneumonie, der Pleuraerguss, die Atelektase)
- Vibration: (N): r Fremitus(seitengleich) (P): asymmetrisch, verstärkt, abgeschwächt, aufgehoben(yok, kalkmış) !!kati ise artar, s/g ise azalır zB: „Der Stimmfremitus ist rechts verstärkt.’

Auskultation:

-e Frequenz: (N): -e Eupnoe, eupnoisch (P): -e beschleunigte Atmung/-e Tachypnoe //-e verlangsamte Atmung/-e Bradypnoe

-s Atemgeräusch: (N): -s Vesikulätratmen(periferde) -s Bronchialatmen (über der Trachea und den Hauptbronchien)

(P): -s Atemgeräusch: verstärkt, abgeschwächt, / -s Bronchialatmen in der Peripherie -s Rasselgeräusch:

Feucht: grobblasig(kaba)- mittelblasig(orta)/feinblasig-ince

trocken: -s Giemen, -s Brummen, -s Pfeifen(daralma, zB: Asthma)

-r Stridor: in- o. Expiratorisch (ÜSY daralması)

-e Bronchophonie: verstärkt o. vermindert

Labor

-s Blut: -e Blutgasanalyse, IgE, BNP(Herzinsuffizienz)
-e Entzündungsparameter (PL.) (CRP, BSG, Leukozyten o. Leukos (PL)) –s große Blutbild mit Eosinophilen

>>-r Nasen- Rachen-Abstrich/-r Nasopharyngealabstrich(sürüntü)
>>e Sputumkultur

Apparative Diagnostik

>>>r Röntgen-Thorax (in zwei Ebenen/çift yönlü) >>s CT
>>>r Ultraschall/-eSonografie >>-e Lungen Spiegelung/-eBronchoskopie >>>r Lungenfunktionstest/-e Spirometrie
Wir planen eine Lungenfunktionsprüfung, das nennt sich Spirometrie

Empfehlungen

-r grippale Infekt: Ausruhen, ungesüßten Tee-şekersiz çay, heiße Zitrone mit Ingwer und Honig(sıcak limon zencefil ve bal, boğazı yumuşatır), vitaminreich essen: Obst und Gemüse, Dampfbäder(buhar banyosu)

-eBronchitis: ausruhen, Nikotinkarenz , viel trinken: Kräutertee, Thymiantee(kekik çayı), Salbeitee(ada çayı), Dampfbäder mit Kochsalz(tuzlu buhar banyosu-nemlendirir öksürük azalır, Wadenwickel bei leichtem Fieber baldıra kompres vücut ısını düşürmeye yardımcı)

-s Asthma: Fenchel(Rezene) und Spitzwegerich als Tee oder Sirup erleichtern Atmung(öksürük ve balgamda etkili çay-şurup) Atemübungen, z.B. Lippenbremse-dudak freni: ventilasyonu iyileştirir • regelmäßige Bewegung

Erkrankungen

-e Erkältung –r grippale Infekt -eGrippe/-e Influenza

•-e Bronchitis -eLungenentzündung/-e Pneumonie

•-e COPD (plötzlich Verschlechterung> akute Exazerzabation)
-s Asthma bronchiole

•-e Lungenüberblähung/-s Lungenemphysem(amfizem)

•-e Covid-19-Infektion/ -e SARS-CoV-2-Infektion

•-r Pneumothorax (-rSpontan- o. Spannungspneumothorax)

•-e Lungenfibrose -Atelektase *Schlafapnoe

•-r Pleuraerguss (p.efüzyon) -r Lungenkrebs/-s Bronchial-Ca

*Fremdkörper einatmen(Aspiration) *der Atemstillstand(Apnoe)

Differenzialdiagnosen

-e Herzschwäche/-e Herzinsuffizienz -r Herzinfarkt-rMyokardinfarkt

•-e allergische Reaktion/-e Anaphylaxie

• orthopädische o. äußere Ursachen, z.B. –e Vergiftung/-e Intoxikation

• verschiedene innere Erkrankungen, z.B. –e Anämie -eTuberkulose

Therapie

•-s Hustenmittel/Hustenstiller(-s Antitussivum) –r Schleimlöser -s Mukolytikum (Acetylcystein (ACC))

-s bronchienerweiternde Mittel/-r Bronchodilatator –r Vernebler/-r Inhalator I-sAntibiotikum
-s Kortison/-s Glukokortikoid

•-r Nikotinverzicht -e Flüssigkeitszufuhr(hidrasyon) –e Bettruhe(yatak istirahati)

•-e Sauerstoffgabe(O₂ verilmesi) -e Atemtherapie -e Drainage (göğüs tüpü) -e Pleurapunktion

•-e Entfernung eines Lungenlappens/-e Lobektomie -e Transplantation

- Joint durchziehen, kiffen =Mariuana/Haschisch rauchen
- Qualmen, Kettenraucher sein: sehr viel rauchen. Paffen: dudak tiryakisi
- Ich drehe: Zigaretten selbst machen
- sMarihuana/rJoint/sGras Wasserpeife(eShisha): nargile Zigarre(puro) / sich Heroin spritzen Tabak schnupfen: burundan çekmek

PNEUMONIE

Unter einer Pneumonie versteht man eine akute Entzündung des Lungengewebes, die meistens durch Infektionen verursacht wird. Dabei handelt es sich hauptsächlich um bakterielle, virale oder atypische Erreger. Die Entzündung kann mit einer teilweisen oder vollständigen Infiltration des Lungparenchyms einhergehen.

Als Ursachen einer Pneumonie kommen hauptsächlich bakterielle, virale und atypische Erreger **infrage**. Zu den häufigsten bakteriellen Erregern gehört *Streptococcus pneumoniae*, der für einen großen Teil der ambulant erworbenen Pneumonien verantwortlich ist. Weitere bakterielle Erreger sind *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae* und *Klebsiella pneumoniae*, insbesondere bei älteren Patienten und hospitalisierten Patienten.

Zu den viralen Ursachen zählen vor allem Influenza-Viren, das Respiratory-Syncytial-Virus (RSV) und SARS-CoV-2.

Bei den atypischen Erregern spielen *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae* und *Legionella pneumophila* eine wichtige Rolle, insbesondere bei jüngeren Patienten oder nach speziellen Expositionen.

Zu den wichtigsten Risikofaktoren einer Pneumonie gehören extremes Alter (geriatrische Patienten), chronische Erkrankungen wie COPD, Herzinsuffizienz oder Diabetes mellitus, sowie eine Immunsuppression (z. B. durch Tumorthérapien, HIV). Auch Alkoholmissbrauch, Rauchen (Schädigt die mukoziliäre Clearance und begünstigt Infektionen) und vorausgegangene virale Infektionen können das Risiko erhöhen.

Die Klassifikation einer Pneumonie erfolgt hauptsächlich **nach** dem Erregertyp und **nach** dem radiologischen Befund.

Nach dem Erregertyp unterscheidet man zwischen einer typischen und einer atypischen Pneumonie. Die typische Pneumonie wird meistens durch bakterielle Erreger verursacht, beispielsweise durch *Streptococcus pneumoniae*. Eine atypische Pneumonie wird dagegen häufig durch Mykoplasmen, Viren oder Chlamydien verursacht.

Nach dem Röntgenbefund unterscheidet man zwischen einer Lobärpneumonie, einer Bronchopneumonie und einer interstitiellen Pneumonie. Bei der Lobärpneumonie **finden sich** die Infiltrate auf einen bestimmten Lungenlappen begrenzt, während bei der Bronchopneumonie diffuse, multifokale Infiltrate auftreten. Eine interstitielle Pneumonie betrifft vor allem das Lungeninterstitium und wird häufig durch virale oder atypische Erreger verursacht. (**sich finden = vorhanden sein / festgestellt werden**)

Typische Symptome einer Pneumonie sind hohes Fieber, Schüttelfrost, Krankheitsgefühl, Abgeschlagenheit, Husten, Dyspnoe und pleuritische Thoraxschmerzen. Der Husten kann zunächst trocken und später produktiv mit eitrigem oder blutigem Sputum sein. **Bei der Auskultation können** Rasselgeräusche oder Bronchialatmen **auftreten**. **Zusätzlich können** eine erhöhte Atemfrequenz und eine verminderte Sauerstoffsättigung **festgestellt werden**. **Im Röntgenbild zeigen sich** typischerweise Infiltrate oder Konsolidierungen des Lungengewebes.

Im Röntgen zeigen sich Infiltrate. *'sich zeigen: görülür, saptanır'*

Röntgende infiltratlar görülüyor / saptanıyor.

Bei der Untersuchung zeigen sich keine Auffälligkeiten.

Muayenede herhangi bir anormallik saptanmıyor.

Bei der Auskultation zeigen sich feuchte Rasselgeräusche.

Oskültasyonda yaşı raller saptanıyor.

Im Labor zeigen sich erhöhte Entzündungswerte.

Laboratuvarda yüksek inflamasyon değerleri görülüyor.

Differentialdiagnostisch kommen auch eine akute Bronchitis (keine Infiltrate), eine COPD-Exazerbation (keine neuen Infiltrate), eine Lungenembolie (plötzliche Dyspnoe ohne Fieber), ein Lungenödem bei Herzinsuffizienz (interstitielle Zeichen im Röntgen) und eine Tuberkulose (chronischer Verlauf) **infrage**.

Die Diagnostik umfasst die Anamnese, die körperliche Untersuchung, Laboruntersuchungen und die Bildgebung. **Bei der Auskultation können** Rasselgeräusche oder Bronchialatmen **auffallen**. Das Röntgen-Thorax ist die Standarduntersuchung zum Nachweis von Infiltraten und Konsolidierungen. **Im Labor können** Leukozytose und erhöhte Entzündungswerte wie CRP oder Prokalzitonin **festgestellt werden**. Bei schweren Verläufen erfolgen Blutkulturen, Sputumkultur, PCR Tests (bei Verdacht auf atypische Erreger) und gegebenenfalls eine CT-Thorax oder Bronchoskopie.

Die Therapie einer Pneumonie **besteht aus** einer symptomatischen und einer antibiotischen Behandlung. **Symptomatisch erfolgen** Sauerstoffgabe bei Hypoxie, Flüssigkeitszufuhr und Fiebersenkung. Bei einer ambulant erworbenen Pneumonie **wird** eine empirische Antibiotikatherapie, zum Beispiel mit Amoxicillin/Clavulansäure, **eingeleitet und nach Erregernachweis angepasst**.

Das Herz/ Das Cor

„Das hüpf't manchmal. Mir wird dann auch ein bisschen schwindlig!“

Anamnese

Aktuellen Beschwerden

- Haben Sie Brustschmerzen oder ein Engegefühl in der Brust?
- Haben Sie ein Druckgefühl in der Brust?
- Befinden sich die Schmerzen hinter dem Brustbein oder in der Magengegend? Oder wo genau?
- Seit wann haben Sie die Schmerzen/Beschwerden?
- Haben sie plötzlich oder allmählich begonnen?
- Strahlen die Beschwerden aus? In den linken Arm, in den Bauch, den Unterkiefer oder den Rücken?
- Verändert sich der Schmerz, wenn Sie stehen, sitzen oder liegen?
- Haben Sie bei derartigen Beschwerden schon mal ein Nitro-Spray(Nitropräparat) eingenommen?
- Sind die Beschwerden/ Schmerzen mit der Atmung verbunden? => V.a Perikarditis, Pleuritis, Pneumothorax
- Treten die Beschwerden nur bei Belastung oder auch in Ruhe auf?
- Sind die Beschwerden belastungsabhängig?
- Wie viele Treppen können Sie beschwerdefrei laufen?
- Haben Sie Veränderungen bei Ihrem Herzschlag bemerkt, z.B. Herzrasen oder Herzstolpern? (bei Belastung oder...?)
- Haben Sie Atemprobleme, wenn Sie flach liegen?
- Benutzen Sie mehrere Kissen beim Schlafen? Schlafen Sie mit erhöhtem Oberkörper? => Orthopnoe

- Haben Sie Husten?
- Sind Ihre Beine und Knöchel abends geschwollen?
- Müssen Sie nachts häufiger zur Toilette gehen?
- War Ihnen schwindlig? / Waren Sie ohnmächtig?/ Sind Sie in letzter Zeit ohnmächtig geworden?
- Wird Ihnen manchmal „schwarz vor Augen“?

Vegetative /Vorerkrankungen

- Hatten Sie Schweißausbrüche?
- Fühlen Sie sich in letzter Zeit schwach und abgeschlagen?
- Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck oder erhöhte Blutfettwerte?
- Haben Sie einen Herzschrittmacher? (pacemaker)
- Hatten Sie als Kind einen angeborenen Herzfehler? (konjental kalp hastalıǵı)
- Hatten Sie oft eitrige Mandelentzündungen? (Akutes rheumatisches Fieber?)

Noxen

- Rauchen Sie? Wie viel? Seit wann?

Familienananmnese

- Gibt es in Ihrer Familie Herzerkrankungen, z.B. Herzschwäche oder Infarkte?

Anatomie und Begriffe

-e Lungenvene: -e Vena pulmonalis
-r linke Vorhof: -s Atrium sinister
-e Mitralklappe: -e Valva mitralis
-e linke Herzkammer: -r Ventriculus cordis sinister
-e Aortenklappe: -e Valva aortae
-e Hauptschlagader: -e Aorta
-r Aortenbogen: -r Arcus aortae
-e obere Hohlvene: -e Vena cava superior
-e untere Hohlvene: -e Vena cava inferior
-r rechte Vorhof: -s Atrium dexter
-e Trikuspidalklappe:-e Valva tricuspidalis
-e rechte Herzkammer: -r Ventriculus cordis dexter
-e Pulmonalklappe: -e Valva trunci pulmonalis
-e Lungenarterie: -e Arteria pulmonalis

die Scheidewand → das Septum
der Vorhof → das Atrium
die Kammer → der Ventrikel
der Herzbeutel → das Perikard
die Innenhaut → das Endokard
die Muskelschicht → das Myokard
die Herzkranzgefäße (Plural) → die Koronargefäße
die Anspannung / das Zusammenziehen → die Kontraktion **sich zusammenziehen** → kontrahieren
der Zwischenrippenraum → der Intercostalraum

Diagnostik

allgemeine Beschwerden

*-e Erschöpfung/-e Fatigue(yorgunluk) *-e Schwäche/-e Asthenie (güçsüzlük) *-e Kurzatmigkeit/-e Dyspnoe
*-e Schmerzen (Pl.) im Brustkorb (mit Ausstrahlung in den Rücken, den Unterkiefer, den Arm)
*-s Engegefühl in der Brust o. -e Brustenge/-e Angina pectoris (sıkışma) *-r Schwindel/-e Vertigo
*-s Herzrasen/-e Tachykardie * -s Herzstolpern/-e Palpitationen (Pl.)(düzensizlik, tekleme) * -s Herzstechen (batıcı ağrı)
*-s Schwitzen *-r Schweißausbruch (terleme ataǵı, AKS?) *-e Todesangst (AKS, Panik atak?)
*-e Haut-, Knöchel-, Beinödeme (Pl.) *-e Ohnmacht/-e Synkope
*-e Krampfadern/e Varikose der unteren Extremitäten o. Varikosis

Inspektion

-e Atmung: N:-e Eupnoe
P:-e Atemnot, -e Kurzatmigkeit/-e Dyspnoe
-e Gefäße (Pl.) -r sichtbare Herzspitzenstoß(apikal vurukMG/Sol VHT) -e Pulsation(boyun veya diğer damarlar)
-e Haut, -e Lippen -e Nägel:
-e Blaufärbung/-e Zyanose -e Blässe/-r Pallor
-e Uhrglasnägel (Pl.) -e Trommelschlägelfinger(Pl.)
(Kronik hipoksi, kardiyak-COPD)

Palpation:

>4. - 5. Intercostalraum (ICR), medioklavikular
N:-r Herzspitzenstoß: tastbar
P:-r Herzspitzenstoß: verstärkt
>-r Puls: N: tastbar, rhythmisch
P:abgeschwächt(zayıf, zB KY, şok),
fadenförmig(iplik gibi ince,zayıf zB şok, hipotansiyon),
fehlend(nabız yok, zB:arrest? Arter tıkanıklığı?)
arrhythmisch (zB: Vorhofflimmern/AF)

Auskultation:

-e Herztöne (Pl.) N:-r erste und der zweite Herztön
P:-e Herzrhythmusstörung/-e Arrhythmie
3. und 4. Herztön, -e Spaltung der Töne

-s Herzgeräusch N:rein und rhythmisch
P(üfürüm):-s Systolikum(AS,MY) /-s Diastolikum (MS, AY)
hauchend(üfler gibi yumuşak, regürjitasyonda), gießend(akıcı, dökülür gibi), paukend(tok, davul gibi) lageabhängig (im Sitzen, im Liegen, in Linksseitenlage, beim Vorbeugen)

-e Frequenz -s Herzrasen/-e Tachykardie, tachykard
-r verlangsamte Herzschlag/-e Bradykardie, bradykard

Labor

-s Blut: CRP, BSG, BNP, Glucose, Lipide(PL), Elektrolyte(PL)
Herzenzyme (PL): LDH, Troponin, CK-MB, CK-MM
-e Leber- und Nierenparameter (PL.), ggf. Nüchternblutzucker
• -r Urinstatus

Apparative Diagnostik

>-r Blutdruck,-r Langzeitblutdruck o. -r 24-Stunden-Blutdruck
>-s EKG: -s Ruhe-EKG
-s Belastungs-EKG/-e Ergometrie
-s Langzeit-EKG (Holter)
>-s Herz- Echo/-e Echokardiografie
> -r Röntgen-Thorax (in zwei Ebenen)
> -e Herzkatheteruntersuchung/-e Koronarangiografie

Erkrankungen

• -s akute Koronarsyndrom: -e Brustenge/-e Angina Pectoris
* - e KHK (Koronare Herzkrankheit) * r Herzinfarkt/-r Myokardinfarkt
* - e Herzschwäche/-e Herzinsuffizienz

• -e Herzinnenhautentzündung/-e Endokarditis (Infektiöse (bakterielle) Endokarditis oder Nichtinfektiöse (abakterielle) Endokarditis / Rheumatisches Fieber)

• -e Herzmuskellentzündung/-e Myokarditis

• -e Herzbeutelentzündung/-e Perikarditis

• -e Herzmuskelerkrankung/-e Kardiomyopathie

• -e Verengung/-e Stenose * - r Klappenfehler/-s Vitium

*Herzrhythmusstörungen

*-r Stillstand: arrest –e Arterienverkalkung/-e Arteriosklerose
*mechanische Kontraktionsbehinderungen, z.B. Perikarderguss
*arterielle Hypertonie
*Vorhofseptumdefekt- der atrialer Septumdefekt

Differenzialdiagnosen

-e Lungenerkrankungen (Pl.), z.B - e Lungenarterienembolie * -e COPD *-e Lungenfibrose

• -e Schilddrüsenüber- o. - unterfunktion (mit-)/- e Hyper- o. Hypothyreose

• -e Refluxkrankheit/-e Refluxösophagitis o. - e GERD

• -e Blutarmut/-e Anämie -e Leber-, Gallen-, Nierenerkrankungen (Pl.)

• -e Herzneurose/-e Kardiophobie

• -e Leber-, Gallen-, Nierenerkrankungen (Pl.)

• -e Herzneurose/-e Kardiophobie *akuter Angstanfall/-e Panikattacke

Therapie

• -s Nitrat(Nitroglycerin) *- r Betablocker(Bisoprolol, Metoprolol, Carvedilol, Propranolol)
*- r ACE-Hemmer (Ramipril, Lisinopril, Captopril, Enalapril) *ARB(Valsartan, Candesartan, Losartan, Telmisartan)
*r Calciumkanalblocker(Amlodipin, Nifedipin, Diltiazem) *Diuretika(HCT-Hydrochlorothiazid, Furosemid)
*- e ASS (-s Aspirin) *-r Fettsenker/-r Lipidsenker (Simvastatin, Atorvasitatin, Rosuvastatin) *-s Antibiotikum
*Digoxin-Digitoxin-Amiadoron:antiarritmikler)

• - r Nikotinverzicht * -e mediterrane Ernährung * -e körperliche Bewegung * -e Gewichtsabnahme

• -e Intervention: PCI / - e PTCA (- e Ballondilatation, - e Stentimplantation) • -e OP: -r Bypass

• -e Auflösung des Thrombus/-e Thrombolyse o. - e Lysetherapie

Das Gefäßsystem

Anamnese

Aktuellen Beschwerden - Seit wann haben Sie die Schmerzen/Beschwerden? - Können Sie die Schmerzen beschreiben? - Sollten Sie beim Laufen stehen bleiben und eine Pause machen? - Wie weit können Sie ohne Schmerzen laufen? - Was verbessert die Beschwerden? - Haben Sie die Beschwerden nur bei Bewegung oder auch in Ruhe? - Fühlt sich Ihr Bein heiß/kühl an? Ist es blass oder gerötet? Ist Ihr Bein geschwollen? - Hat sich die Haut in diesem Bereich verändert? (z.B. Haarausfall, Hautverfärbung, Hautschuppung oder brüchige Nägel) - Waren Sie längere Zeit nicht mobil (z.B. nach OP oder Krankheit) - Waren Sie in letzter Zeit länger bettlägerig? Vegetative /Vorerkrankungen/OP/Medikamente - Fühlen Sie sich auch schwach und müde? - Ist bei Ihnen eine Herzerkrankung bekannt? - Wurden Sie kürzlich operiert? - Machen Sie eine Hormonersatztherapie? - Nehmen Sie die Pille? - Nehmen Sie andere hormonelle Verhütungsmittel?	Noxen - Rauchen Sie? Wie viel? Seit wann? - Trinken Sie Alkohol? Wie oft? Wie viel? Reisen/der Beruf - Haben Sie vor kurzem eine längere Reise gemacht, z.B. mit dem Auto oder Flugzeug? - Was machen Sie beruflich? Sitzen Sie viel? Familienanamnese - Gibt es in Ihrer Familie Gefäßerkrankungen? -e Veränderung an der Gefäßwand = -e Endothelschädigung -e verlangsamte Strömungsgeschwindigkeit=-e Hypozirkulation -e erhöhte Gerinnbarkeit= -e Hyperkoagulabilität	Anatomie und Begriffe -e Drosselvene: -e Vena jugularis -e Schlüsselbeinvene: -e Vena subclavia -e obere Hohlvene: -e Vena cava superior -e Pfortader: -e Vena portae -e untere Hohlvene: -e Vena cava inferior -e Beckenvene: -r Vena iliaca -e Rosenvene: -r Vena saphena -e Oberschenkelvene: -e Vena femoralis -e Halsschlagader: -e Arteria carotis -e Schlüsselbeinschlagader: -e Arteria subclavia -r Aortenbogen: -r Arcus aortae -e Bauchschlagader: -e Aorta abdominalis -e Beckenschlagader: -e Arteria iliaca communis -e Oberschenkelschlagader: -e Arteria femoralis
--	---	--

Diagnostik

allgemeine Beschwerden	*-e Schmerzen (PL.) beim Laufen oder (auch) in Ruhe * -s Kältegefühl *-e Überwärmung/-r Calor *-e Hautveränderungen (PL.) * -e Schwellung/-r Tumor *-e Wassereinlagerung/-s Odem *-e Wadenkrämpfe (PL.)
--------------------------------------	---

Inspektion

-r Hals, -r Bauch: -e sichtbaren Pulsationen (PL.)
-e Durchblutungsstörung
-blass, -e Blässe/-r Pallor
-e bläuliche Verfärbung/-e Zyanose, zyanotisch gerötet,
-e Rötung/-r Rubor
-e **Extremitäten (PL)** -e Krampfadern(PL.)/-e Varizen(PL.)
-e Kapillarerweiterungen (PL.)/-e Teleangiectasien (PL.)
-e Venenerweiterungen (PL.)/-e Venektasien (PL.)
-e trophischen Störungen:
-e Pigmentation
-e trockene Haut (-e Pergamenthaut)
-r Haarausfall
-e schlecht heilende Wunde

Palpation:

>-r **Puls:** N: tastbar
P: schwach, nicht tastbar
-r pulsierende Tumor, z.B. -s Aortenaneurysma

Auskultation:

z.B. über der Halsschlagader, über der Bauchaorta, über der Oberschenkelarterie: -s Strömungsgeräusch, -s Schwirren

Eine TVT wird von einem Blutgerinnsel verursacht. Bei der pAVK hingegen liegt die Ursache in einer Verengung durch Arteriosklerose. Während bei der TVT vor allem familiäre Veranlagung, die Einnahme von Hormonen und Übergewicht zu den Risikofaktoren zählen, sind es bei der pAVK hoher Nikotinkonsum, Diabetes und Hypercholesterinämie. Umgangssprachlich ist die Erkrankung als Raucherbein bekannt. Die häufigsten Symptome der TVT sind Schmerzen in Ruhe sowie Rötung, Schwellung ,Überwärmung und Spannungsgefühl der betroffenen Extremität. Im Gegensatz zu einer TVT zeigt sich bei einer pAVK eine kühle, blasse Extremität mit Schmerzen bei Belastung. In einem fortgeschrittenen Stadium verfärbt sich die Haut durch Nekrosen bläulich bis schwarz. Patienten mit einer TVT berichten über eine Verbesserung der Beschwerden durch Hochlagerung und Bewegung, wohingegen die Schmerzen bei pAVK-Patienten durch Pausen beim Laufen gelindert werden (Schaufensterkrankheit o. Claudicatio intermittens). Bei der TVT bestehen schon zu Beginn der Erkrankung Schmerzen in Ruhe. Dahingegen tritt der Ruheschmerz bei der pAVK erst in späteren Stadien auf.

TVT: FM:-s Meyer-Zeichen / -s Payr-Zeichen / -s Homans-Zeichen

- Ursache: Blutgerinnsel in den tiefen Beinvenen durch längere Bettruhe, Bewegungsmangel, Gerinnungsstörung, Gefäßverletzungen, Flüssigkeitsmangel
- Schmerzen und Schwellung treten auf
- Risikofaktoren: > 60 Jahre, familiäre Veranlagung, Herzschwäche, Übergewicht, Antibabypille, Hormonersatztherapie
- Komplikation: Lungenembolie

pAVK: -e Pulslosigkeit/ -e Missempfindung / -r Schmerz / -r Schock / -e Bewegungsunfähigkeit/ -e Blässe

- Ursache: langsame Verengung der Bein- oder Arterien durch Kalk- und Fettablagerungen (Arteriosklerose)
- Extremität wird nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt
- Risikofaktoren: Nikotin, Diabetes, Hypercholesterinämie, Hypertonie
- Symptome: Schmerzen bei Belastung (später auch in Ruhe), kalte, blasser Haut, schlecht heilende Wunden
- Pausen beim Gehen verbessern die Beschwerden (-e Schaufensterkrankheit/-e Claudicatio intermittens)

Labor

-s Blut: CRP, Gesamtcholesterin (HDL/LDL), Elektrolyte (Pl.), -s Blutbild -e Gerinnungsparameter (PL.), z.B. Quick , PTT, D-Dimere
• - r Urinstatus, Glucose im Serum und im Urin

Apparative Diagnostik

- r Doppler-Ultraschall/-e **Doppler-Sonografie**
- - r Duplex-Ultraschall/-e **Duplex-Sonografie**
- ggf. -e radiologische Gefäßuntersuchung/-e **Angiografie**

Therapie

- **- r Blutverdünner:**
 - 1)Thrombozytenaggregationshemmer(Plättchenhemmer): -e Acetylsalicylsäure(ASS), Clopidogrel, Prasugrel
 - 2) -s Antikoagulans(-r Gerinnungshemmer) : **Oral**> Vitamin K-Antagonisten(Cumarine) und Direkt OAK: Apixaban, Rivaroxaban, Thrombinhemmer: Dabigatran
- IV> Unfraktioniertes Heparin und Niedermolekulares Heparin:** Enoxaparin(Clexane), Dalteparin
- **-s Thrombolytikum**
- -r **ACE-Hemmer**(Ramipril,Captopril), -r **Betablocker**(Bisoprolol, Metoprolol, Carvedilol)
- -e Hochlagerung der Beine, Wärme vermeiden (bei TVT)
- -s Gehtraining (bei unkomplizierter pAVK)
- Gummistrumpf(Kompressionsstrumpf)/Varis corabi, -e Venenentfernung/-s Venenstripping (Veni uzaklaştırma,Variste) -e Verödung/-e Sklerosierung (Damar kurutma: Varis ve Hemoroidde)
- -e Alkohol- und Nikotinkarenz
- -e Gewichtsreduktion I -e Ernährungsumstellung I -e Bewegung
- -e Intervention(Girişimsel): -e PTA (-e Ballondilatation, -e Stentimplantation)
- e Entfernung des Gerinnsels/-e Thrombektomie, z.B. mit dem Fogarty-Katheter(balon kateter, pıhtıyı çıkarmada)
- -e OP: -r Bypass

Erkrankungen

- e Arterienverkalkung/-e Arteriosklerose I -e Brustenge/-e Angina pectoris
- -r Gefäßverschluss/-e Thrombose/-e Embolie I -e (periphere) arterielle Verschlusskrankheit (-e AVK/pAVIO)
- -e Krampfadern/-e Varizen
- -e Venenentzündung/-e Phlebitis, -e Thrombophlebitis
- -e tiefe Venenthrombose (-e 71/1)/-e Phlebothrombose
- -s Beingeschwür/-s Ulcus cruris

Differenzialdiagnosen

- -r Ischiasschmerz/-e Ischialgie I - r Gelenkverschleiß/-e Arthrose I
- e Gelenkentzündung/-e Arthritis
- -r Bandscheibenvorfall/-r Diskusprolaps I -e Bandscheibenvorwölbung/-e Diskus protrusion
- -e Wundrose/-s Erysipel I -e Bindegewesentzündung/-e Phlegmone I
- e Entzündung der Lederhaut und des Unterhautfettgewebes/-e Zellulitis
- -e kardiologischen Erkrankungen (PL.)

Ulcus Cruris

Unter einem Ulkus versteht man eine offene Wunde am Unterschenkel, meist im Bereich der Innen- oder Außenseite. Es entsteht häufig im Zusammenhang mit venösen oder arteriellen Durchblutungsstörungen.

Die Klassifikation erfolgt nach der Pathophysiologie in ein venös bedingtes Ulkus bei chronischer venöser Insuffizienz (CVI), ein arteriell bedingtes Ulkus aufgrund einer ischämischen Ursache sowie ein diabetisches und neuropathisches Ulkus.

Als Ätiologie eines venös bedingten Ulkus kann man eine chronische venöse Insuffizienz (CVI) und eine Varikosis nennen. Bei einem arteriell bedingten Ulcus cruris kann man hingegen eine pAVK als Ursache nennen. Außerdem kann Diabetes mellitus zu Mikrozirkulationsstörungen führen.

Als Risikofaktoren kann man höheres Alter, Adipositas (begünstigt durch venöse Stauung und Insuffizienz), Bewegungsmangel (führt zu einer verminderten venösen Rückstromfunktion), chronische venöse Insuffizienz als häufige Ursache, Arteriosklerose, Rauchen sowie Diabetes mellitus nennen.

Wundstadien: Frühstadium: Rötung, leichte Hautveränderungen, Beginn der ulcerativen Läsion
/Fortgeschrittenes Stadium: nekrotisches Gewebe /Spätstadium: chronische Wunde.

Die typischen Symptome eines Ulcus cruris sind Schmerzen, lokale Wundveränderungen, Infektionszeichen und eine eingeschränkte Mobilität.

Arterielle Ulzera verursachen häufig starke, stechende Schmerzen, die sich in Ruhe verstärken können. Venöse Ulzera sind oft weniger schmerzhaft, können aber bei Infektion oder Entzündung schmerzhafter werden. Typische Lokalbefunde sind ein unregelmäßiger Ulkusrand, Exsudation, Rötung der Wundumgebung sowie mögliche Zeichen einer Infektion. Häufig treten auch Ödeme und Varikosen auf.

Differentialdiagnostisch kommen auch ein Pyoderma gangraenosum (schneller Verlauf, ausgeprägte Entzündung, häufig assoziiert mit systemischen Erkrankungen wie entzündlichen Darmerkrankungen), arterielle Ulzera (starke Schmerzen, abgeschwächte Pulse bei der Palpation, kalte Extremitäten) und diabetische Fußulzera (weitere diabetische Komplikationen sowie das Fehlen von Varikosen und Ödemen) infrage.

Die Diagnostik umfasst die Anamnese mit relevanten Vorerkrankungen wie CVI, Varizen, pAVK und Diabetes mellitus sowie Risikofaktoren wie Rauchen und Bewegungsmangel. Die körperliche Untersuchung erfolgt im Seitenvergleich mit Hautinspektion, Beurteilung von Ödemen, Varizen, Pulsen und Hauttemperatur. Ergänzend werden Laboruntersuchungen, Wundabstriche mit ggf. Antibiotogramm, Duplexsonographie und bei Bedarf CT-/MR-Angiographie durchgeführt.

Die Therapie umfasst konservative, medikamentöse sowie interventionelle Maßnahmen.

Konservativ erfolgen ein regelmäßiges Wundmanagement mit Reinigung, Debridement und Verbandwechsel sowie eine Druckentlastung. Bei venösen Ulzera wird eine Kompressionstherapie eingesetzt, bei arteriellen Ulzera ist sie kontraindiziert.

Medikamentös kommen lokale Antiseptika, bei Infektionen Antibiotika sowie eine adäquate Schmerztherapie zum Einsatz.

Operativ kommen je nach Ursache eine Revaskularisation, eine venöse Intervention oder eine Hauttransplantation infrage.

Anamnese

<u>Aktuellen Beschwerden</u> 1. Wo genau haben Sie die Schmerzen? 2. Können Sie die Schmerzen beschreiben? Strahlen sie aus? 3. Sind die Schmerzen dauerhaft oder kommen und gehen sie? 4. Haben Sie etwas ausprobiert, um die Schmerzen zu lindern? 5. Haben Sie erbrochen? 6. Hängt die Übelkeit oder die Schmerzen mit dem Essen zusammen? 7. Haben Sie ähnliche Beschwerden früher gehabt? <u>Ernährung</u> 1. Wie sind Ihre Essgewohnheiten? 2. Was essen Sie normalerweise täglich?		<u>Vegetative</u> 1. Haben Sie Fieber? 2. Fühlen Sie sich schwach? 3. Ist Ihnen oft schlecht? 4. Wie ist Ihr Appetit? 5. Haben Sie ab- oder zugenommen? 6. Hat sich die Farbe Ihres Stuhls oder Urins verändert? 7. Schlafen Sie gut? <u>Medikamente/Impfungen</u> 1. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente? Was? Wie oft? Warum? 2. Sind Sie gegen Hepatitis geimpft?		<u>Noxen</u> 1. Trinken Sie Alkohol? Was, wie viel und wie oft? <u>Familienananmnese/ Sozialanamnese/Reisen</u> 1. Gibt es in Ihrer Familie Lebererkrankungen? 2. Gibt oder gab es in Ihrem Umkreis ähnliche Beschwerden? 3. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Wo waren Sie?	
<u>allgemeine Beschwerden</u> *-e Schmerzen (Pl.) im rechten Oberbauch/im rechten Epigastrium *-e Übelkeit/-e Nausea *-s Erbrechen/-e Emesis *-e Schwäche/-e Asthenie *-r Juckreiz/r Pruritus *-e Appetitlosigkeit/-e Inappetenz *-r Blähbauch/-r Meteorismus *-r Abgang von Blähungen (Pl.)/-e Flatulenz Leber: -s Druckgefühl im rechten Oberbauch Gallenblase: -e kolikartigen Schmerzen (Pl.) -e Ausstrahlung zwischen die Schulterblätter/in die rechte Schulter , postprandielle kolikartige Schmerzen					
<u>Inspektion</u> <u>-e Haut:</u>-e Leberhautzeichen (Pl.): *-e Gelbsucht/-r Ikterus *-e Einblutungen (Pl.)/-e Petechien (Pl.) *-e geröteten Handflächen (Pl.)/-s Palmarerythem <u>-e Skleren:</u> *-e Gelbfärbung der Lederhäute (Pl.)/-r Sklerenikterus, <u>-e Mund</u> > -e Lackzunge/-e Lingua glabra (parlak dil) <u>-r Bauch</u>> -r Wasserbauch o. -e Bauchwassersucht/ -r Aszites <u>-e Gefäße (Pl.)</u> -e Gefäßerweiterungen (Pl.)/-e Teleangiektasien (Pl.) -e Spider naevi (Pl.) -s Medusenhaupt/-s Caput Medusae		<u>Perkussion:</u> N: -e Leberdämpfung P: *-e Lebervergrößerung/-e Hepatomegalie *-r Klopfschmerz über der Gallenblasenregion und dem rechten unteren Rippenbogen <u>Palpation:</u> -e Abwehrspannung (defans) -e Größe: N: tastbar P:verkleinert, vergrößert (-e Hepatomegalie) -e Oberfläche: N: weich, glatt /-r Leberrand(KC kenarı): scharf begrenzt P: derb(rijit) *höckerig(pürüzlü) *knotig(nodüler) *verhärtet(sertleşmiş) /-r Leberrand: abgerundet(küntleşmiş) -e Konsistenz: N> weich P>teigig (-e Fettleber) hart (-r Tumor, -e Zirrhose) unter dem rechten Rippenbogen auf der Medioclavikularlinie (MCL): *-s positive Murphy-Zeichen -*s positive Courvoisier-Zeichen <u>Auskultation:</u> -e Kratzauskultation N:-s (laute) Geräusch über der Leber -s Abdomen: P>-e vermehrte Peristaltik		<u>Anatomie</u> -r rechte Leberlappen/ -r Lobus hepatis dexter -r linke Leberlappen /-r Lobus hepatis sinister -s Leberband/ -s Ligamentum falciforme hepatis -e Leberarterie /-e Arteria hepatica -e Pfortader /-e Vena portae -r Lebergang/-r Ductus hepaticus -e Gallenblase /-e Cholezyste o. Vesica fellea/biliaris -r Gallenblasengang/-r Ductus cysticus -r Gallenhauptgang/ -r Ductus choledochus	
		<u>Labor</u> * -s Blut: Leukos (Pl.) *CRP *GOT/AST *GPT/ALT *LDH *GGT *AP *direktes und indirektes Bilirubin *Gesamtcholesterin * LDL *Globulin *Albumin -e Gerinnungsparameter (Pl.), z.B. PTT * Quick(PT) -e Hepatitisserologie <u>Apparative Diagnostik</u> - r Ultraschall/-e Sonografie -e FibroScan-Diagnostik (-e transiente Elastographie): fibrosis düzeyini ölçer [Kr. Hepatitis, Zirrhose, Fettleber] -e ERCP *-e MRCP			
<u>Befunde-Erkrankungen</u> Fettleber: vergrößert/ teigig Hepatitis: weich / teigig/ vergrößert Leberzirrhose: verkleinert / verhärtet Tumoren: vergrößert/ hart/ höckerig/ knotig		<u>Murphy-Zeichen:</u> Es ist ein klinisches Zeichen, das auf eine akute Cholezystitis (Gallenblasenentzündung) hinweist. Der Patient liegt in Rückenlage. Der Arzt drückt tief unterhalb des rechten Rippenbogens in der medioklavikulären Linie (MCL). Der Patient soll dabei tief einatmen. Wenn die Gallenblase entzündet ist, entstehen starke Schmerzen beim Einatmen. Der Patient stoppt die Einatmung plötzlich wegen der Schmerzen. Positives Murphy-Zeichen = Schmerzbedingter Atemstopp beim tiefen Einatmen → Hinweis auf Cholezystitis <u>Courvoisier-Zeichen</u> :Es ist ein Hinweis auf eine Galle-Abflussstörung (Cholestase). Der Patient liegt in Rückenlage. Unterhalb des rechten Rippenbogens in der MCL wird getastet. Man kann eine vergrößerte, prall-elastische Gallenblase fühlen. Wichtig: Dabei hat der Patient meist keine Schmerzen. Positives Zeichen = tastbare, prall gefüllte Gallenblase ohne Schmerz △Wichtiger Hinweis (Cave): Besonders verdächtig auf ein Pankreaskopfkarzinom Kurz gesagt: Große, gefüllte Gallenblase + keine Schmerzen → denkt an Tumor (v. a. Pankreaskopfkarzinom)			
<u>Erkrankungen</u> <u>Leber</u> -e Leberentzündung/-e Hepatitis -e Fettleber/-e Steatosis hepatis -e Schrumpfleber/-e Leberzirrhose [schrumpfen: küçültmek] *-e Leberfibrose *-r Leberkrebs/-s Leber-Ca <u>Gallenblase</u> -e Gallenblasenentzündung/-e Cholezystitis -e Entzündung der Gallengänge/-e Cholangitis -e Gallensteine (Pl.)/-e Cholelithiasis / Cholezystolithiasis/ Choledocholithiasis -e Gallenstauung/-e Cholestase <u>Differenzialdiagnosen</u> <u>Leber</u> -e Magenschleimhautentzündung/-e Gastritis *-s Magengeschwür/-s Ulkus ventrikuli -e Gallenblasenentzündung/-e Cholezystitis - r Bauchspeicheldrüsenkopfkrebs/-s Pankreaskopf-Ca -e Rechtsherzschwäche/-e Rechtsherzinsuffizienz <u>Gallenblase</u> -e Magenschleimhautentzündung/-e Gastritis *-s Magengeschwür/-s Ulkus ventrikuli -e Leberentzündung/-e Hepatitis -e Bauchspeicheldrüsenentzündung/-e Pankreatitis <u>die Cholezystitis:</u> Risikofaktor = Gallensteinleiden. //Verschluss des Gallengangs durch Steine //aufsteigende Bakterien aus dem Darm/selten durch Polytrauma, DM <u>die Cholelithiasis:</u> Risikofaktor = hohe Blutfettwerte //,, 6F" (weiblich, übergewichtig, fruchtbar, über 40, blond, familiäre Veranlagung)//Gallenflüssigkeit verändert// Bildung von Steinen <u>die Leberzirrhose:</u> Alkoholmissbrauch, Übergewicht (Fettleber)//narbige Schrumpfung durch dauernde Entzündung der Leber (Hepatitis B oder C)//selten durch Autoimmunerkrankungen oder Gallenwegsentzündung <u>Therapie</u> <u>Leber</u> -e Ernährungsumstellung -e Alkoholkarenz I - e Gewichtsabnahme -s Virostatikum -s Immunglobulin -e Lebertransplantation <u>Gallenblase</u> „stumme" Steine[sessiz] = keine Behandlung -e (Null-) Diät [oral stop] -s krampflösende Mittel/-s Spasmolytikum *-s Schmerzmittel/-s Analgetikum -e Entfernung der Gallenblase/-e Cholezystektomie					

Die Bauchspeicheldrüse und die Milz (Das Pankreas & der Splen o. Der Lien)

Anamnese

Aktuellen Beschwerden 1. Wo genau haben Sie die Schmerzen? Strahlen sie aus? 2. Können Sie die Schmerzen beschreiben? 3. Sind die Schmerzen gürtelförmig? 4. Ist Ihnen oft übel? 5. Ist die Übelkeit mit dem Essen verbunden? 6. Haben Sie erbrochen? Vorerkrankungen/ Medikamente 1. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? 2. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente? Was? Wie oft? Warum?	Vegetative 1. Haben Sie Fieber? 2. Leiden Sie unter Müdigkeit und Abgeschlagenheit? 3. Haben Sie mehr Durst als gewöhnlich? 4. Wie ist Ihr Appetit? 5. Haben Sie in letzter Zeit abgenommen? 6. Haben Sie Verdauungsprobleme? 7. Gehen Sie öfter zur Toilette? 8. Hat sich Farbe oder Konsistenz Ihres Stuhls verändert? die Ernährung- Noxen 1. Wie sind Ihre Essgewohnheiten? 2. Was essen Sie normalerweise täglich? 3. Trinken Sie Alkohol? Was, wie viel und wie oft?	-r Unfall/das Trauma 1. Hatten Sie einen Unfall? -r Sicherheitsgurt: emniyet kemeri(den Sicherheitsgurt anlegen) Prellung(ezilme), Hämatom, Schürfwunde(sıyrık) Verdacht auf Fraktur, keine Bewusstlosigkeit Schutzausrüstung für Radfahren-Protektoren: -r Helm: kask -r Knieschoner:dizlik -rEllenbogenschoner: dirseklik Beim Radfahren ist er gestürzt. Er trug keinen Helm. Er hatte einen Helm auf. Schutzausrüstung war nicht vorhanden. Familienananmnese/ Reisen 1. Gibt es in Ihrer Familie Krebserkrankungen? 2. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Wo waren Sie?
--	--	---

allgemeine Beschwerden	Bauchspeicheldrüse: -e diffusen bzw. gürtelförmigen Oberbauchschmerzen (Pl.) -e Ausstrahlung in den Rücken -e Abneigung(tiksinme) gegen fettes Essen -e Übelkeit/-e Nausea -s Erbrechen/-e Emesis -r Blähbauch/-r Meteorismus * -e Blähungen (Pl.)/-e Flatulenz[gaz çıkarma] -e Appetitlosigkeit/-e Inappetenz * -r Fettstuhl/-e Steatorrhoe Milz: [Ich hatte einen Unfall!] [Ich bin gegen das Lenkrad gestoßen.] -e Schwäche/-eAsthenie I -e Kopfschmerzen (Pl.)/-e Cephalgie * -e Leistungsminderung -e Überempfindlichkeit der Haut/-e Hyperästhesie -e Schmerzen (Pl.) im Oberbauch und in der linken Schulter	Alkohol 1)-s Bier (normal Helles oder Weißbier) 5% Bockbier (stark bier) 8% Eine Halbe (1 Fl. Bier) Eine Maß (1 Liter Bier) 2)-r Wein Wein, Sekt(Alman köpüklü şarabı), Prosecco(İtalyan köpüklü şarabı 11-13% 3) -r Cocktail ca. 20-30 Vol.-% 4) -r Likör ca. 15-40 Vol.-% 5) -e Spirituose ≥ 40 Vol.-% 6) Schnaps: sert içkiler 35-40% (der Kurzen=Schnaps) Whiskey, Tequila, Gin, Wodka, Cognac, Rum 7)Jägermeister 35% (kleine grüne flasche sehr bekannt in Deutschland, bir çeşit likör) 8) Aperol Spritz: %8–11 (Soda+Aperol+Prosecco) Anstoßen: kadeh tokuşturmak /Anlässen: özel günler
Inspektion Bauchspeicheldrüse bei biliärer Pankreatitis: -e Haut und -e Skleren: :- -e Gelbsucht/-r Ikterus -e Gelbfärbung der Lederhäute (Pl.)/-r Sklerenikterus, Milz -e Blässe/-r Pallor, -e blassen Bindehäute (Pl.) [konjonktivalar] und Schleimhäute [mukoazalar] (Pl.) -e Gelbsucht/-r Ikterus	Palpation: Bauchspeicheldrüse -s positive Courvoisier-Zeichen -e Abwehrspannung(defans) -r Gummibauch(A.Pankreatit'te) Milz Tastbar(pathologisch) Auskultation: -s Abdomen: P>-e vermehrte Peristaltik	
Grey-Turner-Zeichen (Flanke) Hinweis auf eine Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung). Man sieht blau-grünliche Flecken (Ekchymosen) an den Flanken Ursache: Blutansammlung im Retroperitoneum. Häufig links sichtbar Kurz: Blut im Retroperitoneum → blaue Flecken an der Flanke → Grey-Turner-Zeichen Cullen-Zeichen(Nabel) Ebenfalls Hinweis auf innere Blutung (z. B. bei Pankreatitis). Ekchymosen um den Bauchnabel (periumbilikal) Kurz: Blaue Flecken um den Nabel → Cullen-Zeichen Kehr-Zeichen Hinweis auf Milzruptur oder Milzinfarkt. Patient hat Schmerzen in der linken Schulter. Zusätzlich kann eine Überempfindlichkeit der Haut (Hyperästhesie) bestehen Kurz: Milzproblem → Reizung des Zwerchfells → Schmerz in der linken Schulter = Kehr-Zeichen	Anatomie -e Gallenblase: -e <i>Cholezyste</i> o. -e <i>Vesica fellea/biliaris</i> -r Gallenblasengang:-r <i>Ductus cysticus</i> -r Gallenhauptgang: -r <i>Ductus choledochus</i> -r Zwölffingerdarm:-s <i>Duodenum</i> -r Bauchspeicheldrüsenkopf:-s <i>Caput pancreatis</i> -r Bauchspeicheldrüsenkörper: -r <i>Corpus pancreatis</i> -r Bauchspeicheldrüsenschwanz: -e <i>Cauda pancreatis</i> -r Bauchspeicheldrüsenangang:-r <i>Ductus pancreaticus</i> -e untere Hohlvene: -e <i>Vena cava inferior</i> -e Milzkapsel: -e <i>Capsula fibrosa splenis</i> -e Milzarterie:-e <i>Arteria lienalis</i> -e Milzvene:-e <i>Vena lienalis</i>	

Erkrankungen Bauchspeicheldrüse • -e Bauchspeicheldrüsenentzündung/-e Pankreatitis • -r Bauchspeicheldrüsenkrebs/-s Pankreas-Ca • -e Zuckerkrankheit/-r Diabetes Mellitus Milz • -r Milzriss/-e Milzruptur *-r Milzinfarkt • -e Milzschwellung/-e Splenomegalie Differenzialdiagnosen Bauchspeicheldrüse • -e Magenschleimhautentzündung/-e Gastritis *-s Magengeschwür/-s Ulkus ventriculi *-s Zwölffingerdarmgeschwür/-s Ulkus duodeni • -e Leberentzündung/-e Hepatitis • -e Gallenblasenentzündung/-e Cholezystitis Milz • bei Milzschwellung/Splenomegalie: Abklärung der zugrundeliegenden Erkrankung, z.B. Infektionen *-e portale Hypertension *-e Rechtsherzinsuffizienz u.a.	Therapie Bauchspeicheldrüse • -e Alkoholabstinenz • -e Ernährungsumstellung (kleine Portionen, fett- und kohlenhydratarm) • -e Lipase-Substitution(Kreon) *-s Schmerzmittel • -e Gallengang- Erweiterung mittels ERCP • -e Whipple- OP Milz • -e Behandlung der Grunderkrankung • -e Entfernung der Milz/-e Splenektomie • -e Bluttransfusion Die akute Pankreatitis kann durch Gallensteine, Alkohol, Steroide, Mumps, Autoimmunerkrankungen oder Traumata verursacht werden. Bei der körperlichen Untersuchung können ein Gummibauch, das Grey-Turner-Zeichen oder das Cullen-Zeichen auffallen. Die Patientin / der Patient sollte stationär aufgenommen werden, meistens für mindestens 3–4 Tage. Wichtig sind eine ausreichende Volumen- und Elektrolytsubstitution sowie zunächst eine Nulldiät. Später empfiehlt man kleine Portionen und Schonkost. Außerdem ist eine konsequente Alkoholabstinenz notwendig. Zur Schmerztherapie können NSAR oder PethidinOpioid-Schmerzmittel)eingesetzt werden. Bei Verdacht auf einen schweren Verlauf kann ggf. eine Antibiotikaprophylaxe erfolgen. Die chronische Pankreatitis ist eine progrediente Entzündung der Bauchspeicheldrüse und führt häufig zu Diarrhö, Steatorrhoe und Bauchschmerzen. Im Spätstadium kann sich ein Diabetes mellitus (DM) entwickeln. Die Diagnostik erfolgt u. a. mittels Ultraschall (USG) sowie durch die Bestimmung der Elastase im Stuhl. Therapeutisch steht die Ernährungsumstellung im Vordergrund: kleine, häufige Mahlzeiten sowie eine fett- und kohlenhydratreduzierte Kost. Außerdem ist eine konsequente Alkoholabstinenz notwendig. Zur symptomatischen Therapie werden Analgetika und Pankreasenzyme (z. B. Lipase / Kreon 3× täglich) eingesetzt. Zusätzlich können Vitamine (A, D, E, K) substituiert werden, ggf. auch intravenös. Bei Entwicklung eines Diabetes ist eine Insulintherapie erforderlich.	Labor Bauchspeicheldrüse: -s Blut: -e Bauchspeicheldrüsenenzym (PL.)[Amilase, Lipase],Kalzium,AP !Ca yüksekliği sebep olabilir. Prognozda da önemli bir göstergedir. -e Leberwerte (PL.): GOT/AST *GPT/ALT *GGT -e Stuhluntersuchung> Elastase Milz: -s Blutbild, -r Blutaussstrich[periferik yayma] Apparative Diagnostik • -r Ultraschall/-e Sonografie • -e ERCP • -s CT *-s MRT
--	---	--

Der Magen/Der Gaster o. der Ventriculus

Anamnese

Aktuellen Beschwerden 1. Haben Sie Schmerzen beim Schlucken? (<i>Ösophagus</i>) 2. Haben Sie Schluckbeschwerden <i>bei fester oder flüssiger</i> Nahrung? (<i>Ösophagus</i>) 3. Wo genau haben Sie die Schmerzen? 4. Wann treten die Schmerzen auf? Vor oder nach dem Essen? 5. Haben Sie erbrochen? 6. Wie sieht das Erbrochene aus? (<i>gallig, schleimig, blutig?</i>) 7. Haben Sie Sodbrennen? 8. Haben Sie Blähungen? 9. Fühlen Sie sich voll und aufgebläht? (<i>Meteorismus</i>) 10. Müssen Sie oft aufstoßen? (<i>Regurgitation</i>) 11. Hängen die Beschwerden mit dem Essen zusammen?	Vegetative 1. Ist Ihnen schlecht? 2. Wie ist Ihr Appetit? 3. Haben Sie ungewollt abgenommen? Vorgeschichte /-e Medikamente/-r Stress 1. Wann hatten Sie die letzte Magenspiegelung? -Was war das Ergebnis? 2. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente? Was? Wie oft? Warum? 3. Fühlen Sie sich gestresst?	die Ernährung- Noxen 1. Was essen Sie normalerweise täglich? 2. Essen Sie oft stark gewürzte Speisen? 3. Rauchen Sie? Wie viel? Seit wann? 4. Trinken Sie Alkohol? Was? Wie viel? Wie oft? 5. Trinken Sie viel Kaffee? Wie viel? Familienananmnese 1. Gibt es in Ihrer Familie Krebserkrankungen?
---	--	--

Diagnostik

allgemeine Beschwerden -e Schmerzen (Pl.) im Oberbauch/im Epigastrium I -e Schwäche/-eAsthenie -e Übelkeit/-e Nausea I- s Erbrechen/-e Emesis I- s Bluterbrechen/-e Hämatemesis -s Kaffeesatzerbrechen I –s Magenknurren(mide gurultusu) I -r NüchternschmerzZ(açlık karın ağrısı) -e Appetitlosigkeit/-e Inappetenz I -e Abneigung gegen bestimmte Speisen -s Druck- und Völlegefühl I -s Sodbrennen I Rückfluss/-r Reflux I- s Aufstoßen/-r Ructus -e Blähungen (Pl.)/Meteorismus I –r Windabgang(<i>gaz çıkarma</i>)/-e Flatulenz I -e Gewichtsabnahme	Inspektion -s Abdomen:-e Vorwölbung(<i>şişlik</i>), vorgewölbt Perkussion N: tympanisch o. tympanitisch, P: -e Dämpfung, gedämpft/hyposonor <i>Ekstra:</i> <i>Bruch: 1) frakturte 2) hernie.</i> <i>der Loslassschmerz: rebound</i> <i>der Klopfschmerz: KVAH</i>	Palpation: -e Abwehrspannung(<i>defans</i>) I -r Druckschmerz -e Bruchpforte(<i>fıtık açığı</i>) I -e Schwellung/-r Tumor -r Virchow-Lymphknoten (<i>sol supraklaviküler lenf nodu-MagenCA?</i>) Auskultation: Patho>-e erhöhte, verstärkte, gesteigerte Darmbewegung / -e Hyperperistaltik	Anatomie -e Speiseröhre:-r Ösophagus -s Zwerchfell:-s Diaphragma -r Mageneingang:-e Cardia -s Magengewölbe:-r Fundus gastricus -r Magenkörper:-r Corpus ventriculi -r Pylorusvorhof:-s Antrum pyloricum -r Magenpfortner:-r Pylorus -r Zwölffingerdarm:-s Duodenum -e längs gestreifte Muskulatur: -s Stratum longitudinale -e ringförmige Muskulatur:-s Stratum circulare -r schräge Muskulatur:-e Fibrae obliquae -e Gallenblase:-e Cholezyste
Labor -s Blut: Hb I Leukos (Pl.) I Eisen- und B12-Werte (Pl.) I Gerinnungsparameter (Pl.), z.B. PTT I Quick • -r Hämooccult-Test (-s versteckte Blut) (GGK) [occult=versteckt=verborgen] • -r Harnstoff-Atemtest I- r Urease-Schnelltest (ışaretlı üre verilir, bakteride üreaz varsa üre parçalanır, oluşan CO ₂ nefeste ölçülür) Apparative Diagnostik - r Ultraschall/-e Sonografie I -s Röntgen (ggf. mit Kontrastmittel) -e Magenspiegelung/-e Gastroskopie, -e ÖGD I -e Gewebeentnahme/-e Biopsie			

Labor

-s Blut: Hb I Leukos (Pl.) I Eisen- und B12-Werte (Pl.) I Gerinnungsparameter (Pl.), z.B. PTT I Quick
• -r Hämooccult-Test (-s versteckte Blut) (GGK) [occult=versteckt=verborgen]
• -r Harnstoff-Atemtest I- r Urease-Schnelltest (ışaretlı üre verilir, bakteride üreaz varsa üre parçalanır, oluşan CO₂ nefeste ölçülür)

Apparative Diagnostik

- r Ultraschall/-e Sonografie I -s Röntgen (ggf. mit Kontrastmittel)
-e Magenspiegelung/-e Gastroskopie, -e ÖGD I -e Gewebeentnahme/-e Biopsie

Erkrankungen

- -e Magenschleimhautentzündung/-e Gastritis
A: Autoimmun B: Bakterie C: Chemiale
- - r Reizmagens/-e funktionelle Dyspepsie
- -e gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD)
- -s Magengeschwür/-s peptische Ulkus o. -s Ulkus ventriculi
- - r Magenkrebs/-s Magen-Ca

Differenzialdiagnosen

- -s Zwölffingerdarmgeschwür/-s Ulkus duodeni
- -e Bauchspeicheldrüsenentzündung/-e Pankreatitis
- -e Leberentzündung/-e Hepatitis
- -e Gallenblasenentzündung/-e Cholezystitis

Therapie

- -e Ernährungsumstellung
- -e Alkohol-/ Nikotinkarenz
- -e Antiemetika: Metoclopramid(*Dopamin-rezeptor-antagonisten*), Dimenhydrinat(*antihistaminika*), Ondansetron(*Serotonin-Rezeptor-Antagonisten*), Dexamethason (*Glukokortikoide*)
- -s Antibiotikum
- -r PPH/PPi: Pantoprazol, Omeprazol, Esomeprazol -s
- Antazida:** Riopan, Rennie, Talcid
- **Bismut** (H. pylori tedavisinde: **Bismut-basierte Quadrupeltherapie**)
- -e **Anti-Stress-Therapie** (- r Schlaf, -e sportliche Aktivität, -e Entspannung)
- -e **Billroth-OP** (*partielle Magenresektion, Magen-CA*)

!!H.pylori>> Quadrupeltherapie: PPI, Bismut, Metronidazol, Tetracyclin (für 10-14 Tagen)

Gastroskopie

1- Gastroskopie wird auch Magenspiegelung genannt. 2- Das ist eine Untersuchung zur Beurteilung der Schleimhaut (der Speiseröhre, des Magens, des Zwölffingerdarms) 3- Sie dauert ungefähr 20 min. 4- Sie sollen 8 Stunden vor der Untersuchung nüchtern sein 5- Sie bekommen ein Beruhigungsmittel, damit Sie keine Schmerzen spüren 6- Ein dünner, flexibler Schlauch mit einer Kamera wird durch den Mund eingeführt und dann durch die Speiseröhre und den Magen bis zum Zwölffingerdarm geschoben. 7-- Wir können eine Probe entnehmen fürs Labor zur histologischen Untersuchung. 8- Nach der Untersuchung dürfen sie nicht selbst Auto fahren.

Komplikationen: 1- Schluckstörungen (*Reizung des Kehlkopfs durch den Schlauch*) 2- Verletzungen der Schleimhaut, Blutungen, Infektionen

Kontraindikationen : 1- Blutgerinnungsstörung 2- Unkooperativer Patient

Mögliche Ursachen einer akuten Gastritis:

Akute Infektionen **werden** am häufigsten durch Viren oder Bakterien **ausgelöst**.
Als Risikofaktoren kommen auch Nikotin-, Alkohol- und möglicherweise auch Kaffeeekonsum **infrage**.
Darüber hinaus können Lebensmittelvergiftungen oder stark gewürzte Speisen **mögliche Auslöser** sein. Lebensmittelvergiftungen oder stark gewürzte Speisen **gelten** auch als **mögliche Auslöser**.
Außerdem kann ein hoher Medikamentenkonsum eine Gastritis **verursachen**.
Ursachen dafür können psychische Auslöser wie Depression, Stress oder der Angst sein.
Weitere Möglichkeiten sind somatischer Stress durch Operationen oder größere Verletzungen.
Verätzungen(*koroziv*) der Magenschleimhaut **sowohl** durch Säuren **als auch** Lauge(*baz*) können eine Gastritis **verursachen**.
Empfehlungen zur Behandlung von Gastritis:
• viele kleine Mahlzeiten
• Verzicht auf Kaffee, Nikotin, Alkohol und scharfe Gewürze
• Vermeidung von Weizen, Schweinefleisch und Kuhmilch
• Verwendung von hochwertigen Ölen und entzündungshemmenden Gewürzen (Zimt -tarçın, Kurkuma -zerdeçal, Ingwer -zencefil)
• mindestens 1,5 l Getränke (z.B. Kräutertees)
• wenig Zucker

-e Belegzellen(Parietalzellen) : Bildung von HCL (Salzsäure), Abtötung von Bakterien, Aktivierung der Umwandlung von Pepsinogen in Pepsin, Bildung von Intrinsic-Faktor
-e Hauptzellen(Chef cells): Bildung von Pepsinogen
-e Nebenzellen(Sleim Zellen): Bildung einer schützenden Schleimschicht
-e G-Zellen(Gastrin Zellen): Bildung von Gastrin

Die Belegzellen geben Protonen in den Magen ab. Die Protonen und Chlorid bilden Salzsäure. Durch PPI wird die Abgabe von Protonen aus Belegzellen blockiert. Infodigessen wird weniger Magensäure produziert. Der Wirkstoff gelangt über den Magen-Darm-Trakt ins Blut. Man sollte den Protonenpumpenhemmer vor dem Essen einnehmen.

Schmerzen: brennend / dumpf/drückend /stechend / ziehend / krampfartig / gürtelförmig
Erbrechen: schwallartig(*fişkırır tarzda*) / blutig/ / hell (*boş mide*)/grünlich/ gallig / kaffeesatzartig /fäkal(*ileus*) / angedaut / säuerlich / übelriechend

Der Patient klagte über schwallartiges Erbrechen.
Die Patientin beschrieb das Erbrochene als grünlich.

Der Darm/Das Intestinum o. das Enteron

Anamnese

Aktuellen Beschwerden

1. Wo genau haben Sie Schmerzen?
2. Können Sie die Schmerzen beschreiben?
3. Haben Sie erbrochen?
4. Haben Sie Blähungen?
5. Fühlen Sie sich aufgebläht?
6. Haben Sie Blut oder Schleim im Stuhl bemerkt?
7. Hatten Sie ähnliche Beschwerden früher schon einmal?
8. Haben Sie noch andere Beschwerden?

Vegetative /Gynäkologische /Vorerkrankungen

1. Wie geht es Ihnen im Allgemeinen?
2. Haben Sie Fieber oder Nachtschweiß?
3. Haben Sie ab- oder zugenommen?
4. Leiden Sie unter Durchfall oder Verstopfung?
5. Wie sind Farbe und Konsistenz des Stuhls?
6. Schlafen Sie gut?
7. Haben Sie Menstruationsbeschwerden?
8. Wann war die letzte Regelblutung?

Ernährung/Unverträglichkeiten

1. Was haben Sie zuletzt gegessen?
2. Ist bei Ihnen eine Unverträglichkeit gegen irgendwelche Lebensmittel bekannt?
3. Wie ernähren Sie sich?

Familien-und Sozialananmnese

1. Haben Sie Probleme auf der Arbeit oder im Privatleben?
2. Gibt es in Ihrer Familie ähnliche Beschwerden?

Stuhlgang

1. Wie oft haben Sie Stuhlgang?
2. Hat sich die Form Ihres Stuhls in letzter Zeit verändert?
3. Haben Sie eine farbliche Veränderung bemerkt?
4. Nehmen Sie irgendwelche Mittel, um Ihren Stuhlgang zu regulieren?
5. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem, was Sie essen, und Ihrem Stuhlgang?

Anatomie und Begriffe

-r Magen:-r Gaster
-r Zwölffingerdarm:-s Duodenum
-r Leerdarm: -s Jejunum
-r Krummdarm:-s Ileum
-r Wurmfortsatz: -e Appendix vermiformis
-r Blinddarm: -s Caecum
-r aufsteigende Dickdarm: -s Colon ascendens
-r querliegende Dickdarm: -s Colon transversum
-r absteigende Dickdarm: -s Colon descendens
-r S-Darm:-s Colon sigmoideum o. -s Sigmoid o. Sigma
-r Mastdarm: -s Rektum
-r After: -r Anus

Nausea/Emesis

1. Ist Ihnen auch übel?
2. Haben Sie nur gewürgt oder auch erbrochen? (Würgereiz:kusma refleksi, Brechreiz:kusma hissi)
- 3.. Könnten Sie mir die Konsistenz und Farbe des Erbrochenen beschreiben?
→ Konsistenz: flüssig, breiig, mit Stücken
→ Farbe: gelblich, bräunlich, durchsichtig, klar, rötlich!!
- 4.. Haben Sie Blut in Ihrem Erbrochenen bemerkt?
umgangssprachlich: **kotzen** (bei Erwachsenen), **spucken** (bei Babys)
5. Enthielt das Erbrochene Nahrungsreste?

Im Duodenum findet die enzymatische Spaltung und Resorption des Speisebreis **statt**.

Im Jejunum findet die Fortsetzung der enzymatischen Aufspaltung der Nahrung sowie die Resorption von Wasser und Elektrolyten **statt**.

Zu den Aufgaben des Ileums gehört die Resorption von Wasser und Gallensäuren.

Die **Appendix ist für** die Körperabwehr durch Lymphzellen **verantwortlich**.

Im Colon findet die Eindickung des Stuhls durch Entzug von Wasser und Salz **statt**.

Die Aufgaben des Rektums sind die Speicherung des Stuhls, bis der Entleerungsreflex ausgelöst wird.

Diagnostik

allgemeine Beschwerden

*-e Schmerzen (Pl.) im Unterbauch/im Hypogastrium *- r Krampf, -e Kolik
*-e Übelkeit/-e Nausea *- s Erbrechen/-e Emesis *- s Fieber/-e Pyrexie
*-r Durchfall/-e Diarrhoe *- e Verstopfung/-e Obstipation
*-s Blut im Stuhl/-e Hämatochezie bzw. -e Meläna *- r Blähbauch/-r Meteorismus
*-e Windabgang/-e Flatulenz *-e akuten Bauchschmerzen (Pl.)/-s akute Abdomen

Inspektion (Abdomen):-r Bruch/-e Hernie
*-e Narbe *-e Vorwölbung *-e Pulsation

Perkussion: **N:** tympanisch
P:-e Dämpfung, gedämpft

Palpation: -e Abwehrspannung(defans): leicht, deutlich
-s brettharte Abdomen o. -r akute Bauch (tahta katin/peritonitis)
-r Druckschmerz, druckschmerzhaft/druckdolent
-r Loslassschmerz (rebound)
Zeichen und Punkte: McBurney, Lanz, Rovsing,Blumberg, Psoas
-r Erschütterungsschmerz (sarsintyla ağrı, yani yürürken ziplarken vs)

Auskultation:
-e Peristaltik: vermehrt *klingend *hochgestellt
* vermindert * fehlend („-e Grabesstille“)

Labor

-s Blut: CRP I Natrium I Kalium I Bilirubin I LDH I Quick I PTT I -s Blutbild
-e Stuhluntersuchung: -e pathogenen Keime (Pl.) (m.o)
-r Hämoccult-Test * -r iFOBT
*Wir testes, os es im Stuhl **verborgenes Blut gibt**.*
ggf. Leber- und Nierenparameter (Pl.)

Apparative Diagnostik

- r Ultraschall/-e Sonografie
-s Röntgen-Abdomen *-s CT * -s MRT
-e Darmspiegelung/-e Koloskopie
-e Bauchspiegelung/-e Laparoskopie

Lebensmittelinfektion und Lebensmittelintoxikation?

Übelkeit, krampfartige Schmerzen im Unterbauch, Erbrechen und Durchfall - die Symptome ähneln sich, doch die Auslöser sind verschieden. Wenn diese Beschwerden wenige Stunden nach dem Essen auftreten, handelt es sich meist um eine Lebensmittelvergiftung bzw. -intoxikation. Die Ursache hierfür sind von Bakterien gebildete Toxine (z.B. von Staphylokokken) in verdorbenen Lebensmitteln. Eine Lebensmittelvergiftung ist nicht ansteckend. Anders sieht es bei der Lebensmittelinfektion aus. Hier befinden sich die Bakterien (z.B. Campylobacter, Salmonellen, Listerien, E-Coli) oder Viren (z.B. Noro, Rota, Cholera) in verunreinigten bzw. schlecht gelagerten Lebensmitteln. Die Erreger gelangen direkt in den Darm und lösen dort nach ein bis zwei Tagen die Beschwerden aus. Wie schon der Name sagt, sind Erkrankungen, die von diesen Erregern verursacht werden, infektiös. Sollten E- coli, Salmonellen, Rota- oder Noroviren festgestellt werden, muss sofort das Gesundheitsamt informiert werden. Infektionen mit diesen Erregern sind in Deutschland meldepflichtig.

Koloskopie: Koloskopie wird auch Darmspiegelung genannt. Das ist eine Untersuchung zur Beurteilung der Schleimhaut des Dickdarms. Sie dauert ungefähr 30 min. Sie sollen 12-24 Stunden vor der Untersuchung nüchtern sein. Sie sollen ein Tag vor der Untersuchung sowohl ein Abführmittel einnehmen als auch ein Liter Wasser trinken, damit der Darm sauber wird. Sie bekommen ein Beruhigungsmittel, damit Sie keine Schmerzen spüren. Ein dünner Schlauch mit einer Kamera wird durch den After eingeführt und dann durch den Mastdarm und den Dickdarm geschoben Der Schlauch hat drei Teile: Eine Lichtquelle mit Kamera, eine Zange sowie ein Versorgungskanal. Wir können eine Probe entnehmen fürs Labor zur histologische Untersuchung. Nach der Untersuchung dürfen sie nicht selbst Auto fahren.

Laparoskopie(Schlüssellochchirurgie): Die Laparoskopie ist eine diagnostische und operative Maßnahme im Bauchraum. Sie werden stationär aufgenommen und müssen vor dem Eingriff ungefähr 8 Stunden nüchtern sein. Der Eingriff erfolgt unter Vollnarkose. Wir machen kleinste Schnitte neben den Nabel und im Unterbauch. Ein Trokar wird eingeführt, um den Bauch mit CO₂ aufzublähen. Sie verspüren danach möglicherweise Schmerzen im Brustkorb oder in den Schultern, die nach einigen Tagen aber verschwinden.

Therapie

*-e Nahrungskarenz *-e Schonkost(hafif diyet, AGE'de) *-e Ernährungsumstellung (ballaststoffreich)
*-s Mittel gegen Durchfall/-sAntidiarrhoikum *-s Abführmittel/ -s Laxans
* -s krampf lösende Mittel/-s Spasmolytikum *-s Antibiotikum ggf. -s Viostatikum
• -e körperliche Bewegung
• OP: -e (minimalinvasive) Blinddarmentfernung/-e (laparoskopische) Appendektomie
• -e Teilresektion des Darms
• -e Hartmann-OP
• -e Bestrahlung/-e Radiotherapie *-e Chemotherapie *-e Immuntherapie
Tipps bei Gastroenteritis: sich ausruhen, viel Tee und Wasser trinken (in kleinen Schlucken), Banane, Zwieback, geriebener (rendelenmiş) Apfel, ggf. Elektrolytlösungen aus der Apotheke nur bei langanhaltenden Beschwerden: Medikamente gegen Durchfall und Erbrechen
Reibe: rende reiben: rendelemek EL: Esslöffel TL: Teelöffel

Erkrankungen

- - r Magen- Darm- Infekt(umgang:die Bauchgrippe)/-e virale o. bakterielle Gastroenteritis
- e Lebensmittelvergiftung/-e Lebensmittelintoxikation I -e Lebensmittelinfektion
- -s Zwölffingerdarmgeschwür/-s Ulcus duodeni
- -e Blinddarmentzündung/-e Appendizitis
- -e Divertikulose/Divertikulitis *Polyp = gutartige Schleimhautwucherung
- -e chronisch entzündliche Darmerkrankung (CED):
-r Morbus Crohn, -e Colitis ulcerosa
- -s Reizdarmsyndrom/-s Colon irritabile
- - r paralytische o. mechanische Darmverschluss/-r lieus
- - r Darmkrebs/-s Colon- CA
- -e Glutenunverträglichkeit/-e Zöliakie o. -e Sprue

Differenzialdiagnosen

- -e Oberbaucherkrankungen, z.B. -s Ulcus ventriculi
- -e Nierenerkrankungen, z.B. -e Pyelonephritis *-e Urolithiasis
- -e Erkrankungen der Geschlechtsorgane, z.B. -e Adnexitis
- - r Leistenbruch/-e Inguinalhernie

Der Morbus Crohn

Der Morbus Crohn ist eine **chronisch entzündliche Darmerkrankung**, bei der **alle Wandschichten** des Darms betroffen sein können. Die Erkrankung kann den **gesamten Verdauungstrakt** betreffen, am häufigsten sind jedoch das **terminale Ileum und das Colon** betroffen. Typische Symptome sind **Bauchschmerzen**, **chronische Diarrhö**, **Gewichtsverlust** sowie **Fieber** und **Müdigkeit**. Außerdem können extraintestinale Beschwerden wie **Gelenkschmerzen** oder **Hautveränderungen** auftreten. Charakteristisch ist ein **schubweiser Verlauf**. Die Erkrankung ist **nicht heilbar**, kann jedoch durch medikamentöse Therapie gelindert werden. Komplikationen wie **Fisteln**, **Abszesse** oder **Stenosen** sind möglich.

Ulcerative colitis

Die Colitis ulcerosa ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des Dickdarms. Die Entzündung **beginnt meist im Rektum** und breitet sich **kontinuierlich im Colon** aus. Typische Beschwerden sind **blutig-schleimige Diarrhö**, **Bauchkrämpfe** und **häufiger Stuhldrang**. Die Erkrankung verläuft typischerweise **schubweise**. Die Therapie richtet sich nach der Krankheitsaktivität und erfolgt meist **medikamentös**. In schweren Fällen oder bei Komplikationen kann eine **operative Entfernung** des Dickdarms notwendig werden. Außerdem besteht langfristig ein erhöhtes Risiko für Darmkrebs.

CED (chronisch entzündliche Darmerkrankungen)

Die CED umfassen vor allem den Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa. Es handelt sich um chronische, schubweise verlaufende Entzündungen des Darms. Typische Symptome sind Bauchschmerzen, Durchfälle (teilweise blutig), Gewichtsverlust und Müdigkeit. Die genaue Ursache ist nicht vollständig geklärt, es wird jedoch eine autoimmune Genese angenommen. Die Therapie erfolgt medikamentös, zielt auf die Entzündungshemmung und die Kontrolle der Schübe ab. In schweren Fällen können operative Maßnahmen notwendig sein.

Kolonkarzinom

Das Kolonkarzinom ist ein bösartiger Tumor des Dickdarms. Es entsteht häufig aus Adenomen im Rahmen der sogenannten Adenom-Karzinom-Sequenz. Risikofaktoren sind unter anderem höheres Alter, familiäre Belastung, ballaststoffarme Ernährung und chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Klinisch bleibt der Tumor lange asymptomatisch, später treten Symptome wie Blut im Stuhl, Veränderungen der Stuhlgewohnheiten, Gewichtsverlust und Anämie auf. Die Diagnose erfolgt meist durch Koloskopie mit Biopsie. Die Therapie besteht in der Regel aus operativer Entfernung, oft kombiniert mit Chemo- und/oder Strahlentherapie.

Appendizitis

Die Appendizitis ist eine Entzündung des **Wurmfortsatzes**, der ein **Anhängsel** des Blinddarms ist. Sie tritt besonders häufig bei **Kindern und Jugendlichen** auf. Der Verlauf kann unterschiedlich sein, typischerweise handelt es sich jedoch um ein akutes Krankheitsbild mit **zunehmenden Bauchschmerzen**, oft im **rechten Unterbauch**, sowie **Fieber** und **Übelkeit**. Die Standardtherapie ist die **operative Entfernung** des Wurmfortsatzes (**Appendektomie**), in ausgewählten Fällen kann auch eine **antibiotische Therapie** erfolgen.

-r McBurney-Punkt: Druckpunkt auf der Monro-Linie zwischen rechter SIAS und Nabel
-s Blumberg-Zeichen: zum McBurney-Punkt kontralateraler Loslassschmerz (rebound)
-s Psoas-Zeichen: Anheben des rechten Beines gegen einen Widerstand
-r Lanz-Punkt: Druckpunkt im rechten Drittel auf der Lenzmann-Linie zwischen den SIAS
-s Rovsing-Zeichen: Ausstreichen des Kolons gegen den Uhrzeigersinn

Die Divertikulose

Die Divertikulose ist durch **Ausstülpungen** der Darmschleimhaut (Divertikel) gekennzeichnet. Ursachen sind unter anderem **ballaststoffarme Ernährung**, häufige **Obstipation** und ein **schwaches Bindegewebe**, wodurch sich die Darmschleimhaut nach außen **vorwölbt**. Meist verläuft die Erkrankung **asymptomatisch** oder mit leichten Beschwerden. Die Therapie besteht vor allem aus einer **ballaststoffreichen Ernährung**, **ausreichender Flüssigkeitszufuhr** und **regelmäßiger Bewegung**. Wenn sich Divertikel entzünden, spricht man von einer Divertikulitis.

Das Colon irritabile

Das Colon irritabile ist ein funktionelles Darmleiden, das sich durch häufige Bauchbeschwerden äußert. Typisch sind **wechselnde Stuhlgewohnheiten** mit **Verstopfung** und **Durchfall**. Es liegt **keine organische Ursache** zugrunde, sondern meist eine funktionelle bzw. **psychosomatische** Störung. Chronischer Stress sowie soziale oder psychische Belastungen können die Beschwerden auslösen oder verstärken. Die Therapie besteht vor allem aus **Ernährungsumstellung**, **Stressreduktion** und **psychotherapeutischen Maßnahmen**.

Infektiöse Enterokolitis

Die infektiöse Enterokolitis ist eine entzündliche Erkrankung des Dün- und Dickdarms, die durch Bakterien, Viren oder Parasiten verursacht wird. Typische Erreger sind z. B. Noroviren, Rotaviren, Salmonellen oder Campylobacter. Klinisch zeigt sich die Erkrankung meist akut mit wässriger oder manchmal auch blutiger Diarrhö, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und gelegentlich Fieber. Die Übertragung erfolgt häufig fäkal-oral über kontaminierte Lebensmittel oder Wasser. Die Therapie ist meist symptomatisch mit ausreichender Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr; in schweren Fällen kann eine spezifische antiinfektiöse Therapie notwendig sein.

Ösophaguskarzinom

Das Ösophaguskarzinom ist ein bösartiger Tumor der Speiseröhre. Es tritt häufiger bei älteren Patienten auf und ist oft mit Risikofaktoren wie Rauchen, Alkohol, Refluxkrankheit oder Barrett-Ösophagus assoziiert. Klinisch bleibt die Erkrankung lange asymptomatisch. Später treten vor allem progrediente Dysphagie (erst feste, dann flüssige Nahrung), Gewichtsverlust und retrosternale Schmerzen auf. Die Diagnose erfolgt durch Endoskopie mit Biopsie. Die Therapie besteht abhängig vom Stadium aus Operation, Radiochemotherapie oder palliativen Maßnahmen.

Ulcus ventriculi

Das Ulcus ventriculi ist ein Schleimhautdefekt des Magens. Typische Symptome sind epigastrische Schmerzen, Übelkeit und Völlegefühl. Wichtige Ursachen sind die Infektion mit *Helicobacter pylori* sowie die Einnahme von NSAR. Die Schmerzen treten häufig **nach dem Essen** auf und können sich dadurch verschlechtern. Die Therapie besteht aus Protonenpumpenhemmern und ggf. Eradikation von *Helicobacter pylori*.
Unterschied zum Ulcus duodeni
Ulcus ventriculi → Schmerzen **nach dem Essen**
Ulcus duodeni → Schmerzen **nüchtern / besser nach dem Essen**

Cholezystolithiasis

Die Cholezystolithiasis bezeichnet das Vorhandensein von Gallensteinen in der Gallenblase. Viele Patienten sind asymptomatisch. Typische Symptome treten bei einer Gallenkolik auf: starke kolikartige Schmerzen im rechten Oberbauch, oft nach fettreichen Mahlzeiten, mit Ausstrahlung in Rücken oder rechte Schulter, ggf. Übelkeit und Erbrechen. Risikofaktoren sind z. B. weibliches Geschlecht, Übergewicht, zunehmendes Alter und fettreiche Ernährung. Die Therapie reicht von Beobachtung bei asymptomatischen Patienten bis zur operativen Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie) bei symptomatischen Verläufen.

Der Harnapparat

Anamnese

Aktuellen Beschwerden	Vegetative /Gynäkologische /Vorerkrankungen	Anatomie und Begriffe
- Haben Sie Beschwerden beim Wasserlassen? - Haben Sie Schmerzen oder ein brennendes Gefühl? - Haben Sie Schmerzen in den Flanken? - Können Sie die Schmerzen beschreiben? - Hat sich Ihre Urinmenge verändert? - Hat sich Geruch oder Farbe des Urins verändert? - Haben Sie Blut im Urin bemerkt? (Akkusativ) // - Ist Ihnen Blut im Urin aufgefallen? (Nominativ) - Schäumt Ihr Urin? (der Schaum: köpük schäumen; köpürmek) - Haben Sie Schwellungen an Armen, Beinen oder im Gesicht? - Wie häufig müssen Sie auf die Toilette? - Müssen Sie öfter zur Toilette als gewöhnlich? - Müssen Sie auch nachts mehrmals auf die Toilette (Nykturie)? - Können Sie den Urin bis zur Toilette halten? - Verlieren Sie manchmal Urin, z.B. beim Lachen, Husten oder Niesen?	- Haben Sie Fieber? - Haben Sie Schüttelfrost oder Nachtschweiß? - Fühlen Sie sich schwach? - Hat sich in letzter Zeit Ihr Gewicht verändert? - Wie viel trinken Sie pro Tag? - Ist Ihre Periode regelmäßig? - Wann war die letzte Periode? - Haben Sie Probleme beim Geschlechtsverkehr? - Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen, z. B. Herzprobleme?	-e untere Hohlvene: -e Vena cava inferior -e Bauchschatlagader: -e Aorta abdominalis -e Nebenniere: -e Glandula suprarenalis -e Niere: -r Ren -r Harnleiter: -r Ureter -e Harnblase: -e Vesica urinaria -e Harnröhre: -e Urethra -e Beckenvene: -e Vena iliaca -e Beckenschlagader: -e Arteria iliaca communis -e Nierenarterie: -e Arteria renalis -e Nierenvene: -e Vena renalis -e Nierenrinde: -r Cortex renalis (die Rinde: kabuk) -s Nierenmark: -e Medulla renalis -e Nierenpyramide: -e Pyramis renalis -r Nierenkelch: -r Cafix renalis -s Nierenbecken: -s Pyelos o. -e Pelvis renalis -e Nierenkapsel: -e Capsula fibrosa renis Urinieren: Wasser lassen / Wasserlassen, pinkeln(günük dil), pullern / Pipi machen (çocuklarda), das kleine Geschäft machen (kibar), pissen(argo) Defäkieren: Stuhlgang haben, auf die Toilette gehen, das große Geschäft machen, AA machen (çocuklarda), kacken(argo), ein Fax schicken(mizahi) Enuresis nocturna: nächtliches Einnässen einnässen → Altını ıslatmak. Bettnässer → gece altını ıslatan çocuk. (der Junge= der Bub=der Knabe: oğlan çocuk)
☐ Pollakisurie → Häufiges Wasserlassen in kleinen Mengen. ☐ Algurie → Brennen beim Wasserlassen. ☐ Nykturie → Nächtliches Wasserlassen ☐ Hämaturie → Blut im Urin. ☐ Dysurie → Erschwertes oder schmerzhaftes Wasserlassen. ☐ Oligurie → So nennt man eine tägliche Urinmenge von weniger als 500 ml. ☐ Proteinurie → erhöhte Eiweißausscheidung im Urin. Patienten berichten oft über schaumigen Urin. ☐ Anurie → Darunter versteht man eine Urinmenge von 100ml oder weniger innerhalb von 24 Stunden. ☐ Pyurie → Das ist die Bezeichnung für Eiter im Urin. Patienten beschreiben den Urin als trüb(nicht klar/bulanik) und/oder milchig-flockig[mit kleinen Partikeln].		

Die Geschlechtsorgane

Anamnese

Aktuellen Beschwerden	GynäkologischeAnamnese/Verhütung/ Sexualverhalten	Anatomie und Begriffe
- Wo genau haben Sie die Schmerzen? - Hängen die Schmerzen mit der Periode zusammen? - Haben Sie einen unangenehmen Geruch bemerkt? - Könnnten Sie schwanger sein? - Haben Sie einen Ausschlag oder Schwellungen im Intimbereich? - Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? - Haben Sie Ausfluss bemerkt? - Haben Sie Probleme beim Geschlechtsverkehr?	- Haben Sie noch Ihre Regelblutung? - Ist Ihre Periode regelmäßig? - Wann war die letzte Periode? - Waren Sie schon mal schwanger? - Verlief die Schwangerschaft normal? - Waren die Geburten natürlich? - Besuchen Sie regelmäßig Ihren Frauenarzt? - Wann waren Sie das letzte Mal beim Frauenarzt? - Verhüten Sie? Wie? - Haben Sie häufig wechselnde Sexualpartner?	-r Eierstock:-s Ovar -r Eileiter: -e Tuba uterina o. -e Salpinx -e Gebärmutter: -r Uterus -r Gebärmutterhals: -e Cervix uteri -r Muttermund: -s Ostium uteri -e Scheide: -e Vagina -e großen Schamlippen:-e Labia majora pudendi -e kleinen Schamlippen: -e Labia minora pudendi -e Vulva -r Kitzler: -e Klitoris -e Harnröhrenmündung :-s Ostium urethrae -e Scheide: -e Vagina -s Jungfernhäutchen: -s Hymen -r Damm: -s Perineum HWG = häufig wechselnde Geschlechtspartner *der Kreißsaal: doğumhane *gebären: doğurmak entbinden: doğum yaptırmak
Die Verhütungsmittel / Die Kontrazeptiva (x ungeschützten Geschlechtsverkehr) Hormonelle Methoden → die (Antibaby-)Pille, der Hormonring, das Hormonpflaster, die Dreimonatsspritze Intrauterinressare (IUP) → (rahim içi araçlar) die Kupferspirale, die Hormonspirale, die Kupferkette Barrieremethoden → das Kondom, das Femidom(kadın prezervatifi), das Diaphragma / die Portiokappe Die Sterilisierung → die Tubenligatur (Frauen), die Vasektomie (Männern), Kastration/ Ovarektomie Die erste Regelblutung tritt im Alter zwischen zehn und 16 ein und wird die Menarche genannt. Ein regelmäßiger Zyklus umfasst etwa 28 Tage und wird, wenn er beschwerdefrei abläuft, als Eumenorrhoe bezeichnet. Die Menstruation oder Periode dauert ungefähr drei bis fünf Tage. Eine starke und langanhaltende Blutung nennt man Hypermenorrhoe oder auch Menorrhagie. Treten Zwischenblutungen auf, spricht man von Metrorrhagie. Die meisten Frauen haben die letzte Regelblutung, genannt die Menopause, mit ca. 50 Jahren.		

Anamnese

Aktuellen Beschwerden	Verhütung/ Sexualverhalten	Anatomie und Begriffe
- Haben Sie Schmerzen oder ein Brennen beim WL? - Spüren Sie beim Wasserlassen ein Druckgefühl? - Ist Ihnen beim Wasserlassen eine Verzögerung(verspätung) aufgefallen? - Ist Ihnen Ausfluss oder ein Sekret aufgefallen? - Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Blase nicht vollständig entleert ist? (Restharn: rezidü idrar, Restharngefühl) - Tröpfelt der Urin nach? - Ist Ihr Harnstrahl schwächer geworden? - Haben Sie einen Ausschlag bemerkt?	- Benutzen Sie Kondome? - Haben Sie Probleme beim Geschlechtsverkehr? - Haben Sie wechselnde Sexualpartner oder -partnerinnen?	-e Harnblase /-e Vesica urinaria -s Schambein /-s Os pubis -r Samenleiter /-s Ductus deferens -r Schwellkörper /-r Corpus cavernosum -r Eichelschwellkörper /-r Corpus spongiosum glandis -e Vorhaut /-s Präputium -r Hodensack /-s Skrotum -r Hoden /-r Testis o. -r Testikel -r Nebenhoden /-e Epididymis -r Harnröhrenschwellkörper /-r Corpus cavernosum urethrae -e Harnröhre /-e Urethra -e Vorsteherdrüse /-e Prostata -e Bläschendrüse /-e Glandula vesiculosa

Diagnostik

allgemeine Beschwerden	Nieren (Pl.), Blase, Prostata: >>-s Fieber/-e Pyrexie >>-e Kopfschmerzen (Pl-e Cephalgie >>-e Übelkeit/-e Nausea >>-s Erbrechen/-e Emesis >>-e Schwäche/-e Asthenie >>-r Schüttelfrost >>-r Nachtschweiß >>-e kolikartigen Schmerzen (Pl.) >>-e Unterleibsschmerzen (Pl.) >>-e Flankenschmerzen (Pl.). >>-e vermehrte Urinausscheidung (hell) >>-e Wassereinlagerung/-s Ödem >>-r Bluthochdruck/-e Hypertonie >>-e Blutarmut/-e Anämie >>-s Brennen beim Wasserlassen/-e Dysurie/Algurie >>-s Blut im Urin/-e Hämaturie >>-r ständige Harndrang mit kleiner Urinmenge/-e Pollakisurie >>-e kleinen Urinmengen (Pl.)/-e Oligurie bzw. Anurie >>-r Harnverhalt/-e Ischurie >>-e Blasenschwäche/-e Harninkontinenz >>-r schwache Harnstrahl >>-s Blut im Sperma >>-e Erektionsschwierigkeiten (Pl.) /-e erektile Dysfunktion >>-e Schmerzen bzw. -s Druckgefühl im Anal- und Genitalbereich Geschlechtsorgane: -e Unterbauchschmerzen (Pl.) >>-r Ausfluss/-r Fluor >>- r Juckreiz/-r Pruritus >>-r Ausschlag/-s Exanthem >>-r Schleimhautausschlag/-s Erythema >>-e Menstruationsbeschwerden (Pl.) >>-e Erektionsstörungen (Pl.) >>Schmerzen beim Geschlechtsverkehr/ Dyspareunie	Inspektion -e äußeren Geschlechtsorgane (Pl.): P: geschwollen, gerötet, -r Sekretaustritt, -e (Schleim)Hautveränderung Perkussion: e Nieren (Pl.): N: Nierenlager frei P:-r Klopfschmerz im Nierenlager Palpation: -e Nieren (Pl.): N: bei gesunden Erwachsenen nicht tastbar -e Prostata (digital- rektale Untersuchung): N: Größe im Normbereich, Oberfläche glatt P: vergrößert, höckerig
Labor -s Blut: CRP I BSG I -s Blutbild I Leukos (PL) I Harnstoff (Üre) Harnsäure(Ürik asit) I Kreatinin I Kreatinin-Clearance, GFR (glomeruläre Filtrationsrate) Cystatin C -r Urinstatus: pH-Wert I Leukozyten (Pl.) I Etythrozyten (Pl.) I Proteine (Pl.) I Ketone (Pl.) I Glukose -e Urinkultur -r Abstrich Apparative Diagnostik >>-r Ultraschall/-e Sonografie >>-s CT >>-s MRT >>-e Blasenspiegelung/-e Zystoskopie >>-e HSG (Hysterosalpingographie) -e urodynamischen Untersuchungen: >>-e Harnstrahlmessung/-e Uroflowmetrie >>-e Blasendruckmessung/-e Zystometrie >>-s Harnröhrendruckprofil/-e Sphinkterometrie >>-s MCU [Miktionszystourethrographie]	Niereninsuffizienz Die Niereninsuffizienz ist eine eingeschränkte Funktion der Nieren. Man unterscheidet zwischen einer akuten und einer chronischen Form. Die Nieren können Abfallstoffe und überschüssige Flüssigkeit nicht mehr ausreichend ausscheiden. Typische Symptome sind Müdigkeit, Ödeme, Hypertonie und eine verminderte Urinproduktion. Die Behandlung richtet sich nach der Ursache. In schweren Fällen kann eine Dialyse erforderlich sein. Benigne Prostatahyperplasie (BPH) Die benigne Prostatahyperplasie ist eine gutartige Vergrößerung der Prostata, die vor allem ältere Männer betrifft. Durch die Vergrößerung wird die Harnröhre eingeengt. Typische Beschwerden sind ein abgeschwächter Harnstrahl, Startschwierigkeiten beim Wasserlassen, Pollakisurie, Nykturie und Restharngefühl. Die Therapie erfolgt je nach Ausprägung medikamentös oder operativ. Oft wird zunächst eine Behandlung mit Alphablockern begonnen. Urolithiasis Die Urolithiasis bezeichnet das Vorhandensein von Steinen in den Harnwegen. Die Steine können sich in der Niere, im Harnleiter oder in der Blase befinden. Typische Beschwerden sind kolikartige Schmerzen, Hämaturie sowie Übelkeit und Erbrechen. Kleine Steine können spontan mit dem Urin ausgeschieden werden, größere Steine müssen manchmal medikamentös, endoskopisch oder mittels ESWL behandelt werden. Litholyse: Die Litholyse ist eine Behandlung zur Auflösung kleiner Harnsteine mit Medikamenten. Dabei wird der pH-Wert des Urins verändert, sodass sich die Steine langsam auflösen. Die Steinreste werden anschließend mit dem Urin ausgeschieden. Während der Behandlung sollte der Patient viel trinken, um die Ausscheidung der Steine zu erleichtern. ESWL (Extracorporeal shock wave lithotripsy): Die ESWL ist eine Behandlung von Harnsteinen mit Stoßwellen. Dabei werden Schallwellen von außen durch die Haut in den Körper geleitet. Die Wellen zerbrechen die Steine in kleine Stücke. Diese werden anschließend entweder mit dem Urin ausgeschieden oder endoskopisch entfernt. Die Behandlung erfolgt ohne Operation.	
Erkrankungen Blase und Nieren: -e Blasenentzündung/-e Zystitis -e Blasenschwäche/-e Inkontinenz (/Harninkontinenz) -e Harnreihrenentzündung/-e Urethritis -e Harnröhrenenge/-e Urethrastriktur -e Steine in den Harnwegen/-e Urolithiasis -e Nierensteine/-e Nephrolithiasis -e Nierenbeckenentzündung/-e Pyelonephritis -e Nierenschwäche/-e Niereninsuffizienz -s akute o. chronische Nierenversagen(komplet nicht funktioniert) -r Morbus Addison -s Cushing- Syndrom -e Tumoren (Pl.) Weibliche Geschlechtsorgane: -e Eileiter- und Eierstockentzündung/-e Adnexitis -e Eierstockentzündung/-e Oophoritis -e Eierstockverdrehung/-e Ovarialtorsion -e Zyste -e Wucherung der Gebärmutter Schleimhaut/-e Endometriose -e Gebärmutter Schleimhautentzündung/-e Endometritis -r Gebärmutterhalskrebs/-s Zervixkarzinom. -e Scheidenentzündung/-e Vaginitis -r Scheidenpilz/-e Vaginalmykose o. -e Soorkolpitis -e Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter/-e Extrauterin gravidität -e sexuell übertragbaren Erkrankungen, z.B. -e Syphilis/-e Lues Männliche Geschlechtsorgane: -e gutartige Prostatavergrößerung/-e BPH. ; -e Harnröhrenenge/-e Urethrastriktur -e Prostataentzündung/-e Prostatitis -r Prostatakrebs/-s Prostata- Ca -e Hodenentzündung/-e Orchitis -e Nebenhodenentzündung/-e Epididymitis -e Hodenverdrehung/-e Hodentorsion -e Erektionsstörungen/-e erektile Dysfunktion -e sexuell übertragbaren Erkrankungen, z.B. -r Tripper/-e Gonorrhoe	Therapie Niere und Blase: -s Schmerzmittel/-s Analgetikum - s Antibiotikum -s krampflösende Mittel/-s Spasmolytikum -s pflanzliche Mittel/-s Phytotherapeutikum -e erhöhte Flüssigkeitszufuhr -s harntreibende Mittel/-s Diuretikum -r ACE-Hemmer -r Betablocker -e Steinauflösung/-e Litholyse -e Lithotripsie (-e ESWL) -e Blutwäsche/-e Dialyse -e Nierentransplantation Geschlechtsorgane: -s Antibiotikum (Fluorchinolone: Ciprofloxacin, Nitrofurantoin, Fosfomycin) -s Antimykotikum (Fluconazol, Voriconazol, Amphotericin B, Nystatin) -r 5-Alpha-Reduktasehemmer -e Prostataentfernung/-e Prostatektomie -e Entfernung von Eileiter und Eierstock/-e Adnektomie -e Gebärmutterentfernung/-e Hysterektomie -r Schwangerschaftsabbruch/-e Abortus graviditatis	Tipps bei Zystitis • viel trinken (Wasser, Blasen- und Nierentee, Brennnesseltee) • Intimhygiene: von vorn nach hinten reinigen • Kälte vermeiden (z.B. nicht auf kalten Untergründen sitzen) • nach dem Geschlechtsverkehr Wasser lassen, um Bakterien herauszuspülen

Das Gehirn/ Das Cerebrum o. Das Enzephalon

Anamnese

Aktuellen Beschwerden 1. Wurden Sie verletzt? / Hatten Sie einen Unfall? 2. Haben Sie Ihren Kopf gestoßen? 3. Haben Sie Ihr Bewusstsein verloren? Können Sie sich an alles erinnern? 4. Haben Sie Kopfschmerzen? 5. Ist Ihnen schwindlig? 6. Was verbessert oder verschlechtert die Beschwerden? 7. Haben Sie Lähmungserscheinungen? 8. Haben Sie Schwäche oder Lähmung an Armen oder Beinen? 9. Können Sie Ihre Arme und Beine ohne Probleme bewegen?	10. Haben Sie Taubheitsgefühle Kribbeln oder Lähmungen bemerkt? z.B. im Gesicht, in Ihren Beinen oder in den Armen? → Ameisen unter der Haut, “mein Bein ist eingeschlafen” 11. Haben Sie Probleme mit dem Sprechen? 12. Haben Sie Probleme mit dem Sehen? Beispielsweise verschwommenes Sehen, Lichtblitze oder sehen Sie alles doppelt? 13. Haben Sie Probleme mit dem Hören, Riechen oder Schmecken? 14. Haben Sie Konzentrations- oder Gedächtnisprobleme? 15. Wissen Sie, wo Sie sind und welcher Tag heute ist?	Lebensgewohnheiten / Vorerkrankungen 1. Schlafen Sie gut? 2. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen, z.B. Bluthochdruck oder Herzprobleme? Familienananmnese/ Sozialanamnese 1. Sind in Ihrer Familie Schlaganfälle oder andere Hirnerkrankungen bekannt? 2. Was machen Sie beruflich? 3. Haben Sie Stress? 4. Haben Sie private oder berufliche Probleme?
--	--	---

Diagnostik

allgemeine Beschwerden >>-e Kopfschmerzen(PI)-e Cephalgie >>-e Sehestörungen (PI.) >>-e Aura >>-r Schwindel/-e Vertigo >>-e Übelkeit/-e Nausea >>-s Erbrechen/-e Emesis >>-s Fieber/-e Pyrexie >>-e Lichtempfindlichkeit(ışığa duyarlılık)/-e Photophobie >>-e Lärmempfindlichkeit (sesse duyarlılık)/-e Phonophobie >>-e Nackensteifigkeit (ense sertliği) /r Meningismus	Inspektion -s Gangbild (Yürüyüş şekli) ataktisch: Serebellum hastalıkları, Alkol etkisi vs. unkoordiniert → koordinasyonsuz schwankend → sallanarak torkelnd → sarhoş gibi yalpalayarak kleinschrittig: küçük adımlarla/Parkinson schlurfend: ayak sürüyerek/Parkinson breitbeinig: geniş tabanlı /serebellum hasarı -r Steppergang: ayak düşmes, Peroneal sinir hasarı -r Scherengang: makaslama/ serebral palsy, spastik paraparezi -s Wernicke-Mann-Gangbild: inme sonrası, hemiplejik yürüyüş, hasta yarım daire çizer-zirkumduktion
Die neuro-psychologische Untersuchung 1. Das Bewusstsein >normal: bewusstseinsklar >pathologisch: schläfrig/somnolent-uykuya meyil tief schlafend/soporös-ağrılı uyaran+ verwirrt/delirant- konfüze, oryente değil im Dämmerzustand-alacakaranlık nicht ansprechbar/komatös-hiç uyanmaz 2. Die Orientierung >normal:zu allen Qualitäten orientiert (zu Ort, Zeit, Person, Situation) >Pathologisch: nicht o. /eingeschränkt orientiert 3. Die kognitive Kontrolle: vergesslich, unaufmerksam, unkonzentriert	4. Die Sprache -e Sprachstörung/-eAphasie -e Sprechstörung/-eDysphasie -e Wortfindungsstörung -e Perseveration/s Hängenbleiben an Gedanken -e verwaschene Sprache-alkollü 5. Affekt (duygulanım) > n: schwingungsfähig (esnek, değişebilir) /-e adäquate Stimmungslage(duruma uygun) > p: -e verminderte emotionale Schwingungsfähigkeit (donukluk, duygusal esneklik azalmış) manisch / depressiv
-e neurologischen Zeichen und Tests: -e Parese: -e Lähmung/Muskelschwäche [Monoparese, Paraparese: beide Beine, Tetraparese] -e Paralyse: vollständige Lähmung, tam felç) -e Hemiparese: unvollständige Lähmung einer Körperhälfte. (zB: rechtsseitige Hemiparese) -e Hemiplegie: Vollständige Lähmung einer Körperhälfte -e Parästhesie: Missempfindung ohne äußeren Reiz (Kribbeln, Ameisenlaufen, Brennen, Taubheitsgefühl -e Hypästhesie: vermindertes Gefühl -r Muskelkrampf/-e Spastik (Elektrolytungleichgewicht? (K ⁺ , Mg ²⁺), Dehydration?) -r Meningismus, -s positive Kernig-Zeichen -s positive Brudzinski-Zeichen, -s positive Lasègue-Zeichen (radikülopati, siyatik) -e Reflexe: physiologisch: auslösbar, lebhaft Pathologisch: -r gesteigerte Reflex/-e Hyperreflexie *-r fehlende o. nicht auslösbare Reflex * -e Areflexie	Labor -s Blut: Hb, Leukos (PI.), r Entzündungspararameter(CRP, Blutsenkungsgeschwindigkeit-BSG-Sedim), e Blutgerinnung (INR) Blutfettwerte (HDL, LDL), Harnstoff(üre), Phosphat, Kreatinin -e Leberwerte (PI. ALT, AST) -e Elektrolyte (PI.) -s Blutbild (TK) -s Nervenwasser o. -eRückenmarksflüssigkeit/ -r Liquor (BOS) Apparative Diagnostik -sRöntgen I –r Ultraschall/-e Sonografie -s CT -s MRT -s EEG -sEMG

Erkrankungen

- r Schlaganfall/-rApoplex o.-e Apoplexie o. –r Stroke o. –r Insult
- e Gerinnungsstörung/-e Koagulationsstörung (pıhtılaşma bozukluğu)
- e Minderdurchblutung im Gehirn/-e TIA
- e(Hirn)Blutung/-e Hämorrhagie
- s sub- bzw. epidurale Hämatom –e SAB
- r gesteigerte Hirndruck/-e intrakranielle Druckerhöhung (KİBAS)
- e Hirnschwellung/-s Hirnödem
- e Demenz, -e Alzheimer-Demenz
- s Schädel-Hirn-Trauma(SHT): -e Gehirnerschütterung/-eCommotio cerebri –e Gehirnprellung/-e Contusio cerebri
- r Morbus Parkinson -r Morbus Pick -e Multiple Sklerose (MS)
- e Hirnhautentzündung/-eMeningitis -eGehirnentzündung/-e Enzephalitis
- s Krampfleiden/-e Epilepsie
- e Kopfschmerzen (PI.)/-e Cephalgie -eMigräne
- r Hirntumor/-s Glioblastom bzw. –s Meningeom u.a.
- esekundäre Enzephalopathie durch Nieren- und Leberkrankungen (PI.)

Mögliche Differenzialdiagnosen

- e **psychischen Erkrankungen (PI.),** z.B. -eDepression –e Angststörung -e bipolare Störung -e Schizophrenie
- e **hormonellen Erkrankungen (PI.),** z.B. –e Schilddrüsenunterfunktion, -e Hypothyreose
- e **Anämie,** z.B. -eEisenmangelanämie/-e Sideropenie

Therapie

- s Antibiotikum -s Virostatikum -s Kortison/-sGlukokortikoid
- e Behandlung der Grunderkrankung
- e Gerinnselauflösung/-e Thrombolyse das Gerinnsel:pıhtı, pıhtılaşma
- e Gerinnselentfernu ng/-e Thrombektomie
- e intrakranielle Druckentlastung o. –e Trepanation
- e mikrochirurgische Resektion
- e Bestrahlung/-e Radiotherapie -e Chemotherapie
- s Psychopharmakon
- e Psychotherapie (-eVerhaltenstherapie –etiefenpsychologische Therapie -e Psychoanalyse u.a.)
- e Ergotherapie –e Logotherapie -e Physiotherapie

Epilepsie

1. Unter Epilepsie versteht man das Auftreten von wiederholten epileptischen Anfällen durch abnorme elektrische Entladungen im Gehirn.
2. Die Klassifikation erfolgt nach Anfallsart in fokale, generalisierte und unklassifizierte Anfälle.
3. Als Ätiologie kann man genetische Ursachen, Hirntumoren oder Schädel-Hirn-Traumata sowie Schlaganfälle nennen.
4. Als Risikofaktoren können Schlafmangel, Alkoholmissbrauch sowie neurologische Vorerkrankungen genannt werden.
5. Die typischen Symptome bei einer Epilepsie sind Bewusstseinsverlust, Muskelzuckungen und Zungenbiss.
6. Differentialdiagnostisch kommen auch Synkopen, Hypoglykämien und psychogene Anfälle in Betracht.
7. Welche Therapiemethoden empfehlen Sie?
– Antiepileptika, Behandlung der Ursache, gegebenenfalls epilepsiechirurgische Verfahren oder Vagusnervstimulation.

Migräne

1. Unter Migräne versteht man wiederkehrende anfallsartige Kopfschmerzen, häufig begleitet von vegetativen Symptomen.
2. Die Klassifikation erfolgt nach Erscheinungsbild in Migräne ohne Aura, Migräne mit Aura und chronische Migräne.
3. Als Ätiologie kann man genetische Faktoren sowie neuronale und vaskuläre Mechanismen nennen.
4. Als Risikofaktoren können Stress, Schlafmangel sowie hormonelle Schwankungen genannt werden.
5. Die typischen Symptome bei einer Migräne sind halbseitige Kopfschmerzen, Übelkeit und Lichtempfindlichkeit.
6. Differentialdiagnostisch kommen auch Spannungskopfschmerzen, Subarachnoidalblutungen und Hirntumoren in Betracht.
7. Welche Therapiemethoden empfehlen Sie?
– NSAR, Triptane, Antiemetika sowie bei häufigen Attacken eine Prophylaxe, z. B. mit Betablockern.

Apoplex

1. Unter einem Apoplex versteht man das plötzliche Auftreten neurologischer Ausfälle infolge einer zerebralen Durchblutungsstörung oder einer Hirnblutung.
2. Die Klassifikation erfolgt nach Ursache in ischämischen Schlaganfall (z. B. thrombotisch oder embolisch), hämorrhagischen Schlaganfall (Hirnblutung) und transitorische ischämische Attacke (TIA).
3. Als Ätiologie kann man bei einem ischämischen Schlaganfall Arteriosklerose, Thromboembolien sowie Vorhofflimmern nennen.
Bei einem hämorrhagischen Schlaganfall kommen vor allem arterielle Hypertonie, Gefäßmissbildungen sowie Aneurysmen infrage.
4. Als Risikofaktoren können arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus sowie Hyperlipidämie genannt werden. Außerdem spielen Nikotinkonsum, Adipositas und Bewegungsmangel eine wichtige Rolle.
5. Die typischen Symptome bei einem Apoplex sind plötzlich auftretende Hemiparese, Sprachstörungen und Fazialisparese. Zusätzlich können Sensibilitätsstörungen, Sehstörungen, Schwindel oder Bewusstseinsstörungen auftreten. Eine Hirnblutung verursacht häufiger starke Kopfschmerzen, Erbrechen und Bewusstseinsstörungen.
6. Differentialdiagnostisch kommen auch Hypoglykämien, epileptische Anfälle mit Todd-Parese sowie Migräne mit Aura in Betracht.
7. Die Diagnostik sollte schnellstmöglich erfolgen, da es sich um einen neurologischen Notfall handelt. Wichtige diagnostische Maßnahmen sind:
neurologische Untersuchung (z. B. NIHSS), Blutzuckerkontrolle, cCT zum Ausschluss einer Hirnblutung, gegebenenfalls cCT-Angiografie oder MRT, EKG zum Nachweis von Vorhofflimmern, Laboruntersuchungen inklusive Gerinnung.

Therapie

Beim ischämischen Schlaganfall: sofortige Vorstellung in einer Stroke Unit, intravenöse Thrombolyse innerhalb des therapeutischen Zeitfensters, mechanische Thrombektomie bei großen Gefäßverschlüssen, anschließend Sekundärprophylaxe mit Thrombozytenaggregationshemmern oder Antikoagulation.

Beim hämorrhagischen Schlaganfall: keine Lysetherapie, Blutdrucksenkung, Gerinnungsnormalisierung, neurochirurgische Entlastung bei Bedarf, intensivmedizinische Überwachung.

Der Hals, die Nase, das Ohr/ HNO

Anamnese

Die Mundhöhle & der Rachen

1. Können Sie die Schmerzen genauer beschreiben?
2. Haben Sie auch Kopfschmerzen?
3. Haben Sie Schluckbeschwerden?
4. Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Hals geschwollen ist?
5. Haben Sie Mundgeruch bemerkt?
6. Sind Sie manchmal heiser?
7. Hatten Sie diese Beschwerden schon einmal?
8. Haben Sie etwas gegen die Beschwerden eingenommen?
9. Haben Sie noch Ihre Mandeln?

Die Nase-der Nasus

- ☐ Haben Sie auch Schnupfen?
- ☐ Läuft Ihre Nase oder ist sie eher verstopft?
- ☐ Wie sieht das Nasensekret aus (klar, gelblich, grünlich)?
- ☐ Haben Sie auch Kopfschmerzen?
- ☐ Haben Sie Gesichtsschmerzen?
- ☐ Verstärken sich die Schmerzen, wenn Sie den Kopf nach unten beugen?
- ☐ Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?

- ☐ Ist Ihr Geruchssinn beeinträchtigt?
- ☐ Haben Sie Heuschnupfen oder andere Allergien?
- ☐ Müssen Sie häufig niesen?
- ☐ Benutzen Sie regelmäßig Nasenspray?

Das Ohr- die Auris

1. Haben Sie Fieber?
2. Hatten Sie Übelkeit oder Schweißausbrüche?
3. Ist Ihnen schwindelig?
4. Juckt es im Ohr?
5. Läuft Sekret aus dem Ohr?
6. Treten diese Beschwerden zum ersten Mal auf?
7. Hören Sie schlechter als sonst?
8. Haben Sie Ohrgeräusche (Tinnitus)?
9. Haben Sie weitere Beschwerden wie Husten oder Schnupfen?
10. Waren Sie kürzlich schwimmen?
11. Sind Sie in letzter Zeit geflogen?

Anatomie und Begriffe

- die Rachenmandel –e *Tonsilla pharyngealis*
- die Gaumenmandel –e *Tonsilla palatina*
- die Zungenmandel –e *Tonsilla lingualis*
- die Mundhöhle –s *Cavum oris*
- der Oberkiefer –e *Maxilla*
- der Unterkiefer –e *Mandibula*
- der Rachen –r *Pharynx*
- der Kehldeckel –r *Epiglottis*
- der Kehlkopf –r *Larynx* [Kehle: boğaz]
- die Luftröhre –e *Trachea*

- das Zahnfleisch –e *Gingiva*
- der Schneidezahn –r *Dens incisivus*
- der Backenzahn –r *Dens molaris* (Backe=Wange=yanak)
- der Gaumen –s *Palatum* [Gaumen:damak]
- die Zunge –e *Lingua*
- das Gaumenzäpfchen –e *Uvula*

- der Nasenvorhof – *Vestibulum nasi*
- die Nasenmuschel – *Concha nasales*
- der Nasenrachen – *Nasopharynx*
- die Stirnhöhle – *Sinus frontalis*
- die Keilbeinhöhle – *Sinus sphenoidalis*
- die Kieferhöhle – *Sinus maxillaris*
- die Siebbeinzellen – *Sinus ethmoidalis* Sieb: elek

die Ohrmuschel – *Auricula auris*
der Gehörgang – *Meatus acusticus*
das Trommelfell – *Membrana tympani*-Tympanon
der Hammer – *Malleus*
der Amboss – *Incus*
der Steigbügel – *Stapes*
die Ohrtuba – *Tuba auditiva*
das Gleichgewichtsorgan – *Vestibularapparat*
die Hörschnecke – *Cochlea* die Schnecke:salyangoz
der Hörnerv – *Nervus cochlearis* (Teil des *Nervus vestibulocochlearis*, VIII. Hirnnerv)

lärm: gürültü yapmak
Wattestäbchen = kulak çubuğu
(Ohren)schmalz / Ohrenschmalz = kulak kiri, kulak serumeni
Einwölbung= içe doğru bombeleşme / içe çekilme (retraksiyon)
Delle=Einbuchtung=Einwölbung=Einziehung= içe bombeleşme/çökme **Vorwölbung**=dışa bombeleşme
-e Seekrankheit: deniz tutması

Labor

-s Blut: Leukos (PL) //CRP I BSG I gesamt-IgE
spezifisches IgE
• - r Pricktest
• - r Nasenrachenabstrich/-r Nasopharyngealabstrich
• - r nasale Provokationstest

Apparative Diagnostik • -s Röntgen I - r Ultraschall/
-e Sonografie • -s CT I -s MRT
• - r Gleichgewichtstest
• -e Spiegelung/-e Endoskopie (-e Otoskopie I
-e Rhinoskopie)
• -e Messung der Nasenatmung/
-e Rhinomanometrie

Auskultation:

Hals / Lymphknoten

physiologisch: Lymphknoten nicht tastbar, nicht druckschmerzhaft (*indolent*), weich, verschieblich
pathologisch: tastbar (*palpabel*), vergrößert, druckschmerzhaft (*druckdolent*), schlecht verschieblich / fixiert /nicht verschieblich

Nase: Nervenaustrittspunkt des N. trigeminus:
pathologisch: druckschmerzhaft (*dolent*)

Nebenhöhlen (Sinus paranasales)

pathologisch: druckschmerzhaft (*druckdolent*), klopfschmerzhaft

Ohr: Druck auf den Tragus und Ziehen am Ohrläppchen:
schmerzhaft (*dolent*)

Erkrankungen

Mund und Hals: -e Mandelentzündung/-e Tonsillitis I -e Rachenentzündung/-e Pharyngitis I
-e Kehlkopfentzündung/-e Laryngitis I -e Erkältung I - r grippale Infekt
• - r Lippenherpes/-r Herpes simplex I -e Mundfäule/-e Stomatitis aphthosa o. herpetica Fäule = çürüme, çürüklük
• -e Entzündung des Zahnhalteapparats/-e Parodontitis -e Zahnfleischartzündung/-e Gingivitis
Nase: -e Nasennebenhöhlenentzündung/ -e Sinusitis maxillaris o. frontalis o. ethmoidalis o. sphenoidalis I -e Nasenpolypen (PL.) • - r Heuschnupfen/-e allergische Rhinitis o. -e Pollinosis
Ohr: -e Mittelohrentzündung/-e Otitis media I -e Entzündung des äußeren Gehörgangs/-e Otitis externa
• -e Innenohrentzündung/-e Labyrinthitis o. -e Otitis interna I -e Trommelfellentzündung/-e Myringitis
• -s Ohrensausen/-r Tinnitus sausen: uğultu I -r Morbus Menière
-e Altersschwerhörigkeit/-e Presbyakusis I -e Taubheit/-e Anakusis
• - r Hörsturz/-r Ohrinfarkt
Differenzialdiagnosen
-e neurologischen Erkrankungen (PL.) I -e Hirnerkrankungen (PL.) des Gehirns

Therapie

- -e abschwellenden Nasentropfen (PL.) I -s abschwellende Nasenspray/-r Vasokonstriktor/
- s Sympathomimetikum I -e Nasendusche
- -r Hustenstiller/-s Antitussivum j- r Schleimlöser, -r Hustenlöser/-s Mukolytikum j
- s Antiallergikum/-s Antihistaminikum I -r Vernebler/-r Inhalator
- -s Antibiotikum I -s Virostatikum I- s Kortison/-s Glukokortikoid
- -e Mandelentfernung/-e Tonsillektomie
- -e gesunde und ausgewogene Ernährung I -s Gurgeln[gargara] Ich gurgle I -s Vitamin C I -s Zink
- diverse Therapien (-r Stressabbau/-s Entspannungsverfahren)

Diagnostik

allgemeine Beschwerden	☐ die Kopfschmerzen –e <i>Cephalgie</i> ☐ die Heiserkeit – <i>Dysphonie</i> ☐ das Fieber –e <i>Pyrexie</i> ☐ die Übelkeit – <i>Nausea</i> ☐ die Geschmacksstörung e– <i>Dysgeusie</i> ☐ die Geruchsstörung –e <i>Dysosmie</i> ☐ die Schwerhörigkeit –e <i>Hypakusis</i>	☐ die Halsschmerzen ☐ der Schnupfen –e <i>Rhinitis</i> ☐ der (Dreh-)Schwindel –e <i>Vertigo</i> ☐ das Erbrechen – <i>Emesis</i> ☐ der Geschmacksverlust –e <i>Ageusie</i> ☐ der Geruchsverlust –e <i>Anosmie</i> ☐ die Taubheit – <i>Anakusis</i>	☐ die Schluckbeschwerden –e <i>Dysphagie</i>
-------------------------------	--	--	---

Inspektion

Lippen: **physiologisch**: rosig
pathologisch: blass, bläulich/zyanotisch, rissig, trocken
Mundschleimhaut
physiologisch: rosig, feucht
pathologisch: blass, trocken, gerötet, geschwollen

- Belag: weißlich, gelblich, bräunlich
- der Schleimhautausschlag – *Enanthem*
- das Bläschen –e *Vesicula*
- die Einblutung – *Petechie*

Zunge: **physiologisch**: rosig, feucht

- **pathologisch**: aufgeraut, furchig, Belag (weiß/gelb/braun), das Bläschen –e *Vesicula*, Petechien

Rachen: **physiologisch**: rosig

pathologisch: gerötet, geschwollen

Hals **pathologisch**: schmerzhaft

-e Verdickung I - r Knoten/-r Nodus

Nase **pathologisch**: gerötet, geschwollen

Nasenseidewand: **physiologisch**: gerade, regelrecht

pathologisch: verkrümmt (Deviation)

Sekret/Schleim:

physiologisch: klar, dünnflüssig

pathologisch: gelblich-grünlich, dickflüssig

Fließschnupfen – *Rhinorrhö*

Ohr

Trommelfell:

physiologisch: grau-gelblich, transparent,

perlmutterartiger Glanz

pathologisch: gerötet, vorgewölbt, prall, geschwollen

Sekretion – *Otorrhö*

Palpation:

-r Hals -r Lymphknoten: nicht schmerzhaft/ indolent I

nichttastbar I verschieblich

pathologisch: druckschmerzhaft/druckdolent

tastbar/palpabel, geschwollen I nicht verschieblich

-e Nase -r NAP (-r Nervenaustrittspunkt) des N.trigeminus

druckschmerzhaft/druckdolent

-e Nebenhöhlen (PL.)

-e Sinus paranasales (PL)

druckschmerzhaft/druckdolent

klopfschmerzhaft

-s Ohr Druck auf den Tragus und Ziehen am

Ohrläppchen: schmerzhaft/dolent

- s **äußere Ohr**: Hier werden die Geräusche empfangen.
- s **Mittelohr**: In diesem Teil werden die Schallwellen vom Trommelfell über Hammer, Amboss und Steigbügel zum Innenohr geleitet.
- s **Innenohr**: Hier werden in der Hörschnecke die Schallwellen in elektrische Nervenimpulse umgewandelt und das Gleichgewicht reguliert.

Die Nase produziert täglich viel Sekret, um die Schleimhaut feucht zu **halten** und die Atemluft zu **reinigen**. Bei einer Erkältung kann die Nase **verstopfen**, der Schleim läuft nicht ab. **Zum** Nasenraum **gehören** auch die Nasennebenhöhlen. **Dazu zählen** je zwei Kieferhöhlen, Stirnhöhlen, Keilbeinhöhlen und die Siebbeinzellen, die aus mehreren Kammern zwischen den Augenhöhlen **bestehen**. **Sammelt** sich dort im Rahmen einer Erkältung Schleim **an**, kann es zu einer Sinusitis (Nasennebenhöhlenentzündung) **kommen**. Im schlimmsten Fall können die Nebenhöhlen **vereitern**. Eine Sinusitis **äußert** sich durch starke Gesichtsschmerzen, Kopfschmerzen und **mitunter** auch sichtbare Schwellungen. **'mitunter**:teilweise, manchmal (Dazu zählen ...= Bunlar arasında ... vardır.)

Die Mundhöhle ist ein **kleines** Sammelbecken für eine Vielzahl an Mikroorganismen und nicht **steril**. Für Nahrungsaufnahme und Atmung ist die Mundhöhle mit Speiseröhre und Luftröhre verbunden. Außerdem befinden sich im Halsbereich **zahlreiche** Lymphknoten. Für das Immunsystem spielt der **sogenannte** Waldeyersche Rachenring mit seiner **hohen** Anzahl an Leukozyten und Lymphozyten eine **wichtige** Rolle. Zu diesem **ringförmigen** System gehören Rachen-, Gaumen- und Zungenmandel sowie **lymphatisches** Gewebe an der Rachenwand, auch Seitenstränge genannt. (**Sammelbecken** = toplama havuzu / toplandığı yer.)

Der Tinnitus: Unter einem Tinnitus versteht man das Auftreten von Ohrgeräuschen. Diese Geräusche können nur einige Sekunden oder auch bis zu mehreren Stunden andauern. Bestehen sie länger als drei Monate, spricht man von einem chronischen Tinnitus. Die meisten Betroffenen berichten über einen Pfeif(**ıslık**)- oder Piepton(**bip sesi**) im Ohr, aber auch Summen(**uğultu, vizilti**-arı), Brummen(**homurtu**-beâr) und Rauschen(**hışırtı**-deniz şelale vs sesi) sind häufige Geräusche. Manche Menschen hören sogar Kirchenglocken(**kilise çanı**) o.Ä. (oder Ähnliches) In den meisten Tinnitusfällen ist die Ursache in Stress oder Lärmbelastung zu finden. Auch ein Knalltrauma(**anı ses travması**) (z .B. eine Explosion) kann dafür verantwortlich sein. Außerdem können chronische Mittelohrentzündungen Ohrgeräusche hervorrufen(=**verursachen, auslösen**). Bei Morbus Menière zählt Tinnitus zu den begleitenden Beschwerden. Aber ebenso können Probleme außerhalb des Ohrbereichs Tinnitus verursachen, z.B. Fehlstellungen des Kiefergelenks oder Verspannungen des Kiefermuskels.

Er schleimt sich beim Chef ein. (**sich einschleimen**=yalakalık yapma **Schleimer**:yalaka
Die Zähne fallen aus. (döküldü) Milchzähne->bleibende Zähne->die Füllung: dolgu-> Zahn prothese (einen Zahn ziehen=einen Zahn entfernen) Weisheitszahn: yirmilik diş

TONSILLITIS

Unter einer Tonsillitis versteht man eine **Entzündung der Rachenmandeln (Tonsillae palatinae)**, die meistens durch eine Infektion mit Viren oder Bakterien verursacht wird.

Als Ursachen einer Tonsillitis kommen vor allem virale und bakterielle Infektionen infrage. [Viren (**häufigste Ursache**), **z. B. Rhino-, Adeno- oder Coronaviren**. Bakterien, **insbesondere** β -hämolisierende Streptokokken der Gruppe A]

Als Risikofaktoren kann mann **enger Kontakt zu infizierten Personen, geschwächtes Immunsystem , Aufenthalt in Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. Kindergarten, Schule), kalte Jahreszeit** nennen

Die typischen Symptome einer Tonsillitis sind Halsschmerzen und Schluckbeschwerden, gerötete und geschwollene Mandeln, Fieber, Kopfschmerzen, vergrößerte und schmerzhafte Halslymphknoten. Bei einer viralen Tonsillitis treten häufig zusätzlich **Schnupfen** und **Husten** auf.

Zu den möglichen Komplikationen gehören **Peritonsillarabszess, Halsabszess, Ausbreitung der Infektion**, bei Streptokokkeninfektion selten: **akutes rheumatisches Fieber oder Poststreptokokken-Glomerulonephritis**

Die Diagnostik umfasst: Anamnese (Abklärung von Halsschmerzen, Fieber, Schluckbeschwerden und Krankheitsdauer), körperliche Untersuchung (**Inspektion des Rachens mit Beurteilung der Mandeln**) , Palpation der Halslymphknoten , Rachenabstrich **zum Nachweis von β -hämolisierenden Streptokokken der Gruppe A, bei Bedarf Laboruntersuchungen (z. B. CRP, Leukozyten)** Differentialdiagnostisch kommen auch **Pharyngitis, Infektiöse Mononukleose (EBV-Infektion) und Peritonsillarabszess** infrage.

Die Therapie richtet sich nach der Ursache. Bei viraler Tonsillitis: **symptomatische Therapie** mit Schmerzmitteln, Fiebertmitteln und ausreichender Flüssigkeitszufuhr. Bei bakterieller Tonsillitis durch Streptokokken: **Antibiotikatherapie**, z. B. mit Penicillin. Bei wiederkehrenden schweren Tonsillitiden: ggf. **Tonsillektomie (operative Entfernung der Mandeln)**

SINUSITIS

Unter einer Sinusitis versteht man eine **Entzündung der Nasennebenhöhlen**, die meistens durch eine virale oder bakterielle Infektion verursacht wird.

Als Ursachen einer Sinusitis kommen vor allem **Infektionen mit Viren oder Bakterien** infrage. [**Virale Infektionen** (häufigste Ursache), **Bakterielle Infektionen**, häufig als Folge einer **Rhinitis** (Erkältung/Schnupfen)]

Als Risikofaktoren kann man **häufige Erkältungen, Allergische Rhinitis, Nasenpolypen, anatomische Engstellen der Nase, geschwächtes Immunsystem nennen**.

Die typischen Symptome einer Sinusitis sind: **Schnupfen und verstopfte Nase, Kopfschmerzen bzw. Gesichtsschmerzen** (insbesondere im Bereich: Stirn, Augenhöhlen, Wangen), **Druckgefühl im Gesichtsbereich, Fieber, Müdigkeit und Abgeschlagenheit** , eventuell **eitriger Nasenausfluss**

Zu den möglichen Komplikationen gehören: **Ausbreitung der Infektion auf die Augenhöhle (Orbitaphlegmone), Meningitis** (selten) und **chronische Sinusitis**.

Die Diagnostik umfasst **Anamnese** (Abklärung von Schnupfen, Gesichtsschmerzen, Fieber und Dauer der Beschwerden), **körperliche Untersuchung** (Inspektion der Nase und des Rachens, Druckschmerz über den Nasennebenhöhlen), bei unklaren oder komplizierten Verläufen: **Nasennebenhöhlen-CT**

Differentialdiagnostisch kommen auch **Rhinitis, Migräne, Clusterkopfschmerz, Zahnbedingte Schmerzen (odontogene Ursachen)** infrage.

Die Therapie richtet sich nach der Ursache und dem Schweregrad. Symptomatische Therapie: ausreichende Flüssigkeitszufuhr, Nasenspülungen mit Kochsalzlösung, abschwellende Nasensprays (nur kurzfristig), Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol **Bei bakterieller Sinusitis: Antibiotikatherapie** Bei chronischen oder komplizierten Verläufen: ggf. **operative Therapie**

Die Schilddrüse-Die Thyreoidea

Anamnese

Allgemeine Befinden & Vegetativen Symptome

- 7) Wie fühlen Sie sich?
- 8) Fühlen Sie sich oft gereizt oder aggressiv?
- 9) Sind sie gestresst?
- 10) Haben Sie Probleme, sich zu konzentrieren?
- 11) Sind Ihnen zusätzlich depressive Verstimmungen oder kognitive Einschränkungen aufgefallen?
- 12) Sind Sie in letzter Zeit antriebslos?
- 13) Sind Sie oft müde?
- 14) Sind Sie oft krank?
- 15) Gab es in letzter Zeit Infektionen o. Stresssituationen?
- 16) Leiden Sie unter Herzrasen oder Zittern?
- 17) Haben Sie Veränderungen an Ihren Augen bemerkt, wie z. B. hervortretende Augen (Exophthalmus) oder Doppelbilder?
- 18) Haben Sie feuchte Hände?
- 19) Haben Sie trockene Haut?

- 1) Haben Sie Haarausfall bemerkt?
- 2) Frieren oder schwitzen Sie oft?
- 3) Wie ist Ihr Appetit?
- 4) Haben Sie in letzter Zeit ab- oder zugenommen?
- 5) Haben Sie Durchfall oder Verstopfung?
- 6) Haben Sie Veränderungen im Menstruationszyklus?

Beschwerden im Halsbereich

1. Haben Sie Schluckbeschwerden?
2. Spüren Sie ein Druckgefühl im Hals?
3. Ist Ihr Hals dicker geworden?

Ernährung/Unverträglichkeiten

1. Wie ernähren Sie sich?
2. Gibt es in Ihrer Familie Schilddrüsenerkrankungen?

Anatomie und Begriffe

-r **Schildknorpel**: -e Cartilago thyroidea
-e **Kehlkopfmuskulatur**: -e Musculi laryngis (Pl.)
-r **rechte Lappen**: -r Lobus dexter
-r **linke Lappen**: -r Lobus sinister
-e **Luftröhre**: -e Trachea
-e **Schildknorpel-Zungenbein-Membran**:
-e Membrana thyrohyoidea
-e **Gewebebrücke**: -r Isthmus

der Schild: 1) kalkan 2) tabela
das Knorpel: kirkirak

HYPOTHYREOSE, 27 Jahre: „Ich fühle mich seit einigen Wochen extrem müde und antriebslos. Obwohl ich viel schlafe, werde ich gar nicht mehr richtig wach. Alles, was ich früher gern gemacht habe; interessiert mich irgendwie nicht mehr. Manchmal bin ich auch traurig und weiß gar nicht so genau, warum. Ich habe auch das Gefühl, zugenommen zu haben. Die Kleidung, die ich letzten Sommer gekauft habe, passt nicht mehr. Jetzt trage ich meistens Jogginganzüge (esofman). Ich habe auch oft Verstopfung. Vielleicht liegt das an der Schokolade, die ich ständig esse. Ich friere dauernd und trage meistens auch zu Hause einen dicken Pullover. Meine Haare fallen aus und meine Haut, die total trocken ist, muss ich jetzt täglich eincremen. (Meine Haare sind stumpf und brüchig. Früher haben sie richtig gegläntzt.) Auch mein Studium, mit dem ich schon seit Monaten fertig sein sollte, macht mir Sorgen. Aber ich kann mich einfach auf nichts konzentrieren...“ **Stoffwechselbremsung**

HYPERTHYREOSE, 32 Jahre : „Mein bester Freund, der mich schon seit Jahren kennt, hat schon vor Monaten gesagt, dass ich mich verändert hätte. Ich sei permanent ungeduldig und nervös, teilweise sogar aggressiv. Mir war das gar nicht bewusst, aber seit einigen Wochen merke ich auch, dass einige Dinge, denen ich bisher keine Beachtung geschenkt habe, anders sind als früher. Zum Beispiel habe ich ziemlich oft Durchfall. Ich dachte erst, das hätte mit Stress zu tun, aber auch in ruhigen Phasen leide ich darunter. Meine Freundin, mit der ich schon seit acht Jahren zusammen bin, hat mich darauf hingewiesen, dass ich dünner geworden sei. Dabei habe ich doch ständig diese Heißhungerattacken. Und meine Nachbarin, deren Hund wir manchmal nehmen, sagte letztes, ich hätte irgendwie Glubschaugen. Ich habe immer schwitzige Hände und überhaupt ist mir dauernd viel zu warm. Manchmal fängt mein Herz plötzlich an, ganz schnell zu schlagen...“ **Stoffwechselaktivierung**

Diagnostik

allgemeine Beschwerden

-e **Müdigkeit** | -e **Erschöpfung** / -e **Fatigue** | -e **Kopfschmerzen** (Pl.) / -e **Cephalgie**
-e **Depression** | -e **Gewichtszunahme** | -r **Gewichtsverlust** | -e **Kälteempfindlichkeit**
-s **vermehrte Schwitzen** / -e **Hyperhidrose** | -r **Haarausfall** / -e **Alopezie**
-e **Verstopfung** / -e **Obstipation** | -r **Durchfall** / -e **Diarrhoe** | -e **kühle + trockene Haut**
-e **stumpfen Haare** (Pl.) | -e **Infektanfälligkeit** | -e **Herzrhythmusstörung** / -e **Arrhythmie**
-r **Bluthochdruck** / -e **Hypertonie** | -e **Schlafstörungen** (Pl.) / -e **Dyssomnie** | -e **Nervosität** |
-e **Zyklusstörungen** (Pl.) | -e **Aggressivität** | -e **Schwellung der Unterhaut** / -s **Myxödem**
-e **Schmerzen** (Pl.) am Hals | -e **Schluckstörung** / -e **Dysphagie** | -s **Globusgefühl**

Inspektion:

- r Kropf / -e Struma: pulsierend
- e gestauten Halsvenen (Pl.)
- r hervortretende Augapfel / -r Exophthalmus

Palpation

-e **Größe** N: tastbar/palpabel, nicht vergrößert
P: vergrößert
-e **Verschieblichkeit** N: schluckverschieblich
P: nicht schluckverschieblich
-r **Schmerz** N: nicht schmerzhaft / indolent
P: (druck)schmerzhaft / druckdoient
-e **Beschaffenheit** (kvam) N: weich
Isymmetrisch
P: derb (siki) | asymmetrisch | knotig (nodulär)
Auskultation: -s Strömungsgeräusch (akim üfürümü)
oder -s Schwirren über der Struma
-s Herzrasen / -e Tachykardie

Labor

-s **Blut:** TSH | T3 -T4 | -e Autoantikörper (Pl.),
Anti Thyreoperoxidase= Anti-TPO, TRAK = TSH-Rezeptor-Antikörper (insbesondere Basedow)
| -r Tumormarker

Apparative Diagnostik

- -r Ultraschall / -e Sonografie | -e Szintigrafie
- -r Röntgen- Thorax
- ggf. -s CT | -s MRT
- -e Feinnadelbiopsie

der Morbus Basedow Symptome: Merseburger Trias: Exophthalmus, Struma und Tachykardie

- Konjunktivitis, Photophobie, Dyssomnie, Gewichtsverlust, Diarrhoe, Dysmenorrhoe, Alopezie
- Unruhe, Reizbarkeit

Ursachen: gesteigerte Hormonproduktion der Schilddrüse durch Antikörper = Hyperthyreose

- keine klare Ursache
- genetische Disposition

Die Szintigrafie

Die Szintigrafie gehört zu den nuklearmedizinischen Untersuchungen und wird deshalb von einem Nuklearmediziner durchgeführt. Mit diesem Verfahren kann man die Aktivität von Geweben darstellen. Dadurch ist es möglich, z.B. Entzündungen zu lokalisieren oder auch auffällige Stoffwechselprozesse nachzuweisen. Vor der Untersuchung wird ein Aufklärungsgespräch geführt. Weitere Vorbereitungen sind in der Regel nicht notwendig. Dem Patienten wird eine radioaktive Substanz injiziert, die Gammastrahlen aussendet. Dieses radioaktive Material sammelt sich im zu untersuchenden Gewebe an. Das dauert bei der Schilddrüse ca. zehn Minuten. Mit einer Gammakamera wird die Strahlung aufgezeichnet und ein Szintigramm erstellt. Bei der Schilddrüsenszintigrafie kann man z.B. „kalte“ von „heißen“ Knoten unterscheiden, die für einen erhöhten bzw. verminderten Stoffwechsel verantwortlich sind. Die Szintigrafie ist schmerzfrei und die Strahlendosis ähnlich belastend wie bei einer Röntgenuntersuchung.

Erkrankungen

- r Kropf (Guatr) / -e Struma
- e Schilddrüsenunterfunktion / -e Hypothyreose
- e Schilddrüsenüberfunktion / -e Hyperthyreose
- r Morbus Basedow
- e Hashimoto-Thyreoiditis
- r Schilddrüsenkrebs / -s Schilddrüsen-Ca

Differenzialdiagnosen

- -e Depression | -e Mangelerscheinung (eksiklik belirtisi)
z.B. Eisenmangelanämie / -e Sideropenie
- -e infektiös bedingte Lymphdrüsenentzündung / -e Lymphadenitis
- -e Herz- Kreislauf- Erkrankungen (Pl.)
- -r Morbus Hodgkin

Therapie

• -s **Jod** | **L-Thyroxin** |
-r **Betablocker** (z. B. Propranolol, Bisoprolol))
| -s **Antiphlogistikum** (NSAR: entzündungshemmend, schmerzlindernd, fiebersenkend) | **Glukokortikoiden**,
Thioamide = **das Thyreostatikum** (z. B. **Thiamazol Carbimazol, Propylthiouracil**) zur Hemmung der Schilddrüsenhormonsynthese.

- -e Radiojodtherapie
- -e operative Knotenentfernung
- -e vollständige o. teilweise Schilddrüsenentfernung / -e (sub)totale Schilddrüsenresektion

HYPOTHYREOSE

Unter einer Hypothyreose versteht man eine Schilddrüsenfunktionsstörung mit einer Unterfunktion von der Schilddrüse.

Die Klassifikation erfolgt nach dem Pathomechanismus in Primäre Hypothyreose, Sekundäre(zentrale) Hypothyreose, subklinische Hypothyreose und Overt Hypothyreose. In den meisten Fällen sind die Hashimoto-Thyreoiditis und Jodmangel dafür verantwortlich.

Als Ätiologie einer Hypothyreose kann man

Autoimmunreaktion (Hashimoto-Thyreoiditis-entzündliche Zerstörung des Schilddrüsengewebes durch Autoantikörper-häufigste Ursache), Jodmangel, iatrogene Ursachen (Bestrahlung, Schilddrüsenoperationen, Medikamente wie Amiodaron oder Lithium) sowie kongenitale Hypothyreose nennen.

Als Risikofaktoren können das weibliche Geschlecht (häufiger bei Frauen), Alter (Zunahme der Prävalenz bei älteren Menschen), Genetische Disposition/Positive Familienanamnese, Bestehende Autoimmunerkrankungen (DM Typ 1, rheumatoide Arthritis, Zöliakie) sowie eine frühere Strahlentherapie im Kopf-Hals-Bereich genannt werden

Die typischen/häufigsten Symptome bei einer

Hypothyreose sind Müdigkeit, Erschöpfung, Kälteintoleranz, Gewichtszunahme trotz unveränderter Kalorienzufuhr, Konzentrationsstörungen, depressive Verstimmung, Bradykardie, niedriger Blutdruck, eventuell periphere Ödeme, Verstopfung, trockene o. schuppige Haut, brüchige Haare und Nägel, unregelmäßiger Zyklus und vielleicht Myxödem.

Zu den wichtigsten Komplikationen gehören

Myxödemkomas, kardiovaskuläre Komplikationen (Hypercholesterinämie, Atherosklerose, Herzinsuffizienz) und Psychische Beeinträchtigungen (wie schwere Depression oder kognitive Einschränkungen).

Differentialdiagnostisch kommen auch Depression, Anämie, Nebennierenrindeinsuffizienz in Betracht.

Die Diagnostik umfasst Anamnese (Abklärung klinischer Symptome), körperliche Untersuchung (bei der Palpation kann man eine Vergrößerung oder Knoten feststellen), Labor (erhöhte TSH-Spiegels, niedrige fT4 und Antikörperbestimmung(anti-TPO, anti-Tg), bildgebende Verfahren (Ultraschall der Schilddrüse und in speziellen Fällen Szintigrafie).

Die medikamentöse Therapie erfolgt mit Levothyroxin. Zur Doseinstellung sind regelmäßige Kontrollen der TSH- und fT4-Werte wichtig.

HYPERTHYREOSE

Unter einer Hyperthyreose versteht man eine Schilddrüsenfunktionsstörung mit einer Überproduktion von Schilddrüsenhormonen. Diese Überaktivität führt zu einer Beschleunigung des Stoffwechsels und einer Vielzahl systemischer Symptome.

Die Klassifikation erfolgt nach dem Pathomechanismus in Morbus Basedow, die subakute Thyreoiditis, die iatrogene Hyperthyreose, Toxisch multinodulärer Struma und das toxische Adenom.

Als Ätiologie einer Hyperthyreose kann man

Autoimmunreaktion(häufigste Ursache-60-80% der Fälle, TSH-Rezeptor-Antikörper), Toxische autonome Knoten, entzündliche Prozesse (Subakute Thyreoiditis), Iatrogene Ursachen (Überdosierung von Schilddrüsenhormonen im Rahmen einer Therapie) sowie genetische Prädisposition nennen.

Als Risikofaktoren können das weibliche Geschlecht (häufiger bei Frauen), Genetische Disposition, Autoimmunvorerkrankungen, Stress, Infektionen sowie eine Vorangegangene Strahlentherapie genannt werden.

Die typischen/häufigsten Symptome bei einer Hyperthyreose

sind Gewichtsverlust, gesteigerter Appetit, vermehrtes Schwitzen, Müdigkeit und Muskelschwäche, Schlaflosigkeit und Nervosität, Angstzustände und Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit, Tachykardie (erhöhter Ruhepuls (über 90/min)), erhöhter systolischer Blutdruck, Hervortreten der Augen(Exophthalmus) und mögliche Doppelbilder.

Zu den wichtigsten Komplikationen gehören thyreotoxische Krise (lebensbedrohlicher Zustand mit hohem Fieber, Delirium und schweren kardialen Komplikationen), Kardiovaskuläre Komplikationen (Vorhofflimmern, Herzinsuffizienz), Osteoporose und Sehstörungen

Differentialdiagnostisch kommen auch Angststörungen, Phäochromozytom und subakute Thyreoiditis (mit vorübergehendem Verlauf und oft schmerzhafter Schilddrüse) in Betracht.

Die Diagnostik umfasst Anamnese (Erfassung von Symptomen wie Gewichtsverlust, Nervosität, Hitzeempfindungen und Herzrhythmusstörungen), körperliche Untersuchung (Suche nach Augenveränderungen (Exophthalmus)), Labor (TSH ist deutlich erniedrigt, fT3 und fT4: meist erhöht, Antikörperbestimmung: Nachweis von TSH-Rezeptor-Antikörpern(TRAK) bei Basedow-Krankheit) sowie bildgebende Verfahren(Ultraschall der Schilddrüse: Beurteilung der Durchblutung und nodulärer Veränderungen, Szintigrafie) und bei Bedarf CT o. MRT.

Sollte sich der Verdacht auf eine Hyperthyreose bestätigen, kommen eine konservative Therapie (Symptomatisch: Betablocker (z. B. Propranolol, Bisoprolol) zur Kontrolle von Tachykardie und Tremor & Therapeutisch: Thioamide (z. B. Carbimazol, Propylthiouracil zur Hemmung der Schilddrüsenhormonsynthese), Radiojodtherapie (bei toxisch-multinodulärem Struma), sowie eine chirurgische Therapie(eine totale oder subtotale Thyreoidektomie) infrage.

Der Stoffwechsel/Der Metabolismus

Anamnese

Aktuellen Beschwerden

1. Sind Sie in letzter Zeit antriebslos?
2. Haben Sie Probleme, sich zu konzentrieren?
3. Haben Sie Herzrasen?
4. Leiden Sie unter Atemnot?
5. Treten die Bauchschmerzen und/oder der Durchfall häufiger auf?
6. Haben Sie Gelenkbeschwerden?
7. Haben Sie Haarausfall bemerkt?

Vegetative

1. Fühlen Sie sich oft schwach oder müde?
2. Sind Sie gestresst?
3. Haben Sie in letzter Zeit ab- oder zugenommen?
4. Haben Sie vermehrt Hunger oder Durst?
5. Schlafen Sie gut?

Vorerkrankungen

1. Sind Ihre Erkrankungen gut unter Kontrolle?
2. Sind Ihre Blutzuckerwerte/ Ihr Blutdruck/ Ihre Blutfette gut eingestellt?
(nicht ausreichend kontrolliert) (schlecht eingestellt)

Ernährung/Unverträglichkeiten

1. Wie ernähren Sie sich?
2. Kochen Sie selbst? (Essen Sie oft Fast-Food?)
3. Essen Sie viel Fleisch?

Familienanamnese

- Sind in Ihrer Familie Diabetes oder andere Stoffwechselerkrankungen bekannt?

Begriffe

Kohlenhydrate (Pl.): -e Kartoffeln (Pl.),-e Milch, -s Getreide(tahıl) , -r Reis, -e Sahne
Eiweiße (Pl.)(das Protein): -e Hülsenfrüchte (Pl.)(baklagiller), -e Milch, -r Fisch, -e Nüsse (Pl.)
Fette (Pl.)(das Lipid): -s Olivenöl, -e Butter
Vitamine (Pl.): -s Retinol, -s Cobalamin, -e Folsäure
Mineralstoffe (Pl.): -s Natrium, -s Kalzium, -s Kalium
Spurenelemente (Pl.): -s Zink, -s Eisen,-s Jod
Hormone (Pl.): -s Adrenalin, -s Insulin, -s Thyroxin
Enzyme (Pl.): -e Protease, -e Amylase, -e Lipase

weißes Fleisch-Geflügel (kümes hayvanları)

rotes Fleisch: kırmızı et

Rindfleisch = siğir eti

Kalbfleisch = dana eti

Lammfleisch = kuzu eti

Schweinefleisch = domuz eti

der Zeh=die Zehe –Pl: Zehen

Spinat (ispanak) Feldsalat (kuzu marulu). Rote Bete

(pancar), Vollkornbrot (tam tahıllı ekmek), Joghurt,

Innereien (sakatat), Rosinen (kuru üzüm)

Purinarme Ernährung

1. Mg :-s Magnesium
2. Ca : -s Kalzium
3. K: -s Kalium
4. Na: -s Natrium
5. Fe: -s Eisen
6. Zn: -s Zink
7. Cu: -s Kupfer
8. Se: -s Selen

Vitamin A = -s Retinol

Vitamin B12 = -s Cobalamin

Vitamin C =-e Ascorbinsäure

Vitamin D3 =-s Cholecalciferol

Vitamin E = -s Tocopherol

Vitamin K=-s Phyllochinon

-r **Anabolismus:** Erneuerung von Gewebe und

Muskelbildung

-r **Katabolismus:** Energiegewinnung aus körpereigenen Ressourcen

-r **Eiweißstoffwechsel:** Abbau zu Aminosäuren in Magen und Dünndarm

-r **Kohlenhydratstoffwechsel:** Aufnahme, Transport und Abbau von bspw. Glukose

-r **Fettstoffwechsel:** Speicherung von Lipiden in den Körperzellen zur Energiegewinnung

-r **Mineralstoffwechsel:** Bereitstellung der Stoffe für verschiedene Aufgaben, z.B. für Hormone, Knochenbau u.a.

Aufnahme: alım, emilim

Speicherung: depolama

Bereitstellung: sağlamak, hazırda bulundurmak

Diagnostik

allgemeine Beschwerden

-e Müdigkeit I -e Erschöpfung/-e **Fatigue** I -e Kopfschmerzen (Pl.)/-e **Cephalgie**
-e **Infektanfälligkeit** I -r Haarausfall/-**Alopezie** I -e Wundheilungsstörung
-e Übelkeit/-e **Nausea** I -r Durchfall/-e **Diarrhoe** -e Windabgang/e **Flatulenz**
-r Blähbauch/-r **Meteorismus** I -e **Gewichtszunahme** I -r **Gewichtsverlust** I
-s Herzrasen/-e **Tachykardie** I -e Atemnot/-e **Dyspnoe** I -e Schlafstörungen (Pl.)/
-e **Dyssomnie** I -r übermäßige Durst/-e **Polydipsie** I -e erhöhte Urinmenge/-e **Polyurie** I
-s nächtliche Wasserlassen/-e **Nykturie**
Leistungabfall: Ich kann nicht meine tägliche Aufgaben erledigen./Ich kann meinen Alltag nicht mehr bewältigen.

Inspektion:

(-e Haut, -e Schleimhaut und -e Bindehaut)
N: dem Hauttyp entsprechend, rosig
P: blass
-r Hauteinriss/-e Rhagade o. -e Fissur
die Landkartenzunge/-e Lingua geographica
-e **Nägel (Pl.)**
P: brüchig I -e Längsrillen (Pl.): boyuna çizgi I
-e Querrillen (Pl.): enine çizgi
-s **Gelenk**
P: geschwollen I gerötet

Palpation

-s Gelenk schmerzhaft I überwärmt

Auskultation(-s Herz):

-s Herzrasen/-e Tachykardie

Labor

-s **Blut:** Hb I Ferritin(Das Speichereisen) I
Transferrin I Vitamin B12 I
Vitamin D I TSH I T3 I T4 I IgA I
Harnsäure
• -r Nüchternblutzucker I
- r Glukosetoleranztest
I HbA1c(Langzeitzucker)
-r Laktosetoleranztest

Apparative Diagnostik

- -r H2-Atemtest
- -e ÖGD
- -s Röntgen

Der H2-Atemtest

Durch die Messung der Wasserstoff- Konzentration in der Atemluft kann eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, z.B. Laktoseintoleranz, nachgewiesen werden Infolge der Zersetzung von .unverdaulichem Zucker im Dickdarm leiden die Patienten unter starken Darmbeschwerden. Bei diesem Prozess entsteht Wasserstoff, der mit dem Atem ausgeschieden wird. Für den Nachweis einer Intoleranz oder Malabsorption sollte der Patient mindestens zwölf Stunden nüchtern sein. Ein Basalwert der Atemluft wird mit einem speziellen Messgerät bestimmt. Anschließend trinkt der Patient eine Lösung mit dem entsprechenden Zucker. In regelmäßigen Abständen(düzenli aralıklarla) werden Atemproben durchgeführt. Gelegentlich kommt es zu falschen Testergebnissen. Trotz negativen Resultats kann eine Unverträglichkeit vorliegen, da sich bei einigen Menschen keine wasserstoffproduzierenden Bakterien im Darm befinden.

Der Glukosetoleranztest

Bei Verdacht auf DM sollte ein Glukosetoleranztest durchgeführt werden. Das Prinzip des Tests ist ganz einfach: Mittels Zufuhr(verilime) von Glukose wird Insulin im Pankreas freigesetzt(salgılamak). Die Folge ist eine erhöhte Aufnahme von Glukose in den Organen. Zur optimalen Durchführung des Tests muss sich der Patient an einige Regeln halten.(sich an Regeln halten: kurallara uymak) Zum Beispiel sollten alltägliche Aktivitäten und Ernährungsgewohnheiten vor dem Test nicht geändert werden. Gegebenenfalls müssen Medikamente abgesetzt werden, z.B. Schilddrüsenhormone. Vor der ersten Blutabnahme für die Basalwert-Bestimmung sollte der Patient ca. zwölf bis 16 Stunden nüchtern sein. Anschließend trinkt der Patient eine Glukoselösung und nach ein bzw. zwei Stunden erfolgen weitere Blutabnahmen. Aufgrund der möglichen Verfälschung des Testergebnisses durch weitere Faktoren wie Vorerkrankungen u.a. sollte die Vorgeschichte des Patienten sorgfältig abgeklärt werden.

Erkrankungen

- e Blutarmut/-e Anämie I -e Eisenmangelanämie/-e Sideropenie
- e Vitamin-B12-Mangelanämie/-e perniziöse Anämie I -r Vitamin-D-Mangel
- -e Zuckerkrankheit/-r Diabetes mellitus Typ I o. Typ II
- -e erhöhten Harnsäurewerte (Pl.) im Blut/-e Hyperurikämie I
- e Gicht/-e Arthritis urica
- Podagra: der Gichtanfall in der großen Zehe(=im großen Zeh)
- -e Milchzuckerunverträglichkeit/-e Laktoseintoleranz
- -e Glutenunverträglichkeit/-e Zöliakie o. -e Sprue

Differenzialdiagnosen

- -e weiteren Unverträglichkeiten (Pl.)
- -e endokrinologischen Erkrankungen (Pl.)
- -e neurologischen Erkrankungen (Pl.)
- -e Erkrankungen der inneren Organe (Pl.)

Therapie

- -e Ersatztherapie/-e Substitutionstherapie
- -s Schmerzmittel/-s Analgetikum
- -s Antidiabetikum I -s Urikostatikum I -s Kortison/-s Glukokortikoid
- s Colchicin I -e Laktase
- -e Ernährungsumstellung I -e Änderung des Lebensstils

Diabetes mellitus

Definition: • Diabetes mellitus ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, die durch einen relativ oder absoluten Insulinmangel und/oder eine Insulinresistenz gekennzeichnet ist. Dies führt zu dauerhaft erhöhten Blutzuckerwerten(Hyperglykämie), die mit Funktionsstörungen an verschiedenen Organen assoziiert sind (z. B. Herz, Niere, Netzhaut, Nervensystem).

Ätiologie: Genetische Faktoren: Eine familiäre Vorbelastung spielt eine wesentliche Rolle (z. B. bei Typ-2-Diabetes ist ein genetisches Dispositiv vorhanden).

- Autoimmunprozesse: Bei Typ-1-Diabetes führt die autoimmune Zerstörung der Beta-Zellen in den Langerhans-Inseln der Bauchspeicheldrüse zum absoluten Insulinmangel.
- Lebensstilfaktoren: Ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und Übergewicht tragen vor allem zur Entstehung des Typ-2-Diabetes bei.
- Umweltfaktoren und Infektionen: Virale Infektionen (z. B. Coxsackie-Virus) können, durch einen Triggermechanismus, autoimmune Prozesse begünstigen (vorwiegend bei Typ-1-Diabetes).

Risikofaktoren: Übergewicht und Adipositas, insbesondere viszerales Fett, erhöhen das Risiko für Typ-2-Diabetes signifikant.

- Bewegungsmangel: Ein sitzender Lebensstil ist ein wesentlicher Risikofaktor.
- Genetische Disposition: Eine positive Familienanamnese (z. B. Eltern oder Geschwister mit Diabetes) vermehrt das Risiko
- Alter: Das Risiko für einen Typ-2-Diabetes, insbesondere ab 45 Jahren.
- Ethnische Zugehörigkeit: Menschen aus bestimmten ethnischen Gruppen (z.B. Südasiaten, Afroamerikanern) haben ein erhöhtes Risiko.
- Schwangerschaftsdiabetes: Frauen, die während der Schwangerschaft einen Gestationsdiabetes entwickelten, haben ein erhöhtes Risiko, später einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln.

Klassifikation• Typ-1-Diabetes (juvener Diabetes): Autoimmunerkrankung mit Zerstörung der insulinproduzierenden Beta-Zellen (häufig im Kindes- und Jugendalter).

- Typ-2-Diabetes (adultonaler Diabetes): Beginnt meist im Erwachsenenalter; charakterisiert durch Insulinresistenz kombiniert mit einer relativen Insulinsekretionsstörung.
- Gestationsdiabetes: Diabetesfirstellung während der Schwangerschaft, der nach der Geburt meist zurückgeht, jedoch ein Risikofaktor für die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes darstellt.
- Sonstige spezifische Formen: z. B. MODY

Klinische Informationen

- Polyurie: Häufiges Wasserlassen (verursacht durch osmotische Diurese).
- Polydipsie: Starker Durst als Folge der Dehydration.
- Gewichtsverlust: Vor allem bei Typ-1-Diabetes aufgrund von unzureichendem Glukosestoffwechsel.
- Müdigkeit und Schwäche: Allgemeine Erschöpfung, verringerte Leistungsfähigkeit.
- Verschwommenes Sehen: Osmotische Veränderungen im Auge können zur Sehbeeinträchtigung führen.
- In schweren Fällen (z. B. diabetische Ketoazidose): Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und respiratorische Kompensation (Kussmaul-Atmung).

Differentialdiagnose : Typ-1-Diabetes vs. Typ-2-Diabetes:

- Typ-1-Diabetes manifestiert sich oft bei jüngeren Patienten mit plötzlichem Beginn und Insulinmangel; Typ-2-Diabetes tritt meist schleichend im höheren Lebensalter auf und ist mit Insulinresistenz verbunden.
- Phäochromozytom: Bluthochdruck und Schwitzen sind dominante Symptome; Hormonanalysen (Katecholamine, Metanephrene) helfen bei der Unterscheidung.
- Schilddrüsenüberfunktion kann ebenfalls zu Hyperglykämie führen)
- Diagnostik** Nüchternblutzucker > 126 mg/dl (≥7,0 mmol/l) als Richtwert.
- oraler Glukosetoleranztest (OGTT): 2-Stunden-Blutzucker > 200 mg/dl (≥11,1 mmol/l) bestätigt die Diagnose.
- HbA1c-Wert ≥ 6,5% (langfristige Blutzuckerkontrolle).
- Therapie:** Lebensstiländerungen: Gewichtsreduktion, eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität
- Therapeutische Maßnahmen:
- Bei Typ-2-Diabetes: Orale Antidiabetika (z. B. Metformin, Sulfonylharnstoffe, DPP-4- Hemmer, SGLT2-Inhibitoren, GLP-1-Analoga).
- Bei Typ-1-Diabetes: Insulintherapie (Basal- und Bolusinsulin-Regime).
- Chirurgische Therapie: Bariatrische Chirurgie: Vor allem bei adipösen Patienten mit Typ-2-Diabetes kann eine Magenbypass-Operation (Roux-en-Y-Magenbypass) oder eine Sleeve-Gastrektomie zu einer signifikanten Verbesserung oder Remission der Erkrankung führen.
- Komplikationen** • Mikroangiopathie: Diabetische Retinopathie (Gefäßschäden), Nephropathie und Neuropathie.
- Makroangiopathie: Erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen wie koronare Herzkrankheit, zerebrovaskuläre Insulte und periphere arterielle Verschlusskrankheit.
- Diabetische Ketoazidose: Akuter, lebensbedrohlicher Zustand, meist bei Typ-1
- Infektionen: Patienten haben ein erhöhtes Risiko für Haut-, Harnwegs- und Atemwegsinfektionen.

die Gicht

- Stoffwechselstörung
- erhöhte Harnsäure- Konzentration im Blut

Ursachen:

- purinreiche Ernährung (Innereien, Wurst, Alkohol)
- Harnsäure entsteht beim Abbau von Purinen
- Nieren scheiden zu wenig Harnsäure aus

Symptome:

- plötzliche Schmerzzacken in einem Gelenk
- Gelenk = geschwollen, gerötet, berührungsempfindlich
- Kopfschmerzen, Fieber

Folgen bei unzureichender(vetersiz) Behandlung:

- Gicht-Tophi = Schwellung durch Bildung von Harnsäurekristallen im Gelenk
- Knochenschäden, Nierensteine, Nierenversagen

Hypoglykämie

Definition: Hypoglykämie bezeichnet einen Zustand, bei dem der Blutzuckerspiegel unter den physiologisch notwendigen Wert sinkt (in der Regel unter 70 mg/dl oder 3,9 mmol/l), was zu einer Reihe von metabolischen und neurologischen Symptomen führt. Dieser Zustand kann akut auftreten und lebensbedrohlich werden, wenn er nicht zeitnah behandelt wird.

Ätiologie: **Insulintherapie-Fehler**(Überdosierung von Insulin), **Medikamenteninduzierte Hypoglykämie:** Einsatz von sulfonylharnstoffen, Unzureichende Nahrungsaufnahme: Verlängerte Fastenperioden oder ausbleibende Mahlzeiten können, besonders in Kombination mit antidiabetischer Medikation, **Alkoholinduzierte Hypoglykämie:** Alkohol hemmt die Glukoneogenese in der Leber und kann in Kombination mit unzureichender Nahrungsaufnahme zu einem kritischen Abfall des Blutzuckers führen.

Seltene endokrine Tumoren (z.B. Insulinom): Überproduktion von Insulin.

Risikofaktoren: Diabetes mellitus (vor allem Typ-1-Diabetes) und **fehlerhafte Insulindosierung** erhöhen das Risiko signifikant.

- **Fortgeschrittenes Alter** und eingeschränkte Nierenfunktion können die Clearance von Insulin reduzieren und zur Hypoglykämie beitragen.
- **Alkoholmissbrauch** (durch Hemmung der Glukoneogenese) und unregelmäßige Mahlzeiten können als weitere Risikofaktoren identifiziert werden.
- **Intensive sportliche Betätigung** ohne entsprechende Anpassung der Nahrungsaufnahme und Medikation.
- **Vorangegangene Episoden von Hypoglykämie**

Klassifikation:

- **Schweregradeinteilung nach Schwere der Symptome:**
- **Leichte Hypoglykämie:** Symptome sind oft autonom (z.B. Zittern, Schwitzen) und kognitiv moderat beeinträchtigt.
- **Mittlere Hypoglykämie:** Stärkere Ausprägung der autonomen Symptome mit beginnender neuroglykotischer Symptomatik (z.B. Verwirrtheit, Heißhunger, Sehstörungen).
- **Schwere Hypoglykämie:** Bewusstlosigkeit, Krampfanfälle oder Koma, was eine Notfallbehandlung erfordert.

Klinische Informationen: **Autonome Symptome:** Zittern, Schwitzen, Herzklopfen, Angst, und erhöhter Adrenalinausstoß (sympathoadrenerge Reaktion auf niedrigen Blutzucker).

- **Neuroglykotische Symptome:** Verwirrtheit, Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Sprachstörungen und in schweren Fällen Krampfanfälle oder Bewusstseinsverlust (Hinweis auf eine unzureichende Glukoseversorgung des Gehirns).
- **Allgemeine körperliche Beschwerden:** Heißhunger, Schwächegefühl

Differentialdiagnose: Hyperventilation oder Panikattacken: Während Panikattacken ähnliche Symptome wie Zittern und Schwitzen hervorrufen können, fehlt bei diesen in der Regel der kritische Blutzuckerabfall)

- Epileptische Anfälle:
- Unterschiede: Krampfanfälle bei Hypoglykämie gehen oft einher mit begleitenden autonomen Symptomen (Schwitzen, Herzrasen) und Normalbefund im EEG.
- Intoxikationen (z.B. Beta-Blocker-Überdosierung): Die Herzfrequenz ist oft niedriger und mangelnde adrenerge Aktivität ist typisch.
- Insulinom: Biochemie-Tests (z.B. erhöhte Insulin- und C-Peptidwerte).

Addison-Krankheit: Chronische Nebenniereninsuffizienz kann ebenfalls zu Hypoglykämie führen, geht aber häufig mit weiteren Hinweisen wie Hyperpigmentierung und Elektrolytstörungen einher.

Diagnostik:

- **Anamnese:** Detaillierte Befragung zu Insulin- oder Antidiabetikamedikation, Nahrungsaufnahme, Alkoholkonsum und körperlicher Aktivität.
- **Körperliche Untersuchung:** Kontrolle der Vitalparameter (Puls, Blutdruck) und neurologischer Status (Bewusstseinslage, Orientierung).
- **Labordiagnostik:** Blutglukosemessung (kritischer Wert unter 70 mg/dl).
- Messung von Insulin und C-Peptid
- Elektrolytstatus und Leberparameter (zur Beurteilung von mitverursachenden Faktoren wie Alkoholintoxikation oder Leberinsuffizienz).
- **Provokationstests** (z.B. Fastentest) bei Verdacht auf Insulinom
- **Bildgebung:** Sonographie oder CT (bei Verdacht auf Insulinom)

Therapie: Sofortige Zufuhr von schnellwirksamen Kohlenhydraten (z.B. 15-20 g Glukose in Form von Traubenzucker) oral oder intravenös (bei Bewusstlosigkeit).

- Überwachung des Blutzuckerspiegels bis zur Normalisierung.
- Therapeutische Maßnahmen: Anpassung der medikamentösen Therapie (z.B. Korrektur der Insulindosis oder Wechsel der antidiabetischen Medikation).
- Schulung der Patienten hinsichtlich Ernährung und Selbstüberwachung der Blutzuckerwerte.
- Einsatz von Glukagon (intramuskulär) bei schwerer Hypoglykämie
- Bei Insulinomen: Operative Resektion des Tumors

Die Haut/ Die Cutis

Anamnese

Aktuellen Beschwerden 1. Haben Sie Fieber? 2. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? 3. Gibt es einen Auslöser? 4. Ist der Ausschlag plötzlich aufgetreten? 5. Hat sich der Fleck/Ausschlag in der letzten Zeit verändert? 6. Können Sie den Ausschlag beschreiben? 7. Nässt der Ausschlag? 8. Juckt es? 9. Was verbessert oder verschlechtert die Beschwerden? 10. Haben Sie weitere Beschwerden, z.B. Gelenkschmerzen? 11. Hatten Sie die Beschwerden früher schon einmal?	Ernährung / Lebensgewohnheiten / Sexualverhalten 1. Wie ernähren Sie sich? 2. Haben Sie ein neues Pflegeprodukt benutzt? 3. Haben Sie das Waschmittel gewechselt oder neue Kleidung gekauft? 4. Sonnen Sie sich oft? 5. Welchen Lichtschutzfaktor benutzen Sie? 6. Haben Sie häufig wechselnde Sexualpartner?	Vorerkrankungen / Allergien 1. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? 2. Haben Sie Allergien? Familienanamnese/ Sozialanamnese 1. Gibt es in Ihrer Familie Hauterkrankungen? 2. Was machen Sie beruflich?
--	--	---

Diagnostik

allgemeine Beschwerden	-r Hautausschlag/-s Exanthem -r Schleimhautausschlag/-s Enanthem -e Hautveränderung/-e Effloreszenz -e Verletzung/-e Läsion -e Rötung/-r Rubor -e Schwellung/-r Tumor -r Juckreiz/-r Pruritus -r Schmerz/-e Algie -e gutartige Geschwulst aus Bindegewebe/-s Fibrom -e Warze/-e Verruca bei allergischer Ursache zusätzlich eventuell Luftnot/-e Dyspnoe und/oder Husten/e Tussis
-------------------------------	---

Inspektion

Hautfarbe → Cilt rengi Kopfhaut → Saçlı deri Nägel (Pl.) → Tırnaklar Schleimhäute (Pl.) → Mukozalar Physiologisch :rosig bzw. dem Hauttyp entsprechend (Pembe / kişinin cilt tipine uygun) Palpation: -e Läsion: erhaben (kabarık)/ flach (düz)	Pathologisch Renk değişiklikleri blass → Soluk fahl → Mat, cansız bläulich verfärbt → Morarmış (siyanoz) gerötet → Kızanık hochrot → Yoğun kırmızı Kanama bulguları Bluterguss / Hämatom → Morluk, hematom Kapillarblutungen / Petechien → Noktasal kanamalar-peteşi	Hautveränderungen (Cilt değişiklikleri) Ausschlag / Exanthem → Döküntü Enanthem → Mukozada döküntü juckflechte / Ekzem → Egzama, kaşıntılı lezyon Haarausfall / Alopezie → Saç dökülmesi Verletzung / Läsion (Lezyon değerlendirme) Art → Türü Konfiguration → Şekli Beschaffenheit → Yapısı / karakteri Verteilung → Dağılımı Farbe → Rengi
---	--	--

1. –**e Pustel** : Vesikel mit Eiter, bei bakteriellen Infektionen und entzündlichen Störungen

2. –**e Papel**: erhabene Knötchen < 10mm, tastbar, zB: Lipome, Fibrome

3. –**e Macula**: flach, nicht tastbar, <10mm Durchmesser, depigmentiert o. Hyperpigmentiert, z.B. Sommersprossen(gil), Muttermale(doğum lekesi), Tattoos

4. –**e Plaque**: tastbare Läsionen >10mm, über Hautniveau, flach oder rundlich, z.B. bei Psoriasis

5. –**e Vesicula** :flüssigkeitsgefüllte Bläschen, z.B: bei Herpes

Labor

-sBlut: Gesamte

•-r Patch-Test, -rPrick-Test

•-e Hautkultur (-sGeschabsel)

Apparative Diagnostik

-e Gewebeentnahme/-e Biopsie

•-e Dermatoskopie -ediagnostische Exzision

Brandwunde → Yanık yarası Isı, kimyasal veya elektrik
Schürfwunde → Sıyrık (abrazyon) sürtünmeyle
Bisswunde → Isırık yarası
Schnittwunde → **Kesik (insizyon)** Keskin bir cisimle
Stichwunde → **Delici yara (ponksiyon)** Sivri bir cisimle
Platzwunde → **laserasyon, künt travma(örneğin kafa çarpması).**

Primäreffloreszenzen

- Der Fleck: Macula
- Die Quaddel: Urtika
- Die Bläschen: Vesicula
- Die Eiterblase: Pustula
- Die Blase: Bulla (bül)
- Die Zyste: Zystis
- Der Knoten:Tuberculum
- Das Knötchen: Papula

Sekundäreffloreszenzen

- e Schuppe: Squama-kepek
- e Pigmentierung: Pigmentatio
- s Geschwür: Ulcus-ülser
- r Gewebsschwund: Atrophia
- .oberflächlicher Epithelverlust: Erosio
- e Hautabschürfung: Excoriatio

Erkrankungen

-e Hautentzündung/-e Dermatitis * -e Juckflechte/-sEkzem

•-e Neurodermitis/-e atopische Dermatitis o. –e Dermatitis atopica

•-e Gürtelrose/-r Herpes Zoster * -r Lippenherpes/-r Herpes simplex

•-r Nesselausschlag o. –e Nesselsucht/-e Urtikaria

•-eSchuppenflechte/-e Psoriasis * -e Wundrose/-s Erysipel

•-e Knotenrose/-sErythema nodosum

•-r Pilzbefall/-e Candidose o. -eMykose * -e Weißfleckenkrankheit /-e Vitiligo

•-r weiße Hautkrebs/-s Basalzellkarzinom

•-r schwarze Hautkrebs /-s Melanom

Differenzialdiagnosen

-**e endokrinologischen Erkrankungen** (Pl.), z.B. –r DM –r Morbus Addison

-e Beinvenenthrombose/-e Thrombophlebitis o. –e Phlebothrombose

-r Tripper/-e Gonorrhoe * -e Hirnhautentzündung/-e Meningitis //-e Granulomatose
–e Sarkoidose

-e systemischen Erkrankungen (Pl.) ///-e allergische Reaktion/-eAnaphylaxie

Therapie

-e Lokalthherapie: -e Salbe –s Gel –r Puder -e Creme -e Tinktur

•-e systemische Therapie: -sAntibiotikum I-sAntihistaminikum –s Antimykotikum –s Kortison/-sGlukokortikoid

• mechanisch bzw. operativ: -eäußere Abtragung der Hautveränderung

•-eLichttherapie I-eErnährungsumstellung I-eÄnderung des Lebensstils

• ggf. -ePsychotherapie

VERBEN

Düşme (Sturz)

fallen – *fiel* – **ist gefallen** → düşmek

herunterfallen / runterfallen – *fiel herunter* – **ist heruntergefallen** → aşağı düşmek

hinfallen – *fiel hin* – **ist hingefallen** → yere düşmek

umfallen – *fiel um* – **ist umgefallen** → devrilmek

abstürzen – *stürzte ab* – **ist abgestürzt** . →yüksekten düşmek

stürzen : Ich bin gestern auf der Straße gestürzt. → Dün sokakta düştüm.

hinfallen: Ich bin die Treppe hinuntergefallen. → Merdivenden düştüm.

umfallen: Mir wurde plötzlich schwindelig und ich bin umgefallen. → Birden başım döndü ve yere yığıldım.

ausrutschen: Ich bin im Badezimmer auf dem nassen Boden ausgerutscht. → Banyoda ıslak zeminde kaydım.

stolpern: Ich bin über eine Bordsteinkante gestolpert. → Kaldırıma takılıp sendeledim.

abstürzen: Ich bin von einer Leiter etwa zwei Meter tief abgestürzt. → Yaklaşık iki metre yükseklikteki merdivenden düştüm.

stürzen (stürzte/ gestürzt)= düşmek / devrilmek/kaza geçirme

Der Patient **ist** mit dem Fahrrad **gestürzt**.

Der Patient **stürzte auf** die rechte Schulter.

Ich **bin** beim Joggen **gestürzt**.

Ich **bin** gestern auf der Treppe **hingefallen**.

Er **ist** vom Dach **heruntergefallen**.

Ich **bin** von der Leiter **runtergefallen**.

Der Patient **ist** etwa drei Meter **abgestürzt**.

Das Fahrrad **ist umgefallen**

Ich **habe das Gleichgewicht verloren** und **bin hingefallen**.

Üzerine bir şey düşmesi, devrilmesi=

etwas auf jemanden fallen, auf jemanden stürzen, umkippen

Ein Ast ist auf mich gefallen. (*der Ast: dal*) // Ein Stein ist auf meinen Fuß gefallen.

Ein Schrank ist auf ihn gestürzt. // Ein Regal ist auf die Patientin umgekippt.

Takılmak:

stolpern [über]/ ist gestolpert Ich bin **über** ein Kabel gestolpert.

Kaymak

rutschen (rutschte, ist gerutscht): Genel olarak kaymak, kayarak hareket etmek. Kaygan olmak zorunda değildir.

ausrutschen (rutschte aus, ist ausgerutscht): Kaygan bir zeminde ayağın kayması. Genellikle su, buz, yağ, sabun vb. kaygan zemin.

ausrutschen auf -> Eis, Glatteis, Schnee, einer vereisten Straße, Fliesen, nassem Boden, Seifenwasser, Öl, einer Bananenschale **wegrutschen (rutschte weg, ist weggerutscht)**: ayağın/elinin altından desteğin kayması, yol tutuşunu kaybetmesi

abrutschen (rutschte ab, ist abgerutscht): nach unten, genellikle yükseklik, merdiven, çatı, kaya veya alet üzerinden kayma

Der Patient ist **auf** Eis ausgerutscht. / Ich bin **auf** dem nassen Boden ausgerutscht. / Ich bin **auf** einer Eisfläche ausgerutscht.

Mein rechter Fuß ist plötzlich **weggerutscht**. / Die Leiter ist **weggerutscht**.

Der Patient ist von der Leiter **abgerutscht**. / Er ist vom Dach **abgerutscht**. / Beim Klettern ist er am Felsen **abgerutscht**. **Klettern: tırmanmak, Felsen: kaya**

Das Kind rutscht die Rutsche hinunter. / Der Patient rutschte die Böschung hinunter.

Untergrund, etc.

• Auf welchem Untergrund sind Sie gestürzt?

○ Draußen

- das Gras, die Wiese (çim, çayır)
- das (nasse) Laub (ıslak yaprak)
- der Sand (kum)
- der Kies (küçük taşlar)
- der Schotter (kırmı taş)
- das Kopfsteinpflaster (Arnavut kaldırımı)

○ Drinnen

- die Fliesen (fayans)
- der Stein, der Steinboden (taş zemin)
- das Marmor, der Marmorboden (mermer zemin)
- die Treppe, das Geländer (korkuluk), die Wendeltreppe (spiral merdiven), die Treppenstufe (merdiven basamağı)

- der Asphalt → das Schlagloch (asfalttaki çukur)
- der Beton, Zement (çimento-beton)
- der Schnee
- die Pfütze (su birikintisi)
- der Schlamm, der Matsch (çamur)
- das Eis (buz), vereist (buzlanmış), glatt (kaygan)

- das Holz, der Holzboden (ahşap zemin/parke)
- der Teppich, der Teppichboden (halı)

Unfall-Trauma-Orthopädie

Burkulma ve Dönme

verdrehen: Ich habe mir beim Sport das Knie verdreht. → Spor yaparken dizimi burktum.

sich verrenken: Ich habe mir die Schulter verrenkt. → Omzumu çıkardım/incittim.

umknicken (knickte um/ ist umgeknickt): ayağın burkulması, dönmesi ! knicken: bir şeyi bükmek, katlamak (kağıt, dal vb.)
Ich bin mit dem rechten Fuß umgeknickt. → Sağ ayağım döndü.

sich verstauchen (hat sich verstaucht): Burkulma sonucu eklem bağlarının zedelenmesi, incinme (tıbbi sonuç)

Ich **bin** beim Fußball mit dem rechten Fuß nach innen/außen **umgeknickt**.

Der Patient **ist** auf unebenem Boden **umgeknickt**. (unebenem: engebeli)

Ich **habe mir** den Knöchel **verstaucht**.

Yuvarlanmak

rollen(rollte/ist gerollt)

herunterrollen (rollte herunter/ ist heruntergerollt)

Ich bin den Hang heruntergerollt. (**der Hang: yamaç, eğim**) // Der Stein ist den Berg heruntergerollt.

Çarpma (Anprall)

gegen etw. stoßen – stieß – ist gestoßen → çarpmak

gegen etw. prallen – prallte – ist geprallt → çarpmak

zusammenstoßen – stieß zusammen – ist zusammengestoßen → çarpışmak

kollidieren – kollidierte – ist kollidiert → araç çarpışması / çarpışmak

sich anstoßen. Ich habe mir den Kopf am Schrank angestoßen. → Başımı dolaba çarptım.

gegen etwas stoßen. Mit dem Fahrrad bin ich gegen einen Pfosten gestoßen. → Bisikletle direğe çarptım.

zusammenstoßen. Ich bin beim Fußball mit einem anderen Spieler zusammengestoßen. → Futbol oynarken başka bir oyuncuyla çarpıştım.

aufprallen. Ich bin auf die rechte Schulter aufgeprallt. → Sağ omzumun üzerine düştüm.

sich an etwas stoßen (sich + Akkusativ (vücut kısmı) + an + Dativ)

gegen etwas stoßen (Bir şeye çarpmak (özne vücudu veya nesneyle birlikte)). (mit einem Körperteil +stoßen gegen + etwas/Akk)

gegen etwas prallen (plötzlich+stärker)

aufprallen (prallte auf, ist aufgeprallt): çarpma /Das Auto ist auf einen Baum aufgeprallt.

zusammenprallen(prallte zusammen, ist zusammengprallt): çarpışma /Der LKW ist mit einem PKW zusammengprallt.

Das Auto **ist gegen** einen Baum **geprallt**.

Zwei Autos **sind frontal zusammengestoßen**.

Ich **bin** mit einem Fahrradfahrer **zusammen gestoßen**.

Ich **habe mich** (mit dem Kopf) an der Wand **gestoßen**.

Ich **habe mir** den Kopf an der Wand **gestoßen**.

Ich **bin** mit dem Kopf gegen die Wand **gestoßen**.

Das Auto **ist gegen** eine Leitplanke **gestoßen**.

Ich **bin** mit dem Kopf **gegen** den Türrahmen **gestoßen**. (**der Türrahmen: kapı çerçevesi**)

Der Patient **ist** mit dem Kopf **gegen** die Windschutzscheibe **gestoßen**. (**die Windschutzscheibe: ön cam**)

Wogegen sind Sie gestoßen?

- | | | |
|--|---|---------------------------------------|
| • der Hydrant → yangın musluğu | • die Straßenlaterne → sokak lambası direği | • das Schlagloch → yol çukuru |
| • der Gartenzaun → bahçe çiti | • der Baum → ağaç | • die Leiter → merdiven (taşınabilir) |
| • die Bordsteinkante → kaldırım kenarı | • die Mauer → duvar | • das Gerüst → iskele |
| • der Gullydeckel → rögar kapağı | • die Treppenstufe → merdiven basamağı | • die Eisfläche → buzlu zemin |
| • der Pfosten → direk | • das Gelände → korkuluk | |
| • die Leitplanke → yol kenarı bariyeri | • die Türschwelle → kapı eşiği | |

Trafik kazası

anfahren(fuhr an / hat angefahren): Birine/bir şeye araçla çarpmak, temas etmek. (jemanden/etwas anfahren)

überfahren(überfuhr /hat überfahren): ezmek, üzerinden geçmek

umfahren: 1) çarpıp devirmek: umfuhr / hat umfahren

2) son anda çarpmamak, etraftan dolaşmak: fuhr um / ist umfahren

erfassen(erfasste/ hat erfasst): büyük kuvvetle çarpması, onu savurması veya önüne alması.

einen Unfall haben: Ich hatte gestern einen Autounfall. → Dün trafik kazası geçirdim.

angefahren werden: Ich wurde von einem Auto angefahren. → Bana araba çarptı.

zusammenprallen: Die beiden Autos sind frontal zusammengeprallt. → İki araç kafa kafaya çarpıştı.

von der Fahrbahn abkommen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab. → Araç yoldan çıktı.

Unfall-Trauma-Orthopädie

Ein Auto **fuhr** ein Kind auf dem Zebrastreifen **an**. (**der Zebrastreifen: yaya geçidi**)

Ein LKW **fuhr** den Radfahrer **an**.

Der Patient **wurde** von einem Auto **angefahren**.

Der Fuß des Patienten **wurde** von einem Auto **überfahren**.

Ein Fußgänger **wurde überfahren**. (**Fußgänger: yaya**)

Der Radfahrer **wurde** von einem Auto **umfahren**.

Der Pkw **hat** einen Poller **umfahren**. (**der Poller: direk şeklindeki bariyer**)

Wegen der Baustelle **ist** er das Hindernis **umgefahren**.

Der Radfahrer **wurde** von einem LKW **erfasst**.

Der Radfahrer **wurde** frontal von einem Pkw **erfasst**. (**PKW: otomobil**)

Ezilme ve Sıkışma

quetschen: ezmek Ich habe mir den Finger in der Tür gequetscht. → Parmağımı kapıda ezdim.

Mein Fuß wurde von einem Auto gequetscht

einklemmen: sıkıştırmak Meine Hand wurde zwischen zwei Maschinen eingeklemmt. → Elim iki makine arasında sıkıştı.

Ich habe mir den Finger im Türscharnier eingeklemmt. → Parmağımı kapı menteşesine sıkıştırdım.

Kesici Yaralanmalar

schneiden : kesmek Ich habe mich am Messer geschnitten.

sich schneiden. Ich habe mich beim Kochen am Messer geschnitten. → Yemek yaparken bıçakla elimi kestim.

sich verletzen: Ich habe mich bei der Gartenarbeit verletzt. → Bahçede çalışırken yaralandım.

stechen: batırmak, sokmak Er wurde mit einem Messer in den Bauch gestochen. → Karnından bıçaklandı.

durchbohren: delmek Ein Metallstück hat den Oberschenkel durchbohrt.

Isırmak **beißen (hat gebissen)** Ich wurde von einem Hund gebissen.

Kırık ve Çıkık

brechen (ist gebrochen): kırılmak, kırılmak **!!brechen**, umgangssprachlich bazen kusmak anlamında kullanılır

sich etwas brechen. Ich glaube, ich habe mir den Arm gebrochen. → Sanırım kolumu kırdım.

Mein Arm ist gebrochen. (passiv)

Ich habe mir das Handgelenk/den Finger gebrochen.

anbrechen (brach an – hat angebrochen): çatlamak, tam kırılmamak (inkomplet kırık)

Ich habe mir den Arm angebrochen. → Kolum çatladı.

sich den Knöchel brechen. Ich habe mir beim Sturz den Knöchel gebrochen. → Düşerken ayak bileğimi kırdım.

sich etwas auskugeln. → Ich habe mir die Schulter ausgekugelt. → Omzum çıktı.

verrenken (verrenkte, hat sich verrenkt): Bir eklemi zorlayarak yerinden çıkarmak / incitmek

sich etwas ausrenken (hat sich ausgerenkt / ist ausgerenkt): Bir eklem yerinden çıkması / çıkarmak

auskugeln (kugelte aus hat sich ausgekugelt / ist ausgekugelt): Ekleminden çıkmak / çıkarmak (omuz, diz, parmak vb.)

rausspringen(ist rausgesprungen): (Sub-)Luxation

luxieren : Luxation/ tıbbi tanı

Ich habe mir die Schulter ausgekugelt. /// Ich habe mir die Schulter ausgerenkt. Omzum çıktı.

Der Patient hat sich den Ellenbogen ausgerenkt.

Die Schulter ist luxiert.

Der Patient hat sich eine Rippe angebrochen. → Hastanın kaburgası çatladı.

einen Riss bekommen: bağ, tendon, menisküs, kas gibi yumuşak dokularda yırtık-çatlak

☐ Ich habe einen Meniskusriss bekommen. → Menisküsüm yırtıldı.

☐ Der Patient hat einen Bänderriss bekommen. → Hastanın bağları koptu/yırtıldı.

☐ Die Sehne hat einen Riss bekommen. → Tendonda yırtık oluştu.

Bilinç Kaybı

bewusstlos sein. Nach dem Sturz war ich kurz bewusstlos. → Düşükten sonra kısa süreli bayıldım.

Mir war Schwarz vor Augen. (**ohnmächtig, der Bewusstseinsverlust, die Bewusstlosigkeit**)

das Bewusstsein verlieren. Ich habe für einige Minuten das Bewusstsein verloren. → Birkaç dakika bilincimi kaybettim.

Takılı kalmak: stecken bleiben (ist stecken geblieben),

hängen bleiben (ist hängen geblieben)

Mein Fuß ist zwischen zwei Steinen stecken geblieben.

Der Arm ist im Gelände stecken geblieben. (**das Gelände: korkuluk**)

Der Patient ist im Fahrzeug hängen geblieben.

Unfall-Trauma-Orthopädie

allgemeine Beschwerden

-r Unfall/-s Trauma: -e Bewusstlosigkeit/Ohnmächtig -e Synkope I -r Schwindel/-e Vertigo I -r Anlaufschmerz I -e Morgensteifigkeit -s Knirschen im Gelenk/-e Krepitation s Taubheitsgefühl/-e Hypästhesie I -e Missempfindung/-e Parästhesie
-e Lähmung/ -e Parese o. -e Paralyse I -e Bewegungseinschränkung o. -e Funktionsstörung/-e Functio laesa -r Schmerz/-r Dolor -e Schwellung/-r Tumor
-e Rötung/-r Rubor -e Überwärmung/-r Calor
War Ihnen Schwarz vor Augen?

Begriffe

-r Muskel: -r **Musculus**
-e bindegewebige Umhüllung: -e **Faszie**
-e Sehne: -r **Tendo**
-e Sehnenscheide: -e **Vagina synovialis tendinis**
-r Schleimbeutel: -e **Bursa synovialis**
-r Knochen: -s **Os**
-r Knorpel: -e **Cartilago**
-s Gelenk: -e **Articulatio**
-e Bandscheibe: -r **Discus intervertebralis**
-s Band: -s **Ligamentum**

Inspektion:

deformiert I geschwollen I gerötet
-r **Bluterguss-Blauen Flecken/-s Hämatom**
-e Abschürfung-Schürfwunde/-e Exkoriation
-e Hautveränderung/-e Effloreszenz
-e Verletzung/-e Läsion

-e Haltung -e Schonhaltung I -e Gangstörung
-s Gangbild: topallayarak: hinkend / humpelnd
öne eğik/kambur: gebeugt / gekrümmt
-e Beurteilung im Seitenvergleich: symmetrisch/ asymmetrisch

Palpation: **P:** überwärmt
druckschmerzhaft/druckdolent
-r Gelenkerguss/-r Hydrops articularis
-e Sensibilitätsstörung
Pulse: N: tastbar P: nicht tastbar

Bewegungsumfang: **P:** eingeschränkt/limitiert
-r Funktionstest: **N:** neg **P:** positiv

1. Vor einer Stunde bin ich durch den Wald **gejoggt**. Ich wollte **über** einen großen Stein **springen**, bin aber dabei mit dem Fuß **abgerutscht** und **gefallen**. Beim Fallen habe ich mich mit der linken Hand **abgestützt**. Jetzt ist das Handgelenk geschwollen und ich kann die Hand nicht mehr bewegen. (**abstützen:** destek almak, dayanmak **aufstehen=sich erheben**)

2. Als ich heute morgen aus der Wanne **steigen** wollte, bin ich auf dem Badfußboden **ausgerutscht** und auf meine linke Seite **gestürzt**. Ich konnte nicht mehr **aufstehen**, weil ich starke Schmerzen in der Hüfte hatte. Mein Mann hat mich gefunden und den Notarzt gerufen.

3. Vor einer halben Stunde hatte ich einen kleinen Unfall. Ich bin durch den Park **gerannt**, weil ich den Bus erreichen wollte. Dabei bin ich **über** eine Wurzel **gestolpert**, mit dem rechten Fuß **umgeknickt** und **hingefallen**. Jetzt kann ich nicht mehr **auftreten**

!!hingefallen-auf X /// auf varsa fallen ile kullanılır.

sich bücken(gebückt): eğilmek (nach vorne beugen)
buckel: kambur
hocken/hinhocken: çömelmek
der Hocker: tabure
Nesthocker: ailesiyle yaşayan yetişkin
Höcker: deve hörgücü
einschlafen: uyuşmak- Taubheitsgefühl
kämmen: saç taramak
bürsten: fırçalamak die Bürste: fırça
Stindefinger: Mittelfinger
großer Onkel: großen Zeh
Steif: erection
schonen: nicht belasten/korumenak, zorlamamak
Guten Rutch!: iyi seneler (ein deutscher Neujahrsgruß)
das Eis brechen = ortamı yumuşatmak, buzları eritmek
Ein Witz hat das Eis gebrochen.

Das Lasègue-Zeichen: Der Patient **liegt** auf dem Rücken. Das gestreckte Bein wird im Hüftgelenk gebeugt. Das Zeichen ist positiv, wenn bei ca. 45° Flexion **Schmerzen** im Rücken, Gesäß und/oder Bein **auftreten**. Die Schmerzen werden oft durch eine **Entzündung der Nervenwurzel verursacht**. (Dis. Prolapsus)

Das Brudzinski-Zeichen

Der Patient liegt auf dem Rücken und sein **Kopf wird passiv nach vorn gebeugt**. Wenn der Patient dabei seine **Knie anzieht**, ist das Zeichen positiv. Durch diese Bewegung möchte der Patient die **Schmerzen vermeiden**. Der Grund dafür ist häufig in einer **Nervenwurzelreizung** zu finden.

Das Kernig-Zeichen

Der Patient liegt auf dem Rücken und die gestreckten Beine werden im **Hüftgelenk gebeugt**. Das Zeichen für einen Nervendehnungsschmerz ist positiv, wenn der Patient dabei die **Knie beugt**. (Nervendehnungsschmerz: sinir germe ağrısı)

Der Schubladentest

Der Patient liegt auf der Liege und sein Bein wird mit einer 90° Flexion im Knie **aufgestellt**. Wir **legen** die Daumen auf den Tibiakopf und **umfassen** den Unterschenkel mit den Händen. Dann **ziehen** wir die Tibia zu uns **heran** und **drücken** sie **von uns weg**. Erhöhte Verschieblichkeit deutet auf eine **Läsion der Kreuzbänder** hin. (Kreuzbandriss)

Der Neer-Test

Der Patient steht oder sitzt, **strenkt den Arm lang nach vorn aus** und **dreht** ihn so weit wie möglich **nach innen**. Wir **fixieren** mit einer Hand das Schulterblatt und **heben** mit der anderen Hand den Arm des Patienten **an**. Wenn der Patient bei einer Elevation von mehr als 120° **Schmerzen** hat, kann das ein Hinweis auf ein **Impingement-Syndrom** sein.

*Ich habe mir den Daumen im Fenster **geklemmt**. **.einklemmen:sıkışmak**
*Seit dem Unfall kann ich meinen Arm nicht mehr **beugen/strecken**.
*Ich glaube, meine Kniescheibe(patella) ist **rausgesprungen**.
*Ich bin mit dem E-Roller gestürzt. Jetzt kann ich mein linkes Bein nicht mehr **beugen/strecken**.
*Ich bin beim Wandern in ein Loch getreten. (çukura basmak) Jetzt glaube ich, dass mein Fuß **verstaucht** ist. (sich verstauchen)
*Ich habe mir bei der Gartenarbeit irgendwas im Rücken **verrenkt**. (**Wo verrenkt?: im Rücken/ sich verrenken**)
*Ich glaube, am Wochenende habe ich mir beim Fußball einen Muskel **gezerzt**. (sich zerren)
*Ich habe beim Volleyball irgendwie meinen Arm **verdreht**.
*Als ich beim Umzug eine Kiste **heben** wollte, hat es plötzlich im Rücken geknackt.

verdrehen > hareketin mekanizmasıdır, ters dönme, burkulma
verstauchen > hareketin sonucudur, distorsion
incitmek >>>> **verrenken > Gelenk zerren > Muskeln und Band**

Verstauchung(burkulma) ist eine **Verletzung eines Gelenks**, bei der die Bänder durch eine plötzliche Verdrehung oder Umknicken überdehnt oder teilweise verletzt werden, ohne dass das Gelenk ausgerenkt ist.

Eine Quetschung(ezilme) ist eine Verletzung, bei der Weichteile durch starken Druck oder einen stumpfen Schlag zusammengedrückt werden, ohne dass die Haut unbedingt verletzt wird. (Bluterguss als Folge) **die Prellung:Kontusion- Platzwunde**

Eine Zerrung(zorlanma) ist eine Verletzung, bei der Muskeln oder Sehnen durch Überdehnung verletzt werden, ohne dass sie reißen.

1. **Bei einer Luxation** ist ein Knochen aus dem Gelenk gesprungen.
2. **Bei einer Distorsion** ist oft das Gelenk verdreht und die Bänder verletzt. Man sagt auch Verstauchung.
3. **Bei einer Kontusion** sind Körperteile geprellt oder Weichteile gequetscht, z.B. durch einen Schlag oder Aufprall.
4. **Bei einer Distension** ist ein Muskel oder ein Band überdehnt. (überdehnen: extreme Strecken, aşırı germe/zerrung)

Labor:

-s Blut: Hb, Leukos (Pl), Harnsäure, CRP, BSG, **Rheumafaktor, Anti-CCP**(spezifisch für die Rheumatoide Arthritis), **HLA-B27** (Morbus Bechterew / Spondylitis ankylosans (am häufigsten, Reaktive Arthritis, Psoriasis-Arthritis)

Apparative Diagnostik

- s Röntgen I -r Ultraschall/-e Sonografie
- s CT -s MRT
- e Knochendichtemessung/-e Osteodensitometrie
- e Gelenkspiegelung/-e Arthroskopie

Therapie

- **-e PECH-Regel:** -e Pause -s Eis -e Kompression -s Hochlagern
- -s Schmerzmittel (nach dem BtMG: narkotik madde yasası)/-s Analgetikum (NSAR)
- -e Ruhigstellung I -r Gips(verband) I -e Schiene I -e Orthese I -e Bandage
- -e Physiotherapie I -e Krankengymnastik I -e Reha
- -e operativen Verfahren (Pl.), z.B. -e Osteosynthese -s künstliche Gelenk o. -r Gelenkersatz/-e Endoprothese, -e TEP

Anamnesegespräch

Um den Hergang "Schritt für Schritt" zu rekonstruieren

„Können Sie mir das bitte langsam und Schritt für Schritt erzählen?“

„Lassen Sie uns das bitte nochmal gemeinsam durchgehen!“

Wenn du ein Wort nicht kennst!

Entschuldigung, was meinen Sie genau mit „Gerüst?“ „

Können Sie mir kurz erklären, was ein Akkuschrauber ist?“

Vielzahl von Verletzungen: Erst einen Überblick verschaffen, dann priorisieren:

„Können Sie mir sagen, wo Sie überall Schmerzen haben?“ *Sobald du einen Überblick hast, priorisierst du:*

„Wo haben Sie die stärksten Schmerzen?“

Fremdanamnese erfragen

„Können Sie sich selbst daran erinnern, oder hat Ihnen das jemand erzählt?“

„Gab es jemanden, der dabei war und den Unfall gesehen hat?“

„Hat Ihnen vielleicht jemand gesagt, was passiert ist?“

Nur das medizinisch Relevante dokumentieren. Beispiel:

„Herr Franz Zinkel ist ein 39-jähriger Patient, der sich heute infolge eines Arbeitsunfalls bei uns vorstellte. Beim Betreten der Baustelle sei dem Patienten ein Akkuschrauber aus ca. 3m Höhe auf seinen Kopf gefallen. Der Patient berichtete davon, dass er keinen Helm getragen habe. Er gab an, dass er für ca. eine Minute das Bewusstsein verloren habe. Ein Kollege habe ihn daraufhin ins Krankenhaus gebracht.“

Allgemein

Hatten Sie einen Unfall?

Was ist passiert?

Wo genau sind die Beschwerden?

Seit wann haben Sie diese Beschwerden?

Sind die Beschwerden plötzlich aufgetreten?

Können Sie die Schmerzen beschreiben?

Treten die Schmerzen bei einer bestimmten Bewegung auf?

Welche Bewegungen sind schmerzhaft?

Was verbessert oder verschlechtert die Beschwerden?

Hat es geblutet?

Sind Sie auf den Kopf gefallen?

Waren Sie bewusstlos?

Haben Sie Fieber?

Ist Ihnen schwindlig?

Ist das Gelenk geschwollen, gerötet oder überwärmt?

Haben Sie die Beschwerden auch in anderen Gelenken?

Spüren Sie ein Knirschen im Gelenk?

Treiben Sie Sport? Welchen und wie oft?

Gibt es in Ihrer Familie Rheuma, Gicht oder Knochenschwund? **Osteoporose**

Können Sie auftreten bzw. laufen?

Haben Sie Taubheitsgefühle oder Kribbeln?

Haben Sie Kraftverlust bemerkt?

Schmerz-Verhalten

- Bei Schmerzen, Atemnot, etc. ab ~6/10 angemessen
- Es tut mir leid, dass Sie so starke Schmerzen / Atemnot haben.
- Können Sie die Schmerzen gerade (bis zum Ende des Gesprächs) ertragen?
- Haben Sie heute bereits Medikamente (gegen die Schmerzen) eingenommen?
- Falls ja: Welche Medikamente? Wie viel? Welche Dosis? Hat das geholfen?
- Sind bei Ihnen irgendwelche Allergien gegen Medikamente bekannt?
- Dann würde ich Ihnen jetzt gerne einen Zugang legen, um Ihnen das Medikament verabreichen zu können. Ist das in Ordnung für Sie?.

Notfall-Verhalten

- Aufgrund Ihrer Beschwerden würde ich gerne sofort ein paar Untersuchungen veranlassen, damit wir uns schnell ein besseres Bild machen können.
- Insbesondere würde ich gerne sofort ein Ultraschall / Röntgen (...) durchführen. Ist das für Sie in Ordnung?
- Super. Während der Untersuchungen (In der Zwischenzeit werde ich Ihnen weitere Fragen stellen...
- Am Ende: Wir haben ja bereits die Untersuchungen durchgeführt. Wir warten noch auf die Ergebnisse. (Ich werde gleich die Ergebnisse überprüfen.)
- ~~An die Kommission: Liebe Kommission, ich würde das Gespräch jetzt unterbrechen und diese und diese Untersuchung durchführen.~~
- ~~Es könnte sich bei Ihnen um einen Notfall handeln...~~

Trauma-Details / Orthopädie

Unfallhergang / Unfallverlauf / Hergang

- Bitte erzählen Sie mir, was genau passiert ist.
- Wann genau ist das passiert?
- Waren Sie allein?

Unfall-Trauma-Orthopädie

- Gab es eine Fremdeinwirkung?
- Sind Sie alleine hier?
- Können Sie sich an den Unfallhergang erinnern?
- Gibt es andere Personen, die uns mehr Informationen zum Unfallhergang geben könnten?
- Wie sind Sie zu uns gekommen? Wurden Sie von jemandem gebracht? Hat der Krankenwagen Sie abgeholt?
- Wurde die Wunde bereits versorgt? Das heißt zum Beispiel gereinigt, ...? → siehe Wundschmerz
- Waren Sie auf dem Weg zur Arbeit? (aus Versicherungsgründen wichtig)
- Welche Körperteile haben Sie verletzt?
- Können Sie Ihre Körperteile (Arme, Beine, Hände, Kopf) ohne Probleme bewegen? → siehe Bewegungen
- Können Sie gut atmen?
- Auf welche Seite sind Sie gestürzt?
- Wie schnell waren Sie unterwegs?
- Waren Sie in dem Auto, das den Unfall hatte oder waren Sie außerhalb?
- Gibt es eine aktive Blutung?
- Gibt es eine offene Wunde?
- Kennen Sie Ihre Blutgruppe?
- Haben Sie ein Knacken oder einen Knall gehört?
- Haben Sie Ihren Kopf verletzt?
- Haben Sie (sich) Ihren Kopf angeschlagen / gestoßen?
- Woran haben Sie Ihren Kopf gestoßen? War es ein spitzer oder dumpfer Aufprall? → siehe Neurologische Beschwerden
- Haben Sie einen Helm getragen? Ist der Helm beschädigt?
- Haben Sie Ihr Bewusstsein verloren? Wenn ja: Wie lange?
- Standen Sie während des Unfalls unter dem Einfluss von Drogen / Alkohol?
- Waren Sie zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert?

Orientierung

- Könnten Sie mir Ihren Namen sagen?
 - Wissen Sie, welchen Tag wir heute haben?
 - Wissen Sie, wo Sie gerade sind?
- Der Patient war zu Person, Zeit und Ort orientiert.

• **Der Rücken** (Rückenschmerzen), disk hernisi (Bandscheibenvorfall), lumbago (Hexenschuss)

Seit wann haben Sie die Beschwerden schon?
Sind die Schmerzen nach einer bestimmten Bewegung aufgetreten?
Können Sie laufen, sitzen und liegen?
Haben Sie etwas Schweres gehoben?
Müssen Sie bei der Arbeit schwer heben oder sich häufig bücken?
Strahlen die Schmerzen aus, zum Beispiel ins Bein?
Spüren Sie ein Kribbeln? Haben Sie Taubheitsgefühle?
Haben Sie Morgensteifigkeit? Wenn ja, wie lange dauert sie an?
Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen?
Treiben Sie regelmäßig Sport?
Sitzen Sie normalerweise viel?

• **Die Hüfte:** Hüftschmerzen, Koxarthrose (Hüftarthrose), Schenkelhalsfraktur, Bursitis trochanterica

Haben Sie Schmerzen in der Leiste?
Verschlimmern sich die Beschwerden, wenn Sie Treppen runterlaufen?
Haben Sie Anlaufschmerzen, zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen oder nach längerem Sitzen?
Strahlen die Schmerzen aus, zum Beispiel in den Oberschenkeln oder ins Knie?
Schmerzt die Hüfte auch in Ruhe?
Fühlen Sie sich bei Ihren täglichen Aktivitäten eingeschränkt?
Seit wann haben Sie die Beschwerden schon?
Können Sie laufen, sitzen und liegen?
Können Sie auf dem betroffenen Bein stehen?
Können Sie das Bein abspreizen?
Können Sie das Bein in der Hüfte beugen und strecken?
Humpeln Sie beim Gehen?
Hatten Sie einen Unfall oder sind Sie gestürzt?
Sind Sie auf die Hüfte gefallen?
Haben Sie Fieber oder ist die Hüfte geschwollen oder gerötet?
Hatten Sie früher schon einmal Beschwerden an dieser Hüfte?

• **Die Schulter:** Schulterschmerzen, Rotatorenmanschettenruptur, Impingement-Syndrom, Frozen Shoulder

Können Sie etwas tragen, zum Beispiel eine Einkaufstasche?
Wie lange bestehen die Beschwerden schon?
Seit wann haben Sie die Beschwerden?
Spielen Sie oft Basketball, Volleyball oder Tennis?
Treiben Sie regelmäßig Sport?
Haben Sie Probleme beim An- oder Ausziehen?
Können Sie den Arm ohne Schmerzen heben?
Treten die Beschwerden nur bei Bewegung auf?

Unfall-Trauma-Orthopädie

Hatten Sie einen Unfall?

Strahlen die Schmerzen in den Oberarm oder bis in die Hand aus?

Können Sie auf der betroffenen Schulter liegen?

Sind die Schmerzen nachts stärker?

(Spricht für Impingement-Syndrom, Rotatorenmanschettenruptur und Rheumatoide Arthritis)

Haben Sie Kraftverlust im Arm bemerkt?

Ist die Schulter schon einmal ausgekugelt?

Können Sie den Arm über den Kopf heben?

Bewegungen

• Allgemein

- Haben Sie Schmerzen, wenn Sie Ihren Arm (...) bewegen?

• Hand

- Können Sie die Hand zu einer Faust machen?
- Können Sie eine Faust machen?
- Können Sie die Hand schließen?
- Können Sie die Hand öffnen?
- Können Sie die Hand nach oben und unten drehen? (Handfläche, Handrücken)

• Finger

- Können Sie Ihre Finger spreizen?
- Welcher Finger tut Ihnen weh?
- der Daumen → der Zeigefinger → der Mittelfinger → der Ringfinger → der kleine Finger

• Arm

- Können Sie den Arm (aus)strecken?
- Können Sie den Arm nach vorne (zur Seite) ausstrecken?
- Können Sie den Arm beugen?
- Können Sie den Arm (an)heben?
- Können Sie den Arm anlegen?
- Können Sie den Arm kreisen?

• Hals / Nacken / Kopf

- Achtung: Bei Verdacht auf Verletzungen der HWS bitte nicht danach fragen!
- Können Sie Ihren Kopf nach vorne beugen? (sich verneigen)
- Können Sie Ihren Kopf nach hinten strecken?
- Können Sie Ihren Kopf in den Nacken legen?
- Können Sie Ihren Kopf nach links / nach rechts drehen?
- Können Sie Ihren Kopf auf die rechte / linke Seite legen?

• Oberkörper

- Können Sie Ihren Oberkörper nach vorne beugen?
- Können Sie Ihren Oberkörper nach hinten strecken?
- Können Sie Ihren Oberkörper zur Seite drehen?
- Können Sie Ihren Oberkörper auf die rechte / linke Seite legen? (nach rechts/links kippen)
- Haben Sie Schmerzen beim tief Luft holen?
- Haben Sie Schmerzen beim Ein- oder Ausatmen?

• Beine

- Können Sie Ihre Beine spreizen?
- Können Sie Ihre Beine strecken?
- Können Sie Ihre Beine anwinkeln / beugen?
- Können Sie Ihre Beine anheben?
- Können Sie problemlos **in die Hocke gehen?** (çömelmek, eine Kniebeuge machen)
- Können Sie auf einem Bein stehen?

• Fuß

- Können Sie Ihr Sprunggelenk bewegen?
- Können Sie auf den Zehenspitzen stehen?
- Können Sie auf den Fersen stehen?
- Können Sie auf Ihren Fußkanten stehen?
- Können Sie Ihre Zehen spreizen / bewegen?
- Haben Sie Schmerzen beim Auftreten?

→ Die Schmerzen treten beim Auftreten auf.

Fortbewegungsmittel

- Auto • Bus • Straßenbahn, Tram • Zug, S-Bahn, U-Bahn • LKW, Lastwagen • Flugzeug • Fahrrad • Motorrad
- Roller • Was für ein Roller war das? • City-Roller / Tretroller • E-Roller / E-Scooter • Motorroller, Mofa
- Skateboard • Rollschuhe • Inliner / Inline-Skates • Schlittschuhe

Unfall-Trauma-Orthopädie

Sichere Frakturzeichen (Klein kırık bulguları)

1. Sichtbare Fehlstellung / Achsababweichung

Der Knochen weist einen unnatürlichen Knick oder eine Deformität auf. :Kemikte gözle görölür şekil bozukluğu veya eksen kayması vardır.

2. Abnorme Beweglichkeit

Der Knochen lässt sich an einer Stelle bewegen, an der sich normalerweise kein Gelenk befindet. :Normalde eklem olmayan bir yerde anormal hareketlilik vardır.

3. Sichtbare Knochenfragmente

Bei einer offenen Fraktur ragen Knochenstücke aus der Wunde heraus. :Açık kırıkta kemik parçaları yara dışına çıkar.

4. Krepitation

Ein hör- oder fühlbares Reiben, wenn die Knochenenden aneinanderreiben. :Kemik uçlarının birbirine sürtünmesi sonucu hissedilen veya duyulan çıtırtı sesi.

5. Bildgebender Nachweis

Der zweifelsfreie Nachweis einer Fraktur im Röntgenbild oder CT. :Röntgen veya BT'de kırığın kesin olarak gösterilmesi.

Unsichere Frakturzeichen (Şüpheli kırık bulguları)

- Schmerzen (ağrı)
- Schwellung (şişlik)
- Hämatom (morarma)
- Funktionseinschränkung / Bewegungsunfähigkeit (hareket kısıtlılığı)
- Druckschmerz (basmakla ağrı)

„Zu den sicheren Frakturzeichen gehören die sichtbare Fehlstellung, die abnorme Beweglichkeit, sichtbare Knochenfragmente bei offener Fraktur, die Krepitation sowie der radiologische Nachweis im Röntgen oder CT. Unsichere Frakturzeichen sind Schmerzen, Schwellung, Hämatom und Funktionseinschränkung.“

Verletzungen/ Erkrankungen	• -e Prellung o. -e Quetschung/ -e Kontusion • -e Zerrung o. -e Überdehnung/ -e Distension • -e Verstauchung/-e Distorsion	• -s Auskugeln o. -e Verrenkung/ -e Luxation • -r Riss/-e Ruptur • -r Bruch/-e Fraktur
	• -e Gehirnerschütterung/-e Commotio Cerebri -s Schädel-Hirn-Trauma (-s SHT) -e Gehirnprellung/-e Contusio cerebri • -r Hexenschuss/-e Lumbago -e (Lumbo)Ischialgie -e Bandscheibenvorwölbung/-e Discusprotrusion -r Bandscheibenvorfall/-r Discusprolaps • -e Sehnenentzündung/-e Tendinitis -e Sehnenscheidenentzündung/ -e Tendovaginitis -e Schleimbeutelentzündung/-e Bursitis -e Gelenkinnenhautentzündung/-e Synovitis • -s Impingement-Syndrom -r Golferellenbogen/-e Epicondylitis humeri ulnaris -r Tennisellenbogen/-e Epicondylitis humeri radialis • -s Karpaltunnel-Syndrom (-s KTS) • -r Bänderriss/-e Bandruptur -r Muskelfaserriss/-s Muskelfaserruptur • -e Bakerzyste • -s Umknicktrauma/-s Supinationstrauma bzw. -s Pronationstrauma • -r Gelenkverschleiß/-e Arthrose -e Gelenkentzündung/-e Arthritis, • -r Knochenschwund/-e Osteoporose -s Rheuma/-e rheumatoide Arthritis • -e Gicht/-e Arthritis urica -r akute Gichtanfall im Großzehengrundgelenk/ -e Podagra • -r Morbus Bechterew o. -e Spondylitis ankylosans -r Morbus Scheuermann o. -e Osteochondritis deformans juvenilis dorsi -r Morbus Schlatter o. -e Osteochondrose	
Differenzialdiagnosen	• siehe Verletzungen/Erkrankungen • bei Grunderkrankungen, z.B. -r Lupus erythematoses -e Sklerodermie -e Vaskulitis -e Tumoren (Pl.)	